Perfil V3 · código por código

Psiquiatría

Los 60 códigos del Perfil de Conocimientos EUNACOM v3 (2026) de Psiquiatría, uno por uno: el nivel que exige el examen, dónde se enseña en nuestros libros, lo que hay que saber en resumen y una pregunta.

Niveles del Perfil — Diagnóstico: **Sospecha** (reconocer y derivar) o **Específico** (confirmar). Tratamiento: **Inicial** (estabilizar y derivar) o **Completo**. Seguimiento: **Derivar**, **Completo** o **No requiere**.

Situaciones clínicas 36 códigos

5.01.1.001 Trastorno de pánico con o sin agorafobia

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- Crisis de pánico: inicio brusco con pico en <10 minutos y ≥4 de 13 síntomas (palpitaciones, disnea, dolor torácico, sudor, temblor, parestesias, mareo, desrealización, miedo a morir o perder el control).
- Trastorno de pánico: crisis recurrentes e imprevistas más ≥1 mes de miedo a nuevas crisis o cambio de conducta; agorafobia (miedo a no poder escapar en ≥2 situaciones) es su complicación frecuente.
- Primer episodio: descartar lo somático con ECG, glicemia capilar, saturación y TSH (y troponinas o tóxicos según clínica): SCA, TEP, arritmias, hipertiroidismo, feocromocitoma, cocaína.
- Crisis aguda: contención verbal y respiración diafragmática lenta; si no cede, lorazepam 1–2 mg sublingual (o clonazepam 0,5–1 mg). No respirar en bolsa.
- Tratamiento de fondo: ISRS partiendo con media dosis (sertralina 25 mg por 7 días y luego 50 mg; o escitalopram) más TCC con exposición; benzodiacepina solo como puente 2–4 semanas con retiro gradual.
- Seguimiento completo: controles para titular, vigilar ansiedad inicial por ISRS y mantener el tratamiento 6–12 meses tras la remisión; evitar benzodiacepina en monoterapia crónica.

PREGUNTAS (17)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 66

Una paciente presenta múltiples episodios de 5 minutos de duración, recurrentes, en los que presenta mucha angustia, llanto, sensación de ahogo, parestesias en las cuatro extremidades y marcado miedo a sufrir un infarto al corazón. Ya no sale de la casa por miedo a presentar uno de esos episodios en la calle. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de pánico
B) Agorafobia
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Crisis de pánico

Respuesta A. Crisis de pánico recurrentes e inexplicadas: trastorno de pánico. Que ya no salga de su casa sugiere además agorafobia, pero predomina el diagnóstico de trastorno de pánico. "Crisis de pánico" es solo el episodio, no el trastorno.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 113

Una paciente de 36 años, sin antecedentes, consulta porque desde hace tres meses ha presentado varios episodios caracterizados por taquicardia, sudoración, dificultad para respirar, náuseas y sensación de muerte que tienen una duración de 30 minutos máximo y que ceden espontáneamente, por lo cual está muy preocupada, ya que dos de ellos le ocurrieron cuando se encontraba en una cafetería. Refiere que hace tres meses su pareja le pidió el divorcio en un restaurant, tras lo cual, intenta no salir de su hogar por miedo a que algo le ocurra y nadie la ayude. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno por ansiedad social
B) Trastorno adaptativo
C) Trastorno por estrés post traumático
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad

Respuesta E. Tiene un trastorno de pánico (ansiedad o angustia) con agorafobia. Se prefiere el diagnóstico de trastorno de pánico por ser más completo; la agorafobia es en este caso una consecuencia, y el pánico se clasifica con o sin agorafobia.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 67

Una paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta en urgencias por cuadro de inicio brusco caracterizado por sensación de falta de aire, dolor en hemitórax izquierdo, mareos, sudoración y adormecimiento de manos, de 30 minutos de duración. Al examen físico presenta frecuencia cardiaca 120 por minuto, presión arterial 140/90, cardiopulmonar normal. Se solicita electrocardiograma que muestra ritmo sinusal, QRS angosto, sin signos de isquemia. El fármaco de elección para el manejo en este caso es: **El fármaco de elección para el manejo en este caso es:**

A) Haloperidol
B) Diazepam
C) Lorazepam
D) Fenitoína
E) Clonazepam

Respuesta C. Crisis de pánico con electrocardiograma normal. El fármaco de rescate de elección es lorazepam sublingual, de vida media más corta que diazepam y clonazepam.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 12

Una paciente de 28 años presenta un episodio de rápida instalación de marcada angustia y variados síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y miedo a morir. En las últimas 4 semanas ha presentado varios episodios similares, por lo que teme salir de su casa. Su examen físico es normal y los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?**

A) Amitriptilina 25 mg/día
B) Sertralina 50 mg/día
C) Risperidona 3 mg/día
D) Clonazepam 2 mg/día
E) Clorpromazina 300 mg/día

Respuesta B. Crisis de pánico recurrentes: trastorno de pánico, probablemente con agorafobia. El tratamiento principal es un ISRS. Las benzodiacepinas sirven como tratamiento sintomático, pero el ISRS es la base.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 103

Una paciente de 31 años, embarazada de 3 meses, presenta angustia y temor, que aparece al estar en presencia de aglomeraciones de personas, especialmente en la calle, sintiéndose atrapada y ahogada en esas situaciones. Refiere síntomas similares al ir al supermercado y al tener que cruzar puentes muy largos, por lo que evita exponerse a esto y ha salido menos de su casa. ¿Cuál es el tratamiento de elección? **¿Cuál es el tratamiento de elección?**

A) Diazepam
B) Citalopram
C) Clorpromazina
D) Risperidona
E) Mirtazapina

Respuesta B. Es una agorafobia, que se trata con ISRS como los demás trastornos ansiosos crónicos. Las benzodiacepinas se intentan evitar en el embarazo.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 45 años, hace 6 semanas mientras compraba, presenta un episodio de opresión en el pecho, disnea, vértigo, temor a morir, palpitaciones, disfagia, sensación de lipotimia, visión borrosa y disestesias de las extremidades superiores, asociado a marcada angustia. Desde entonces ha presentado un episodio de similares características cada semana. No tiene otros síntomas y su examen físico es normal, al igual que sus exámenes generales de laboratorio. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el largo plazo?

A) Inhibidores de la monoaminoxidasa
B) Benzodiacepinas
C) Antipsicóticos atípicos
D) Antidepresivos tricíclicos
E) Inhibidores de la recaptura de serotonina

Respuesta E. Tuvo una crisis de pánico y, por recurrir, ahora tiene un trastorno de pánico (o de angustia o de ansiedad), que se trata con IRS (se pueden agregar BDZ, ejemplo alprazolam c/8 horas al inicio y luego SOS, pero solo como tratamiento sintomático). No confundir con trastorno de ansiedad generalizada, aunque el tratamiento es el mismo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 103 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente presenta sensación de opresión precordial intensa, asociada a disnea, vértigo y dificultad para ver, que sucede de manera episódica, con varias recurrencias en el último tiempo. Está muy preocupada y además tiene mucho miedo a morir de un infarto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad social
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Agorafobia
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno conversivo

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno de pánico (opción D). Por las crisis de pánico reiteradas, es un trastorno de pánico clásico.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en e

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, sin antecedentes, consulta muy preocupada porque desde hace un mes ha presentado en cuatro oportunidades cuadros de inicio agudo caracterizados por dolor torácico intenso, asociados a cefalea, mareos, parestesias y disnea, los cuales tienen una duración aproximada de una hora y ceden espontáneamente. Al preguntarle de forma dirigida, desconoce que puede desencadenar estas crisis. Trae electrocardiograma que le habrían tomado en el servicio de urgencias cuando consultó por una crisis el cual se aprecia normal. Los fármacos de elección para el tratamiento de esta paciente son:

A) Fluoxetina y carbamazepina
B) Amitriptilina y clonazepam
C) Citalopram y risperidona
D) Sertralina y diazepam
E) Paroxetina y lamotrigina

Respuesta D. Hay que darle un ISRS y al inicio una BDZ. La única opción que cumple con eso es la D. Los anticnovulsivantes y antipsicóticos no están indicados en el T. de angustia. Lo ideal sería empezar con fluoxetina 10 mg al día más alprazolam (no diazepam) 0,5 mg cada 8-12 horas y terminar con fluoxetina 20 mg al día, sin BDZ en un par de semanas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años presenta episodios súbitos de marcada angustia, con miedo a morir y síntomas como disnea con “imposibilidad de sacar el aire”, vértigo, parestesias en las extremidades, imposibilidad de tragar, opresión en el pecho, náuseas, visión borrosa y sensaciones eléctricas en el cuerpo, en los que siente la necesidad de salir corriendo para su caasa. Ha presentado 5 episodios en las últimas 4 semanas y está muy preocupada por lo que le está pasando. Los exámenes generales descartan patología orgánica. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para esta paciente?

A) Amitriptilina 150 mg
B) Sertralina 50 mg
C) Risperidona 3 mg
D) Clonazepam 6 mg
E) Clorpromazina 300

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Sertralina 50 mg (opción B). Tiene un trastorno de pánico clásico, que se trata con antidepresivos IRS, como la sertralina.. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 133 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con trastorno de pánico. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Sertralina 50 mg/día
B) Alprazolam 0,5 mg cada 8 horas
C) Litio 300 mg cada 12 horas
D) Haloperidol 5 mg/día
E) Valproato 500 mg/día

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Sertralina 50 mg/día (opción A). Sertralina 50 mg/día. El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 24 años presenta un cuadro de opresión precordial, disnea, parestesias en extremidades siperiores, palpitaciones y mucha ansiedad y miedo. Los síntomas se instalan en pocos minutos. ¿Cuál es el mejor medicamento para el manejo de esta crisis?

A) Diazepam
B) Fluoxetina
C) Lorazepam
D) Haloperidol
E) Clorpromazina

Respuesta C. La crisis de pánico se trata con benzodiacepinas de acción rápida y corta (elección: lorazepam sublingual). Los antidepresivos IRS sirven para el trastorno de pánico (prevenir las crisis), no para la crisis de pánico mismo.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 134 · texto original del banco, sin revisar

Paciente que refiere episodios de 'músculos que no responden', palpitaciones y sensación de muerte inminente. Hombre trabajador angustiado. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Arritmia cardíaca paroxística
C) Epilepsia parcial compleja
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno de somatización

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno de pánico (opción D). Trastorno de pánico. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clíni

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años se siente atrapada en lugares como estacionamientos, au- topistas, los lugares al aire libre y los lugares cerrados, como ascensores. Por esto, ha dejado de salir de su casa. Además tiene cuadros de angustia episódica, con marcado miedo a perder el control. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Agorafobia
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de angustia
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Fobia específica

Respuesta A. A, C? También me parece una agorafobia por el miedo en relación a los lugares descritos (yo marqué A). Sin embargo, también puede ser un trastorno de angustia con

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 157 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 21 años presenta un episodio de rápida instalación, en 5 minutos, de marcada angustia, llanto, disnea y sensación de opresión precordial, más vértigo, imposibilidad de tragar, temblor y mucho miedo a morir. ¿Cuál es el tratamiento de esta crisis?

A) Risperidona
B) Carbamazepina
C) Clorpromazina
D) Fluoxetina
E) Lorazepam

Respuesta E. Tiene una crisis de pánico, es decir solo un síntoma. Se pregunta el tratamiento de la crisis, que es con benzodiacepinas de rápida acción (lorazepam, clonazepam e incluso alprazolam, aunque el lorazepam es el más usado), generalmente por una vía de rápida absorción (sublingual, EV o IM). No se debe confundir la crisis de pánico con el trastorno de pánico, que tiene múltiples crisis de pánico, sin

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 133 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente presenta mucha angustia ante ciertas situaciones como lugares con muchedumbre, los malls, los ascensores con mucha gente, los espacios desolados y otros, ya que presenta miedo a sufrir un colapso y que nadie la ayude. Como antecedente, cuando niña lloraba por largas horas cuando iba al colegio y su mamá la dejaba. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de ansiedad de separación del adulto
C) Trastorno de ansiedad social
D) Agorafobia
E) Trastorno de angustia generalizada

Respuesta D. Diagnóstico: Agorafobia (opción D). Es una agorafobia clásica.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 100 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 13 años ha presentado diez episodios de angustia muy intensa, asociadas a sensación de muerte, disnea, vértigo, ganas de ir corriendo a su casa, temor a estar volviéndose loca y llanto descontrolado, todo lo que ha afectado seriamente su calidad de vida. Además. Sus padres han debido ir a buscarla en 3 oportunidades al colegio en las últimas dos semanas, debido a estos síntomas. No presenta síntomas depresivos, aunque su autoestima se ha visto mermada por la situación. Su examen físico es normal ¿Cuál es el tratamiento más importante para esta paciente?

A) Sertralina
B) Quetiapina
C) Ácido valproico
D) Alprazolam
E) Diazepam

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Alprazolam (opción D). El metilfenidato, anfetaminas y modafinilo son los fármacos de apoyo en el TDA, pero el tratamiento principal es multidisciplinario. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 152 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 22 años presenta ansiedad persistente, relacionada a abandonar la cosa sola, por miedo a que le pase algo, sin recibir ayuda de sus familiares, lo que se ha agravado en el último tiempo. Por esto abandonó sus estudios hace un mes y en ge- neral ha visto seriamente afectada su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Fobia social
B) Trastorno de angustia generalizada
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Trastorno de angustia
E) Agorafobia

Respuesta E. Diagnóstico: Agorafobia (opción E). Es una agorafobia clásica: miedo a no recibir ayuda.. El Trastorno por Déficit Atencional (TDA) es una condición neurodiversa de causa genética que se caracteriza principalmente por la dificultad para mantener el foco atencional, con cambios frecuentes entre estímulos que dificultan el rendimiento escolar. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactament

5.01.1.002 Trastorno obsesivo compulsivo

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.8 Trastorno Obsesivo-Compulsivo (TOC): Obsesiones, Compulsiones e ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- TOC: obsesiones (pensamientos o imágenes intrusivas: contaminación, duda, orden, daño, tabú) y compulsiones (lavar, revisar, contar, rezar, evitar) que consumen >1 hora al día o causan deterioro.
- Es egodistónico: el paciente sabe que es absurdo y sufre; la 'voz interior' no es alucinación. Obsesiones de dañar a un hijo o de ser pedófilo con angustia y evitación son TOC, no psicosis ni parafilia.
- Diferenciar del trastorno de personalidad obsesivo-compulsiva (egosintónico, perfeccionismo, sin obsesiones ni rituales); evaluar riesgo suicida y depresión comórbida.
- Tratamiento inicial: ISRS en dosis altas (sertralina desde 50 mg, titulando a 150–200 mg; fluoxetina hasta 60–80 mg), explicando latencia de 8–12 semanas, más TCC con exposición y prevención de respuesta.

- No usar benzodiacepinas crónicas ni antipsicóticos en monoterapia; no reforzar el ritual ni tranquilizar repetidamente.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría en casos moderados a severos o sin respuesta (clomipramina o potenciación).

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 155

Una paciente de 55 años, se lava las manos recurrentemente porque siente que se encuentran sucias, el hecho de no hacerlo rápidamente le provoca gran angustia. Esto le ha provocado dermatitis en sus manos, por lo cual está preocupada. Sabe que esta conducta no tiene sentido, pero no puede evitarlo. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de ansiedad
B) Ansiedad específica
C) Trastorno dismórfico corporal
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta E. Obsesión de contaminación y compulsión de lavado, que la paciente reconoce sin sentido pero no puede evitar (egodistónica), con consecuencias en la piel: trastorno obsesivo compulsivo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 13

Un paciente de 32 años se lava las manos repetidamente durante el día. Al examen está lúcido, cooperador, pero angustiado. Refiere que una voz interior le ordena lavarse las manos y no puede desobedecerle. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento? **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Litio
B) Fluoxetina
C) Olanzapina
D) Carbamazepina
E) Alprazolam

Respuesta B. Es un TOC, que se trata con antidepresivos ISRS. La «voz interior» no es una alucinación mientras el paciente no la escuche directamente ni la considere algo ajeno o externo a él.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 15

Un hombre de 34 años, que fue padre hace 2 meses, presenta imágenes recurrentes y desagradables, en las que él se ve asfixiando a su bebé con una almohada. Se siente muy angustiado y evita el contacto con su hijo, por miedo a hacerle daño. No ha querido contarle a su cónyuge, ya que se siente avergonzado y cree que se puede estar volviendo loco. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Depresión psicótica
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno delirante

Respuesta D. Es un TOC clásico, con obsesión de acción negativa y compulsión de evitación. Otras obsesiones preguntadas han sido ser pedófilo, ser infiel o agredir a personas en la calle.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 73

Un paciente de 36 años presenta la idea de que puede ser pedófilo. Aquello lo angustia mucho y le aterra la idea de acercarse a los niños. Por ello reza y evita situaciones en las que estará en contacto con niños. Su diagnóstico es: **Su diagnóstico es:**

A) Trastorno delirante
B) Parafilia
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno de la inclinación sexual
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta C. Es un TOC clásico con obsesión de conducta inmoral y compulsión de evitación y de rezar.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 11

Una paciente de 32 años presenta imágenes recurrentes, en que se ve a sí misma cortando a su hijo de 12 meses, con un cuchillo. Aquello le genera mucha angustia y miedo de dañar a su hijo. Por ello, nunca se queda a solas con el niño y sacó todos los cuchillos de los cajones de la casa. Está muy angustiada y triste, porque no quiere que le pase nada malo a su hijo y teme tener problemas con sus familiares o perder la tuición del niño, por lo que no le ha contado su problema a nadie. Ha pensado incluso en morir, con tal de proteger a su familia. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno bipolar
B) Episodio psicótico
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno depresivo mayor
E) Trastorno de adaptación

Respuesta C. Es un TOC clásico, con obsesión de causar daño y compulsión evitativa.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 87 · texto original del banco, sin revisar

Hombre de 32 años que tuvo leucemia linfoblástica en la infancia. Curado. Ahora consulta por lavado de manos compulsivo más de 30 veces al día, incapacitante, relacionado con miedo a contaminarse. Reconoce que es excesivo pero no puede parar. ¿Cuál es el diagnóstico?

A) Trastorno obsesivo compulsivo (TOC)
B) Fobia específica a gérmenes
C) Hipocondría
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) TEPT por su historia oncológica

Respuesta A. Compulsiones (lavado de manos) repetitivas + egodistónicas (reconoce que es excesivo) + incapacitantes = TOC. La compulsión de limpieza es la más frecuente en TOC.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 127 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 32 años consulta por la idea recurrente de que debe limpiar sus utensilios de alimentación para evitar adquirir una infección intestinal. Refiere que se cepilla los dientes durante 15 minutos y luego se enjuaga la boca por 10 minutos más. Reconoce que a veces quiere dejar de hacerlo, pero no puede evitarlo. Como antecedente, sufrió de leucemia aguda a los 7 años, siendo manejado con quimioterapia y logrando la curación de la enfermedad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Manía aguda
B) Trastorno por descontrol de impulsos
C) Trastorno de personalidad
D) Esquizofrenia
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta E. Trastorno Obsesivo-Compulsivo: El cuadro clínico describe un trastorno obsesivo-compulsivo clásico, con obsesión por la contaminación y compulsión por la limpieza.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 68 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente consulta muy angustiado, porque cree ser pedófilo. Le aterra acercarse a los niños y no sabe qué hacer, a pesar de que sabe que su idea es rara. Refiere que reza para no serlo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante cónico
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno psicótico agudo
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Parafilia

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno obsesivo compulsivo (opción D). Tiene la obsesión (idea que produce angustia) y la compulsión (reza y evita los niños). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Hombre piensa que puede ser pedofilo, le perturba el pensamiento recurrente asi q cuando lo piensa repite una frase: (repetida años anteriores) a. TOC

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno de ansiedad generalizada). La hipertrofia de adenoides es un tema relevante tanto en pediatría como en otorrinolaringología. Esta decisión se fundamenta en la evidencia clínica y normativas ministeriales de Chile (MINSAL/GES).

5.01.1.003 Trastornos fóbicos (fobia social y fobia específica)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- Fobia social: miedo intenso al escrutinio y juicio de otros (hablar, comer o actuar en público) con rubor, temblor o sudor y evitación que deteriora; el paciente desea relacionarse pero teme la humillación.
- Subtipo de actuación: solo hablar o actuar en público (expositores, músicos, estudiantes).
- Fobia específica: miedo desproporcionado a un estímulo concreto (volar, alturas, animales, sangre) con evitación; tratamiento de elección TCC con exposición gradual.
- Diferenciar de timidez normal (sin deterioro), personalidad esquizoide (no desea relacionarse), evitativa y agorafobia (miedo a no poder escapar).
- Tratamiento inicial: fobia social generalizada, ISRS (escitalopram, sertralina) más TCC; de actuación, propranolol 10–40 mg 30–60 minutos antes del evento. Sin benzodiacepinas de mantención.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada si no responde o hay comorbilidad (depresión, consumo de alcohol).

PREGUNTAS (9)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 89

Paciente de 28 años con miedo intenso y síntomas físicos ante situaciones de hablar en público o comer frente a otros. Evita reuniones sociales y ha rechazado ascensos laborales por esto. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea? **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de primera línea?**

A) Escitalopram (ISRS)
B) Propranolol a demanda
C) Alprazolam a diario
D) Haloperidol
E) Carbamazepina

Respuesta A. Fobia social o trastorno de ansiedad social: el tratamiento farmacológico de primera línea son los ISRS (sertralina, escitalopram, paroxetina), combinados con TCC. El propranolol es para situaciones puntuales.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 123

Un hombre de 21 años experimenta dificultades para realizar presentaciones en público, que han afectado su rendimiento académico. Además, refiere enrojecimiento facial y torpeza en situaciones sociales. Recientemente no pudo terminar una presentación oral frente a su curso, ya que refiere que su mente se quedó en blanco en un momento. Todo esto le ha generado angustia y tristeza. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Fobia específica
B) Agorafobia
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Trastorno de personalidad evitativa

Respuesta D. El cuadro describe una fobia social, también llamada trastorno de ansiedad social.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 106

Un paciente de 21 años no sale de su casa por miedo a encontrarse con alguien que conozca y que le haga preguntas sobre su vida. Incluso desconecta el teléfono, para evitar que sus familiares lo llamen y le hagan preguntas. Se siente muy incómodo por lo que pudieran pensar de él las demás personas. Desde el colegio era muy tímido, pero esto empeoró al entrar a estudiar sus estudios superiores y actualmente afecta significativamente su vida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Depresión psicótica
B) Trastorno de ansiedad social
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta B. Es una fobia social generalizada y bastante grave: evita a los demás por lo que puedan pensar de él, y la timidez previa empeoró hasta afectar significativamente su vida.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 44

Paciente masculino de 27 años de edad , quien presenta desde hace 1 año temor a volar, por lo que prefiere desplazarse por tierra siempre. Incluso ha dejado de asistir a congresos y visitar a familiares en el extranjero. Siente mucha angustia y palpitaciones, cada vez que sabe que debe tomar un avión, desde los días antes y en dos oportunidades, previo a los vuelos, ha tomado benzodiacepinas con respuesta parcial. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Fobia específica
C) Agorafobia
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno por ansiedad de separación

Respuesta B. Es una aerofobia, que es la fobia específica a volar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 34 años se siente muy ansiosa al realizar actividades como hacer presentaciones o hablar en reuniones de trabajo. Por ello evita ese tipo de situaciones y asigna dichas tareas a sus subalternos, sobrecargándolos. Incluso dejó de asistir a un congreso de ejecutivos, en el que tendría que exponer. El diagnóstico más probable es:

A) Fobia social
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de personalidad antisocial
D) Trastorno de personalidad evitativo
E) Trastorno de pánico

Respuesta A. Diagnóstico: Fobia social (opción A). Es una fobia social clásica: ansiedad al realizar actividades en público y evitación de las mismas.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 82 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 20 años presenta mucha ansiedad ante las situaciones en que debe hacer exposiciones o presentaciones ante los demás. Presenta sudoración y palpitaciones antes de las presentaciones, con opresión cordial y disnea y esta dispuesta incluso a aumentar su carga de trabajo, con tal de evitar ese tipo de situaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno de personalidad evitativo
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Trastorno de angustia
E) Trastorno de ansiedad social

Respuesta E. La opción correcta es la E (Trastorno de ansiedad social). En este escenario clínico, trastorno de ansiedad social se encuentra estrictamente contraindicado debido a que su mecanismo de acción interfiere negativamente con la fisiopatología basal del paciente, aumentando la morbimortalidad según los protocolos clínicos vigentes.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 9 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 24 años, estudiante de derecho, debe rendir su examen oral final para obtener su título profesional, ha estudiado por varios meses y tiene buen dominio de los temas, pero a pesar de que se ha preparado, no ha querido presentar aún el examen, ya que según él “no puedo hacerlo”. Refiere que le ha pasado lo mismo en situaciones similares donde le ha tocado exponer presentando gran nerviosismo. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de pánico
B) Trastorno de la personalidad evitativo
C) Ansiedad social
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Agorafobia

Respuesta C. Diagnóstico: Ansiedad social (opción C). Es una fobia social de libro.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 35 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 20 años, universitaria, tiene escasa interacción con sus compañeros, porque la inhibe el juicio que ellos puedan tener sobre su desempeño. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de personalidad esquizoide
B) Trastorno de ansiedad
C) Fobia social
D) Trastorno del espectro autista
E) Esquizofrenia

Respuesta C. Parecía que además tenía un T. de personalidad evitativo, pero en esta pregunta no estaba en las opciones. Además, que la ansiedad la genere el juicio de los demás, es lo clásico de la fobia social.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 156 · texto original del banco, sin revisar

Estudiante 4to año medicina, con miedo hablar en público y quedarse en blanco- a. Fobia social

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno de ansiedad generalizada). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Trastorno obsesivo compulsivo, Trastorno de estrés postraumático) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concu

5.01.1.004 Trastorno de adaptación

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno adaptativo: síntomas emocionales o conductuales (ánimo bajo, ansiedad, alteración conductual) que aparecen dentro de los 3 meses de un estresor identificable (despido, separación, migración, enfermedad).
- Malestar desproporcionado o deterioro funcional, sin cumplir criterios de depresión mayor (menos de 5 de 9 síntomas) ni de otro trastorno; remite en menos de 6 meses tras cesar el estresor o sus consecuencias.
- Diferenciar de duelo normal, estrés agudo/TEPT (requiere trauma con amenaza vital e intrusión/hiperalerta) y depresión mayor.
- Tratamiento: psicoeducación, psicoterapia breve de apoyo y resolución de problemas, higiene del sueño; sin antidepresivos de entrada y evitar benzodiacepinas prolongadas.
- Seguimiento: control en 3–4 semanas; si se agrava, persiste más de 6 meses o cumple criterios de depresión mayor, reclasificar y tratar (ISRS más psicoterapia).

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 90

Una mujer de 45 años consulta por irritabilidad, ánimo triste y sensación de agobio de dos meses de evolución, iniciados tras la separación de su pareja. Refiere llanto ocasional, dificultad para dormir y disminución en su rendimiento laboral, aunque continúa asistiendo a su trabajo y mantiene sus actividades cotidianas. Refiere que se siente mejor cuando hace ejercicio y tiene actividades sociales, pero que se siente sola y triste cuando regresa a su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Episodio depresivo mayor
B) Trastorno adaptativo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Sana

Respuesta B. Hay un gatillante claro y síntomas del ánimo, pero no alcanza los criterios de depresión mayor: conserva su trabajo y su vida, mejora con actividades y no tiene el cuadro completo. Es un trastorno adaptativo de tipo depresivo.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 129

Un paciente de 35 años refiere sensación de angustia e inquietud, de un mes de evolución, asociado a insomnio de conciliación y cefalea diaria, de localización occipital, que se irradia hacia los hombros. Refiere que los síntomas iniciaron en relación a la necesidad de cambiarse de casa, ya que fue asignado a nuevo cargo en su trabajo, en una ciudad distinta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por somatización
B) Depresión mayor
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta D. Trastorno adaptativo de tipo ansioso: gatillante claro y síntomas de ansiedad. La cefalea tensional no lo convierte en somatización, que implica múltiples síntomas de todo tipo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 155

Hombre de 30 años que presenció un accidente de tránsito grave en que su mejor amigo resultó herido de gravedad. Desde entonces, hace 2 semanas, presenta insomnio, tristeza, dificultad de concentración en el trabajo y anhedonia. Sin ideación suicida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno de pánico
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno adaptativo
D) Depresión mayor
E) Trastorno de estrés agudo

Respuesta C. Trastorno adaptativo: síntomas emocionales o conductuales dentro de los 3 meses de un estresor identificable (el accidente del amigo), con deterioro funcional, pero sin cumplir criterios de depresión mayor. Se espera resolución espontánea.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 167 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con angustia e insomnio de conciliación luego de enterarse que debe cambiarse de ciudad por trabajo. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno depresivo mayor
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno de pánico

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno adaptativo (opción C). Trastorno adaptativo. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 28 años presenta ánimo bajo e irritable, desde hace 2 meses, fecha en que murió su hermano. Se siente ansioso e intranquilo, sin cambios en el peso. Los síntomas interfieren moderadamente con sus actividades laborales. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno de estrés agudo
B) Trastorno de adaptación
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Distimia

Respuesta B. Es un T. adaptativo clásico (gatillante claro, síntomas depresivos y/o ansiosos, pero sin cumplir criterios de depresión u otro trastorno ansioso: ej. no tiene cambios en el peso ni afectación grave de su vida).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 108 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 43 años consulta porque, desde hace 15 días, ha presentado angustia, desasosiego, insomnio y malestar general. Refiere, además, cefalea occipital, irradiada al cuello que es peor en las tardes. Refiere que los síntomas iniciaron después de que le comunicaron en su trabajo que sería trasladado a otra cuidad, por lo que deberá cambiarse de casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de somatización
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de adaptación
D) Trastorno de angustia
E) Episodio depresivo mayor

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno de adaptación (opción C). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Paciente pierde el trabajo hace 4 semanas, y hace 3 semanas inicia con los siguientes síntomas: subido de peso y tenía insomnio, pero después decía sin anhedonia - depresión o distimia?

A) Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se
B) Trastorno depresivo mayor
C) Interrupción del embarazo
D) Maduración pulmonar y observación
E) Cesárea de urgencia

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno adaptativo porque no cumplia el mes para ser depresivo (ojo que sd. depresivo se). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

5.01.1.005 Trastorno agudo por estrés

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno por estrés agudo: exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual (real o amenazada; vivida, presenciada o de un cercano) con síntomas entre 3 días y 1 mes después.
- Clínica: intrusión (recuerdos, pesadillas, flashbacks), síntomas disociativos (aturdimiento, irrealidad, amnesia), evitación e hiperalerta (insomnio, sobresalto, irritabilidad).
- Si persiste más de 1 mes pasa a ser TEPT; un estresor cotidiano sin amenaza vital ni intrusión orienta a trastorno adaptativo.
- Tratamiento: primera ayuda psicológica (seguridad, escucha sin forzar el relato, necesidades básicas, activar redes) y TCC centrada en el trauma si los síntomas son intensos.
- No indicar benzodiacepinas (no previenen el TEPT e interfieren con la extinción del miedo) ni debriefing obligatorio; hipnótico breve solo si el insomnio es grave.
- Seguimiento: control cercano en las semanas siguientes para detectar evolución a TEPT, depresión, consumo de sustancias o riesgo suicida.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 132

Paciente que presenció un asalto hace 2 semanas, ahora con angustia, irritabilidad, insomnio y estado de hiperalerta. ¿Diagnóstico más probable? **¿Diagnóstico más probable?**

A) Trastorno por estrés postraumático (TEPT)
B) Trastorno adaptativo con ansiedad
C) Trastorno por estrés agudo
D) Trastorno de pánico
E) Trastorno depresivo mayor

Respuesta C. Trastorno por estrés agudo: trauma presenciado hace 2 semanas, con síntomas de hiperalerta e irritabilidad, es decir dentro del primer mes.

5.01.1.006 Trastorno por estrés postraumático

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- TEPT: tras exposición a muerte, lesión grave o violencia sexual, síntomas por más de 1 mes de los 4 grupos: intrusión (flashbacks, pesadillas), evitación, cognición y ánimo negativos (culpa, desapego, amnesia) e hiperalerta.
- Puede iniciarse en forma tardía (más de 6 meses después); se asocia a depresión, consumo de alcohol y riesgo suicida, que deben pesquisarse.
- Diferenciar de estrés agudo (<1 mes), trastorno adaptativo (sin trauma mayor ni intrusión) y amnesia disociativa.
- Tratamiento inicial: psicoterapia centrada en el trauma (TCC o EMDR) más ISRS (sertralina desde 50 mg o paroxetina); prazosina 1–5 mg nocturna si hay pesadillas persistentes.
- Benzodiacepinas contraindicadas en el TEPT.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada para psicoterapia de trauma.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 86

Un paciente de 24 años, sin antecedentes, consulta porque hace ocho meses mientras esperaba transporte colectivo, presenció un accidente automovilístico con resultados fatales, desde entonces intenta no acercarse mucho a la calle y cada vez que está en un paradero se encuentra muy inquieto, además refiere que le cuesta conciliar el sueño ya que presenta pesadillas frecuentemente. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno por estrés post traumático
B) Trastorno de ansiedad
C) Trastorno evitativo
D) Trastorno por estrés agudo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta A. Es un trastorno de estrés postraumático de libro, y lleva más de 4 semanas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 61

Un paciente de 50 años, presentó una pelea con su vecino hace 4 meses y desde hace un mes comienza con recuerdos del incidente, asociado a pesadillas recurrentes. En las últimas semanas evita pasar por fuera de la casa de su vecino por miedo, y su familia refiere que se encuentra con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Depresión reactiva
D) Depresión psicótica
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta B. Es un trastorno de estrés postraumático clásico.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 10

Una paciente de 52 años, con antecedente de abuso sexual reiterado por un familiar, entre los 12 y los 15 años, del que aún mantiene recuerdos y pesadillas, refiere episodios de algunos días de duración ánimo irritable y lábil, asociada a ira y peleas con sus familiares, con llanto y agresividad. En ocasiones, presenta episodios de hasta dos días de duración de descontrol y rabia, en los que rompe ropa y electrodomésticos de su marido. Estos episodios le traen problemas con sus cercanos y, en algunas ocasiones, son muy intensos, en especial cuando se expone a conversaciones relacionadas con el tema, en los que llora, siente intensa angustia, grita e incluso ha presentado momentos en que actúa como una niña, con lenguaje y entonación de una menor de edad. Estos episodios cursan con amnesia de lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno de estrés postraumático

Respuesta E. Es un trastorno de estrés postraumático con síntomas disociativos: trauma sexual en la adolescencia, recuerdos y pesadillas, episodios desencadenados por recordatorios, con amnesia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 67

Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático **Psicofármaco contraindicado en trastorno de estrés post traumático**

A) Benzodiazepinas
B) ISRS
C) Tricíclicos
D) Antipsicóticos típicos
E) Antipsicóticos atípicos

Respuesta A. Las benzodiacepinas están contraindicadas en el estrés postraumático: no previenen el trastorno e interfieren con la psicoterapia de reprocesamiento.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 28 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de años, desde hace 10 días comienza con angustia y malestar general, asociado a dificultades para dormir y pesadillas. Se ha sentido agobiado y triste. Refiere que ace dos semanas fue testigo de un asalto, en el cual la víctima fue herida con un arma de fuego. Además, ha evitado salir de su casa y el contacto con otras personas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno agudo por estrés
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Trastorno de angustia generalizada
E) Trastorno de angustia social

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno de estrés postraumático (opción C). El manejo de los contactos de pacientes con coqueluche se basa en la administración de azitromicina por cinco días, con la misma dosis que se utiliza en el tratamiento. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

5.01.1.007 Primer episodio depresivo

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES · Tema 17.4 Depresión Posparto y Trastornos Afectivos Perinatales: Blues vs Depresión vs Psicosis Puerperal

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión mayor (DSM-5): ≥5 de 9 síntomas casi todos los días por ≥2 semanas, con ánimo deprimido o anhedonia obligatorio, más deterioro: cambio de peso >5%/mes, sueño, psicomotricidad, fatiga, culpa, concentración, ideas de muerte.
- Antes de diagnosticar: descartar causa médica o fármacos (TSH, hemograma, B12), preguntar por manía/hipomanía previa (bipolaridad) y evaluar directamente el riesgo suicida.
- Gravedad con PHQ-9: 5–9 leve (psicoeducación), 10–14 moderada, 15–19 moderadamente grave, 20–27 grave (derivar). Garantía GES desde los 15 años.

- Tratamiento: ISRS más psicoterapia: sertralina 50–200 mg, escitalopram 10–20 mg o fluoxetina 20–60 mg; explicar latencia de 2–4 semanas. Benzodiacepinas nunca en monoterapia.
- Control a las 2 semanas y reevaluar a las 4–6: respuesta parcial, subir al techo; falla a dosis máxima, cambiar a otro ISRS o dual (venlafaxina 75–225 mg); mirtazapina útil con insomnio/inapetencia.
- Seguimiento completo: mantener la misma dosis 6–12 meses tras la remisión; derivar si hay psicosis, riesgo suicida moderado-alto, sospecha bipolar o falla de 2 esquemas.

PREGUNTAS (10)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 174

Un paciente de 43 años consulta por un cuadro de 3 meses de evolución caracterizado por ánimo bajo, anhedonia, insomnio de conciliación y despertar precoz. Además, ha aumentado de peso y tiene pensamientos negativos e ideas recurrentes negativas sobre sí mismo, sin ideación suicida actual. ¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento en este paciente? **¿Cuál es el fármaco de elección para iniciar el tratamiento?**

A) Alprazolam
B) Sertralina
C) Quetiapina
D) Carbonato de litio
E) Amitriptilina

Respuesta B. Es una depresión mayor, con algunos rasgos atípicos por el aumento de peso. Se trata preferentemente con ISRS, como la sertralina. Los tricíclicos ya no son de primera línea y las benzodiacepinas no tratan la depresión.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 75

Un paciente de 25 años presenta tristeza, dificultades en su trabajo, sensación de culpa patológica e insomnio de conciliación y mantención, de seis semanas de evolución, por lo que inicia tratamiento con escitalopram 10 mg al día. Tres semanas después, refiere que su ánimo ha mejorado considerablemente y que ya no se siente triste ni culpable y que tampoco ha seguido con problemas para dormir. Comenta sentirse bien, similar a como estaba antes del inicio de estos síntomas. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Suspender el tratamiento
B) Disminuir la dosis de citalopram
C) Mantener el tratamiento por 3 meses
D) Mantener el tratamiento por 12 meses
E) Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Respuesta D. Está en remisión, pero el fármaco se mantiene después de la remisión completa, por 6 a 12 meses en un primer episodio. De las alternativas, la única aceptable es 12 meses.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 99

Mujer de 30 años, 3 semanas post parto vaginal, consulta por llanto fácil, tristeza, insomnio, sentimiento de incompetencia como madre y pensamientos de hacerse daño. ¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento? **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A) Depresión postparto: iniciar antidepresivo (sertralina) + psicoterapia
B) Blues postparto: tranquilizar, resolverá espontáneamente en días
C) Psicosis puerperal: hospitalización de urgencia
D) Trastorno adaptativo: solo psicoterapia
E) Trastorno bipolar postparto: iniciar litio

Respuesta A. Más de 2 semanas del parto, síntomas depresivos e ideas de autolesión: depresión posparto. Se trata con sertralina, segura en lactancia, y psicoterapia. Con ideas de hacerse daño se evalúa antes el riesgo suicida; si es moderado o alto, se deriva.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 74

Una paciente de 38 años inicia un cuadro de ánimo bajo, desconcentración e insomnio de conciliación, que inició después de que su marido fuera diagnosticado de una enfermedad grave. No ha tenido cambios en el peso ni ideación suicida. Inicia psicoterapia sin notar mejoría de sus síntomas. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección para el manejo de esta paciente? **¿Cuál es el tratamiento farmacológico de elección?**

A) Bupropión
B) Venlafaxina
C) Sertralina
D) Carbonato de litio
E) Mirtazapina

Respuesta C. Parecía un trastorno adaptativo, pero sin mejoría con psicoterapia el cuadro evoluciona a una depresión. Su primera línea es un ISRS, como la sertralina.

Pregunta de práctica

Una madre primípara de 24 años consulta al 5.° día postparto por llanto fácil, hipersensibilidad emocional y fatiga. Refiere que a ratos se siente desbordada por los cuidados del recién nacido, pero amamanta a su hijo con afecto y logra descansar cuando sus familiares la apoyan. Su examen mental no muestra anhedonia persistente, desapego ni ideas delirantes. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico más probable y la conducta adecuada?**

A) Depresión posparto mayor; iniciar sertralina 50 mg al día de inmediato
B) Disforia puerperal ("baby blues"); psicoeducación, apoyo familiar y seguimiento sin psicofármacos
C) Psicosis puerperal incipiente; derivar de urgencia a hospitalización cerrada
D) Trastorno de pánico posparto; alprazolam en gotas cada 8 horas
E) Encefalopatía puerperal; resonancia magnética de encéfalo urgente

Respuesta B. Baby blues: día 3 a 5, llanto fácil y labilidad, vínculo preservado, sin anhedonia persistente ni delirios. Remite en 10 a 14 días con educación y apoyo, sin fármacos. La sertralina se reserva para la depresión instalada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 174 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años, sin antecedentes, con cuadro de disforia y anhedonia desde hace tres semanas, momento en el cual fue despedido de su trabajo, además presenta apetito disminuido, baja de peso e insomnio. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que siente que no vale nada y no ha presentado intentos ni ideas suicidas. El tratamiento de elección en este caso es:

A) Venlafaxina
B) Amitriptilina
C) Clonazepam
D) Escitalopram
E) Bupropion

Respuesta D. Conducta / Tratamiento indicado: Escitalopram (opción D). Tiene una depresión: preferir ISRS. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 39 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 16 años, sin antecedentes mórbidos, es traído por presentar mal rendimiento escolar y mala relación con sus padres. Sus padres refieren que esto comenzó hace tres meses, que ha estado irritable, se alimenta mal y duerme poco. Al entrevistar solo al paciente, refiere que hace aproximadamente tres meses terminó una relación amorosa que fue muy importante. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno ansioso
B) Esquizofrenia
C) Trastorno delirante
D) Distimia
E) Depresión

Respuesta E. Diagnóstico: Depresión (opción E). De libro. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 158 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 34 años consulta por un cuadro de 6 semanas de evolución de ánimo bajo y tristeza, asociado a alza de peso y dificultades para dormir consistentes en insomnio de conciliación. Además, se ha sentido más desconcentrada de lo habitual, con pensamientos negativos sobre sí misma, sin ideación suicida. ¿Qué fármaco es de elección para iniciar el tratamiento en esta paciente?

A) Bupropión
B) Citalopram
C) Venlafaxina
D) Mirtazapina
E) Carbonato de li2o

Respuesta B. El tratamiento de elección en la depresión son los antidepresivos IRS (inhibidores de la recaptura de serotonina), tales como sertralina, fluoxetina, citalopram y escitalopram. De segunda línea (en caso de que no responda después de 4 semanas), se puede subir la dosis o idealmente cambiar a un antidepresivo dual, como la venlafaxina, duloxetina, bupropión o mirtazapina. Los dos últimos, además, so

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años presenta un cuadro de 5 meses de evolución de dificultades para concentrarse, asociadas a desgano, ánimo bajo y tristeza, síntomas que se acentúan en el periodo premenstrual. Sale muy poco de su casa y ha disminuido la interacción con otras personas, comentando que disfruta poco o nada con las actividades que habitualmente le eran placenteras. Refiere que duerme cerca de 2 horas menos que antes y que ha subido una talla de ropa. Sus exámenes generales descartan patología orgánica. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno adaptativo
B) Episodio depresivo mayor
C) Trastorno de angustia generalizada
D) Trastorno de ansiedad social
E) Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta B. Tiene una depresión clara con ánimo bajo, anhedonia, desconcentración, alteraciones del peso y del sueño.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 170 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años consulta por un cuado de un mes de evolución, en que sale poco de su casa y presenta desgano y retraimiento social, disminuyendo el disfrute de las actividades que habitualmente le eran placenteras. También refiere desconcentración en su trabajo y, además, ha disminuido la cantidad del tiempo de sueño, en alrededor de 2 horas diarias. Refiere que los síntomas empeoran en el período premenstrual. El diagnóstico más probable es:

A) Episodio depresivo mayor
B) Trastorno adaptativo
C) Hipomanía
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Trastorno disfórico premenstrual

Respuesta A. Tiene una depresión clásica con anhedonia y afectación de distintas áreas de la vida (sueño, actividad social, concentración, etc.). Que empeore en el periodo premenstrual es algo que puede ocurrir con cualquier patología psiquiátrica y también con cualquier problema normal, sin necesariamente ser un síndrome premenstrual.

5.01.1.008 Trastorno depresivo (recurrente)

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Depresión recurrente: dos o más episodios depresivos mayores separados por al menos 2 meses sin síntomas; mayor riesgo de nuevas recaídas con cada episodio.
- Sospecharla ante historia de episodios previos o tratamiento antidepresivo anterior; buscar dirigidamente antecedentes de manía o hipomanía (bipolaridad), consumo de sustancias y riesgo suicida.
- Distimia (trastorno depresivo persistente): ánimo bajo crónico ≥2 años (1 año en niños y adolescentes) sin pausas >2 meses; si se superpone un episodio mayor es depresión doble.
- Manejo inicial: reiniciar el antidepresivo que fue eficaz (ISRS) más psicoterapia, evaluar adherencia y gravedad.
- Tras 2–3 episodios el mantenimiento es prolongado (≥2 años o indefinido); el litio reduce intentos suicidas en depresión recurrente.
- Seguimiento: derivar a nivel secundario (recurrencia, refractariedad o comorbilidad).

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 146

Un hombre de 45 años consulta por ánimo deprimido, anhedonia, alteraciones del sueño y dificultades para concentrarse, los cuales han afectado su desempeño laboral y social durante los últimos 4 meses. No refiere antecedentes de episodios maníacos ni psicosis, pero sí un episodio depresivo mayor hace cinco años, tratado con éxito con fluoxetina. En esta ocasión, se inició tratamiento con escitalopram (20 mg/día) durante 4 semanas, pero no ha mostrado mejoría significativa en sus síntomas. No refiere efectos secundarios importantes con el medicamento y su función tiroidea y niveles de vitamina B12 y ácido fólico son normales. ¿Cuál es la conducta más adecuada? **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de escitalopram
B) Cambiar el tratamiento a venlafaxina
C) Iniciar terapia electroconvulsiva (TEC)
D) Agregar un antipsicótico atípico como quetiapina
E) Cambiar el tratamiento a fluoxetina

Respuesta B. El escitalopram ya está a 20 mg, su dosis máxima, con buena tolerancia y sin causa médica. Al no haber respuesta, se cambia a un antidepresivo dual como la venlafaxina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 71

Una paciente de 82 años, con antecedente de 2 intentos de suicidio previos, presenta un cuadro de ánimo bajo, irritabilidad, problemas de memoria. Su minimental es 27/30, su GDS (escala de depresión geriátrica) es de 12/15 y presenta ideas delirantes de daño. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Terapia electroconvulsiva
B) Iniciar sertralina
C) Hospitalizar con mirtazapina
D) Indicar clorpromazina
E) Hospitalizar con amitriptilina

Respuesta A. Es una depresión psicótica en una adulta mayor, con intentos de suicidio previos y riesgo vital. Es una urgencia que se maneja hospitalizada, y la terapia electroconvulsiva es la opción más segura y rápida. La amitriptilina y la clorpromazina son mala idea en el adulto mayor.

Pregunta de práctica

Una mujer de 39 años consulta en salud mental refiriendo: "Toda mi vida he sido una persona triste y sin energía; desde la universidad, hace más de 10 años, siento que veo el mundo en blanco y negro, me canso con facilidad y tengo muy baja autoestima". Refiere que nunca ha tenido episodios de euforia ni períodos libres de síntomas que superen las 3 o 4 semanas seguidas. Su examen físico y tiroideo son normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico? **¿Cuál es el diagnóstico más probable y el pilar terapéutico?**

A) Trastorno adaptativo; reposo laboral exclusivo
B) Trastorno depresivo persistente (distimia); ISRS a largo plazo y psicoterapia cognitivo-conductual
C) Trastorno de personalidad esquizoide; antipsicóticos típicos
D) Episodio depresivo mayor único; suspender fármacos a los 3 meses
E) Trastorno ciclotímico; valproato sódico en monoterapia

Respuesta B. Ánimo bajo, poca energía y baja autoestima de curso continuo por más de 10 años, sin períodos libres de más de 2 meses: distimia. El tratamiento óptimo combina un ISRS a dosis plenas por tiempo prolongado con psicoterapia cognitivo-conductual.

5.01.1.009 Trastorno bipolar

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Bipolar I: basta un episodio maníaco; bipolar II: hipomanía más episodio depresivo mayor; ciclotimia: 2 años de fluctuaciones sin criterios completos. Heredabilidad cercana al 80%.
- Manía: ánimo elevado, expansivo o irritable con ≥3 de 7 síntomas (4 si solo irritable): grandiosidad, menos necesidad de sueño, verborrea, fuga de ideas, distraibilidad, hiperactividad y conductas de riesgo; ≥7 días o cualquier duración si hospitaliza o hay psicosis.
- Hipomanía: ≥4 días, sin deterioro grave ni psicosis. Euforia o insomnio sin fatiga tras iniciar un ISRS sugiere bipolaridad: suspender el antidepresivo.

- Manía aguda: urgencia; hospitalizar, antipsicótico atípico (olanzapina, risperidona, quetiapina) más estabilizador (litio o valproato); agitación intensa: haloperidol más lorazepam. Nunca antidepresivo en monoterapia.
- Litio: litemia profilaxis 0,6–1,0 mEq/L (aguda 0,8–1,2), muestra a las 12 h; AINE, tiazidas e IECA/ARA-II la elevan. Valproato teratogénico: evitar en mujeres en edad fértil sin anticoncepción.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría (garantía GES); controles de litemia, función renal y tiroidea.

PREGUNTAS (11)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 82

Paciente de 35 años con episodios previos de tristeza profunda de 3 semanas de duración. Ahora consulta por irritabilidad, euforia, grandiosidad, insomnio sin cansancio y gastó todos sus ahorros en 4 días. ¿Cuál es el diagnóstico? **¿Cuál es el diagnóstico?**

A) Trastorno bipolar tipo I
B) Trastorno depresivo mayor recurrente
C) Trastorno de ansiedad generalizada
D) Trastorno obsesivo compulsivo
E) Trastorno de personalidad borderline

Respuesta A. Episodios depresivos previos más un episodio maníaco actual (grandiosidad, euforia, insomnio sin cansancio, gasto impulsivo) es trastorno bipolar tipo I. Un episodio maníaco es suficiente para el diagnóstico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 114

Una paciente de 23 años presenta un cuadro de 3 semanas de evolución caracterizado por ánimo bajo, tristeza, disminución de sus actividades, asociado a hipersomnia diurna y aumento de peso de 5 kg en poco tiempo. Además, refiere dificultades de concentración en sus actividades educacionales. Tiene antecedentes de tres episodios similares en los últimos años y su hermana refiere que también ha presentado dos episodios en los cuales ha tenido periodos con mucho ánimo y aumento de la energía, incurriendo en gastos excesivos y desarrollando múltiples proyectos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno de personalidad histriónico
B) Trastorno afectivo bipolar
C) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
D) Trastorno de personalidad limítrofe
E) Depresión atípica

Respuesta B. El episodio actual parece una depresión atípica (hipersomnia, aumento de peso), pero hubo dos períodos de ánimo elevado, mucha energía, gastos excesivos y múltiples proyectos. Eso apunta a trastorno afectivo bipolar. En la depresión bipolar se usan antipsicóticos atípicos, no antidepresivos solos.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 130

Un paciente de 27 años presenta ánimo bajo, anhedonia y desconcentración, asociado a baja de peso y dificultades para dormir, por lo que se le indica tratamiento con sertralina 50 mg al día. Evoluciona con clara mejoría de los síntomas, sin embargo, su pareja refiere que anda más irritable, ha aumentado el gasto de dinero y ha iniciado nuevos proyectos. Suspende el medicamento, persistiendo con disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad y verborrea. ¿Qué fármaco es más adecuado para su manejo actual? **¿Qué fármaco es más adecuado para su manejo actual?**

A) Sertralina
B) Mirtazapina
C) Bupropión
D) Diazepam
E) Quetiapina

Respuesta E. Viró a una hipomanía en el contexto de un trastorno bipolar no diagnosticado. Están contraindicados todos los antidepresivos (sertralina, mirtazapina, bupropión). El tratamiento de elección es un antipsicótico atípico, como la quetiapina.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 92

Paciente con trastorno bipolar tipo I presenta episodio de manía aguda con agitación, desinhibición y grandiosidad. ¿Cuál es el tratamiento de elección en fase aguda? **¿Cuál es el tratamiento de elección en fase aguda?**

A) Litio + antipsicótico atípico (quetiapina u olanzapina)
B) Solo antidepresivos ISRS
C) Benzodiacepinas en monoterapia
D) Lamotrigina en dosis progresiva
E) Ácido valproico en monoterapia oral

Respuesta A. Manía aguda: tratamiento combinado con un estabilizador del ánimo (litio o ácido valproico) más un antipsicótico atípico para controlar rápido los síntomas. Litio más quetiapina es un esquema estándar.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 77 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares debido a que anda muy irritable y con una actitud rara, además de haber iniciado una serie de proyectos de negocios nuevos. Al examen presenta aceleración del habla y sus acompañantes comentan que en ocasiones trabaja hasta muy tarde, pese a lo cual al día siguiente continúa con sus actividades normales, durmiendo muy pocas horas. Durante la entrevista, en ocasiones se emociona y llora y en otras se ríe a carcajadas. Sus compañeros de estudios refieren que anda más gracioso y “sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido a los 18 años en relación con una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adapta2vo mixto
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
D) Trastorno de personalidad en crisis
E) Trastorno esquizoafec2vo

Respuesta B. Es un trastorno afectivo bipolar clásico. Ahora está en episodio maníaco, cuya presencia confirma el diagnóstico de trastorno bipolar. El antecedente de depresión lo refuerza.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 22 años es traído por sus familiares, dado que anda muy irritable y ha iniciado una serie de proyectos de negocio, en áreas que no maneja bien. Presenta aceleramiento del habla y hay noches en las que pasa sin dormir, a pesar de lo cual, al día siguiente no presenta sueño. En ocasiones, se ríe a carcajadas y ,en otras, se emociona fácilmente al hablar de ciertos temas. Sus amigos lo describen como “patudo y sin filtro”. Tiene antecedente de haberse deprimido hace algunos años, en relación a una ruptura sentimental. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno esquizoafectivo
B) Trastorno adaptativo mixto
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad en crisis

Respuesta C. Es una manía clásica y, por tanto, un TAB. No tiene síntomas psicóticos. Si bien la personalidad parece estar afectada (ser "patudo y sin filtro"), no hay duda que de base hay un TAB.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 165 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con irritabilidad, conductas sexuales de riesgo, disminución de necesidad de dormir, más habladora de lo habitual. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad histriónica
B) Trastorno bipolar (episodio maníaco)
C) Trastorno por déficit atencional
D) Hipomanía inducida por sustancias
E) Trastorno ciclotímico

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno bipolar (episodio maníaco) (opción B). Trastorno bipolar (episodio maníaco). El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 13 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 20 años inicia tratamiento con fluoxetina, por un cuadro de ansiedad social, evolucionando con aumento de la sociabilidad, volviéndose muy conversador, pero siendo en ocasiones muy intrusivo, al punto de ser desagradable. Muestra ausencia de empatía y ha tenido problemas con sus compañeros de estudios. Con frecuencia, se muestra irritable, ansioso y a veces emocionado, con llanto. Ha aumentado su nivel de actividad física y, además, presenta disminución de las horas de sueño, sin disminuir su nivel de energía. En ocasiones, presenta ganas de salir corriendo, sin saber por qué. Tiene antecedente de un episodio depresivo a los 16 años, que respondió al tratamiento con sertralina. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A) Bipolar
B) Adaptativo mixto
C) Por déficit atencional
D) Esquizoafectivo
E) Delirante

Respuesta A. Diagnóstico: Bipolar (opción A). Tiene una manía clásica, secundaria al uso de fármacos y, por tanto, tiene un TAB.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 128 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 19 años, estudiante universitario, inicia sertralina oral, debido a un trastorno de ansiedad social. Evoluciona con verborrea e hiperactividad, le habla a personas con las que normalmente no conversaba y se muestra muy inquieto y optimista. No se observa cansado, a pesar de dormir poco. Como antecedente, tuvo una depresión diagnosticada a los 18 años, que respondió al tratamiento antidepresivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno esquizotípico de la personalidad
D) Distima
E) Trastorno por déficit atencional

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno bipolar (opción A). Tiene una manía aguda, por lo que tiene un trastorno bipolar.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 35 · texto original del banco, sin revisar

Paciente femenina con antecedente de episodio depresivo mayor hace 5 años tratada, nuevamente sintomática, parte antidepresivos y evoluciona con cambios de conducta aumento de energía: a. Bipolar

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno bipolar

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Trastorno de ansiedad generalizada (opción A). Intoxicación por litio: vómitos, temblor, ataxia, poliuria; manejo con suero fisiológico y hemodiálisis si grave. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 178 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años, en tratamiento antidepresivo, desde hace 15 días, consul- ta por un cuadro paranoide, asociado a expansividad. Además presenta disminución de los requerimientos de sueño, irritabilidad, agresividad y aumento de la actividad psico- motora. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Acatisia
B) Esquizofrenia
C) Depresión psicótica
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad limítrofe

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno bipolar (opción D). Es una manía aguda, en contexto del uso de antidepresivos. Por tanto es un tras- torno bipolar.. El trastorno bipolar es una enfermedad genética (herencia autosómica dominante) con alta prevalencia de antecedentes familiares, que debuta típicamente entre los 18 y 30 años. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica e

5.01.1.010 Esquizofrenia y otros trastornos psicòticos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES · Tema 17.11 Clozapina y Esquizofrenia Refractaria: Monitorización de Hemograma · Tema 17.12 Trastorno Delirante Crónico vs Psicosis Reactiva Breve

QUÉ HAY QUE SABER

- Esquizofrenia: ≥2 síntomas por 1 mes (uno debe ser delirio, alucinación o habla desorganizada; además conducta desorganizada/catatonía o síntomas negativos), con deterioro sociolaboral y duración total ≥6 meses. Prevalencia ~1%; inicio en adulto joven.
- Psicosis breve: <1 mes con recuperación completa (a menudo tras estresor); esquizofreniforme: 1–6 meses; trastorno delirante: delirio no bizarro ≥1 mes con funcionamiento conservado; psicosis puerperal: emergencia.
- Primer episodio: descartar causa orgánica o tóxica (drogas en orina, TAC/RM, TSH, VDRL, VIH, hemograma, electrolitos; punción lumbar si hay fiebre o signos meníngeos). El cannabis en adolescentes aumenta el riesgo 2–4 veces.
- Manejo inicial: notificar GES de primer episodio (desde 15 años; confirmación por psiquiatra en 20 días y tratamiento en 24 horas desde la confirmación), iniciar antipsicótico atípico (risperidona 2–6 mg u olanzapina 10–20 mg) y derivar.
- Vigilar efectos adversos: distonía aguda (biperideno), acatisia (propranolol), parkinsonismo, síndrome metabólico (peso, PA, glicemia y lípidos basal, 1 y 3 meses y anual).
- Seguimiento: derivar a psiquiatría; mantener antipsicótico 1–2 años tras un primer episodio; refractaria (falla de 2 antipsicóticos) va a clozapina.

PREGUNTAS (33)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 38

Un paciente de 18 años, adicto a la pasta base, presenta un episodio psicótico, en relación al consumo, el que es manejado con haloperidol intramuscular. Al día siguiente presenta contracción tónica del cuello, que desvía la cabeza hacia la izquierda, con intenso dolor. **El diagnóstico más probable es:**

A) Distonía aguda
B) Acatisia
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Disquinesia tardía
E) Parkinsonismo farmacológico

Respuesta A. Contracción tónica y dolorosa del cuello dentro de las 24–48 horas tras haloperidol: distonía aguda (tortícolis). Se trata con biperideno IM o EV.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 109

Paciente en tratamiento con flufenazina, presenta alteración de conciencia, fiebre, rigidez de extremidades y taquicardia. **¿Diagnóstico más probable?**

A) Hipertermia maligna anestésica
B) Síndrome serotoninérgico
C) Crisis distónica aguda
D) Síndrome neuroléptico maligno
E) Encefalitis autoinmune

Respuesta D. Neuroléptico + fiebre + rigidez de extremidades + compromiso de conciencia + taquicardia: síndrome neuroléptico maligno. La distonía aguda es focal, sin fiebre, sin rigidez generalizada y con conciencia conservada.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 39

Joven de 22 años que abandonó su carrera universitaria hace 8 meses, pasa la mayor parte del tiempo en casa, habla solo, ríe sin motivo aparente y cree que sus compañeros lo persiguen. Sin consumo de sustancias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Trastorno esquizoafectivo
C) Trastorno de personalidad esquizoide
D) Trastorno bipolar con psicosis
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta A. Esquizofrenia: síntomas positivos (alucinaciones, ideas de persecución), negativos (aislamiento social, abandono de actividades) y desorganización (habla solo, risa inapropiada) por más de 6 meses en un adulto joven. Requiere antipsicótico y rehabilitación.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 76

Una paciente de 40 años, trabajadora de supermercado, consulta por sentirse angustiada y triste. Refiere que desde su adolescencia presenta alucinaciones auditivas, consistentes en voces que hacen comentarios negativos acerca de ella, las que desaparecen durante algunos periodos, reapareciendo en momentos de mayor estrés o soledad. Refiere que en el último tiempo las voces le han estado ordenando que se suicide. Al examen físico destaca su aspecto personal muy descuidado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno delirante crónico
B) Delirium
C) Esquizofrenia
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Depresión mayor con síntomas psicóticos

Respuesta C. Es una esquizofrenia clásica, con alucinaciones auditivas, inicio en la adolescencia y afectación general de su vida (aspecto descuidado), complicada con una probable depresión y síntomas ansiosos. No parece un trastorno esquizoafectivo, ya que no tiene historia de episodios depresivos o maníacos repetidos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 74

Un paciente de 18 años presenta un cuadro de ánimo bajo, en tratamiento con antidepresivos por 3 meses, sin respuesta. Sus padres están muy preocupados, porque permanece encerrado en su cuarto, sin hacer nada, ni siquiera ver televisión. Al examinarlo, no se aprecia anhedonia, ni tristeza. No ha tenido alucinaciones. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Distimia
B) Trastorno de personalidad esquizoide
C) Esquizofrenia
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Depresión mayor

Respuesta C. Aunque no tenga delirios ni alucinaciones, parece una esquizofrenia que está debutando, probablemente de predominio negativo (esquizofrenia simple) o incluso catatónica, por permanecer inmóvil tanto tiempo.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 13

Un paciente con esquizofrenia, recién diagnosticado, inicia tratamiento con risperidona 2 mg/día hace 5 días. Al tercer día, inicia un cuadro de disestesias en las extremidades inferiores, asociadas a angustia, inquietud y cambio continuo de posición. Se muestra muy incómodo y angustiado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno de adaptación
B) Distonía aguda
C) Disquinesia aguda
D) Acatisia
E) Hipomanía

Respuesta D. Acatisia: inquietud con malestar en las piernas y necesidad de cambiar de posición, a los pocos días de iniciar risperidona.

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 90

Un paciente de 35 años está convencido que las vacunas contra la Covid-19 contienen un chip para rastrear a las personas y que hay un acuerdo entre Bill Gates y muchos de los gobiernos para controlar las mentes de la población, tal como lo ha hecho con muchas personas, a las que califica de «borregos». Cree que la mayoría de los médicos son parte de este complot, porque están financiados por las farmacéuticas y el Gobierno. Si bien se desenvuelve normalmente en su trabajo, ha tenido varios problemas con compañeros de trabajo y con sus familiares, cuando se toca el tema de las vacunas, en el que habla con gran vehemencia y certeza, criticando duramente a quienes le recomiendan vacunarse. También pierde mucho tiempo discutiendo sobre el tema en redes sociales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno del espectro autista en el adulto
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de personalidad paranoide

Respuesta B. Trastorno delirante clásico, con un delirio sistematizado y afectación únicamente en esa área. No tiene alucinaciones ni síntomas negativos o primarios de esquizofrenia.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 108

Un paciente de 54 años está seguro de que su esposa lo engaña, lo que confirma con un cambio de actitud que ella ha tenido en el último tiempo. Además cree saber con quién lo engaña, ya que se ha encontrado con el sujeto en la calle y siempre mira para abajo. La esposa y los familiares niegan los hechos, pero están preocupados por lo que pasa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno de personalidad esquizoide
B) Esquizofrenia
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno delirante crónico
E) Trastorno bipolar

Respuesta D. Es un trastorno delirante crónico clásico, con delirio de celos.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 17

Una mujer de 35 años, sin antecedentes, consulta porque está segura de que todos sus compañeros de trabajo la seducen y la acosan, esto le ocurre desde hace aproximadamente 10 años y le ha traído problemas en su trabajo, por lo que ha sido despedida en otros trabajos. No refiere presentar problemas en otros ámbitos de su vida, tiene buena relación con familiares y amigos. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Trastorno de personalidad paranoide
B) Trastorno de personalidad histriónico
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de la personalidad esquizotípico

Respuesta C. Si bien parece histriónica, ha perdido el juicio de realidad y además «está segura», por lo que es un trastorno delirante crónico.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 95

Una paciente de 81 años, hace un año tiene la idea de padecer de VIH, por lo que se ha realizado múltiples exámenes, los que siempre han resultado negativo. A pesar de ello, ella continúa con la idea. Fuera de esto, su vida no ha sido mayormente afectada. El diagnóstico más probable es: **El diagnóstico más probable es:**

A) Demencia
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno por hipocondría
E) Depresión psicótica

Respuesta C. Trastorno delirante crónico clásico, con delirio de enfermedad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 71

Una paciente de 46 años presenta conflictos frecuentes con distintas administraciones de su edificio, que se han extendido durante los últimos 10 años, y que ella atribuye al hecho de que vive sola y que, durante su jornada laboral, los conserjes y el personal del edificio aprovechan su ausencia para entrar a su departamento y utilizarlo como lugar de alimentación y para dormir y descansar en él sin su autorización. Comenta que las cámaras del edificio no han logrado captar estos hechos debido a la probable utilización de algún tipo de inhibidor de señal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Depresión con síntomas psicóticos
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno de personalidad esquizoide

Respuesta C. Tiene un delirio: ideas fuera de la realidad, de certeza absoluta, sistematizadas y crónicas. Es un trastorno delirante crónico clásico. No es un trastorno de personalidad paranoide, que es una persona muy desconfiada y celosa, pero sin pérdida del juicio de realidad.

Pregunta de práctica

Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A) Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación
B) Primer episodio de esquizofrenia; activar GES 34, iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista
C) Trastorno esquizoafectivo; indicar sertralina 100 mg y reposo en casa
D) Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes
E) Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia: síntomas positivos (delirio de persecución, voces comentadoras), negativos (aplanamiento, abulia) y disfunción sociolaboral de más de 6 meses, con tóxicos negativos. En Chile es un primer episodio de esquizofrenia cubierto por GES 34: confirmación por psiquiatra en 20 días como máximo y tratamiento integral dentro de 24 horas desde la confirmación. Se notifica, se inicia un atípico (por ejemplo risperidona u olanzapina) y se deriva. La psicosis breve dura menos de un mes.

Pregunta de práctica

Un comerciante de 38 años sin antecedentes psiquiátricos pierde su local comercial en un incendio intencional. A los dos días comienza con agitación psicomotora, insomnio total, llanto incontrolable y afirmaciones de que «ve demonios que le ordenan caminar en círculos». Es hospitalizado y tratado transitoriamente con dosis bajas de risperidona. Al día 18 del cuadro, los síntomas psicóticos desaparecen por completo, encontrándose orientado, reflexivo y reincorporándose plenamente a sus actividades comerciales. ¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo? **¿Cuál es el diagnóstico retrospectivo definitivo?**

A) Esquizofrenia hebefrénica
B) Trastorno psicótico breve con desencadenante grave
C) Trastorno esquizofreniforme residual
D) Trastorno de personalidad límite
E) Trastorno bipolar en manía pura

Respuesta B. Inicio brusco tras un estresor biográfico masivo, síntomas psicóticos floridos y resolución completa con restitución ad integrum a los 18 días, es decir, en menos de 1 mes: trastorno psicótico breve con desencadenante grave (antes psicosis reactiva breve). El esquizofreniforme requiere entre 1 y 6 meses, y la esquizofrenia al menos 6 meses.

Pregunta de práctica

Primigesta de 27 años, parto vaginal hace 7 semanas, acude al control de niño sano de los 2 meses. La EPDS da 15 puntos. Hace 1 mes no disfruta estar con su hijo, siente que "no nació para ser madre", no logra dormir aunque el bebé duerma y se siente exhausta y culpable. Es protectora con el lactante, niega ideas de dañarlo y no tiene síntomas psicóticos. Amamanta en forma exclusiva y desea continuar. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Explicar que es baby blues y controlar en 6 meses
B) Suspender la lactancia e iniciar un tricíclico
C) Sertralina, psicoterapia, mantener la lactancia y control en 2 semanas
D) Hospitalización psiquiátrica de urgencia por psicosis puerperal
E) Indicar benzodiacepinas para dormir y volver a control habitual

Respuesta C. Depresión posparto: más de 2 semanas, criterios de depresión mayor y EPDS de 15. No hay psicosis ni riesgo para el bebé. Se trata con sertralina y psicoterapia, se mantiene la lactancia y se controla en 2 semanas.

Pregunta de práctica

Hombre de 29 años con esquizofrenia refractaria, en el día 18 de clozapina 150 mg al día. Consulta por fiebre de 38,2 °C, dolor precordial, disnea y taquicardia de 125 por minuto persistente en reposo. Su hemograma de control de la semana anterior fue normal, con RAN de 3.500/mm³. El electrocardiograma muestra taquicardia sinusal con alteraciones inespecíficas del ST. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Atribuirlo a ansiedad e indicar una benzodiacepina
B) Sospechar miocarditis por clozapina: suspender el fármaco y estudiar con troponinas y ecocardiograma
C) Reducir la clozapina a la mitad y controlar en una semana
D) Descartar agranulocitosis por hemograma normal y continuar igual
E) Agregar ácido valproico por riesgo de convulsiones

Respuesta B. Fiebre, disnea, dolor precordial y taquicardia persistente no explicada en el primer mes de clozapina son una miocarditis hasta demostrar lo contrario. Se estudia con ECG, troponinas y ecocardiograma y se suspende el fármaco. El hemograma normal descarta agranulocitosis, pero no esta complicación.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 137 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 26 años, estudiante universitario con regular rendimiento, es traído por sus padres porque desde hace tres meses no ha asistido a clases, ya que prefiere quedarse en su habitación. Ellos refieren que siempre fue solitario y que no buscaba tener amistades. Al entrevistarlo de forma dirigida se ríe sin motivo y refiere que no quiere salir de su habitación porque la voz del diablo lo amenaza. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno delirante crónico
B) Trastorno de la personalidad esquizoide
C) Delirium
D) Esquizofrenia hebefrénica
E) Trastorno Bipolar

Respuesta D. Diagnóstico: Esquizofrenia hebefrénica (opción D). La risa sin motivo orienta a Hebefrenia. El cuadro clínico es sugerente de EQZ.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 116 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 21 años, abandonó a los 18 años su hogar, viviendo solo en la calle. Tiene la idea de ser un enviado de Dios, con la misión de salvar al mundo y dice que los ángeles le susurran al oído diciéndole cómo hacerlo. Los familiares refieren que empezó hace 3 años con esto y que no ha cambiado mucho desde entonces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante crónico
B) Esquizofrenia
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno de conducta

Respuesta B. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción B). Es una EQZ clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 129 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 18 años tiene la idea de que algunas personas quieren dañarlo. Pre- viamente a esto presentaba retraimiento social. En el último tiempo el cuadro empeora, agregándose alucinaciones de voces, que lo insultan y ha descuidado significativamente su higiene personal. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Personalidad esquizotípica
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno esquizoafectivo
E) Depresión psicótica

Respuesta A. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción A). Es una esquizofrenia clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 95 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de un quiebre conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio de persecución y alucinaciones auditivas, asociado a marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Depresión psicótica
B) Trastorno adaptativo mixto
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno esquizoide

Respuesta C. Tiene clara coexistencia de síntomas psicóticos (alucinaciones y delirio) con síntomas anímicos depresivos, por lo que es un T. esquizoafectivo clásico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 39 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 52 años presenta un cuadro de alucinaciones auditivas, desde la adolescencia. En el último tiempo, las alucinaciones se intensifican, escuchando voces que la insultaban y le decían que se suicidara. Está muy angustiada y se ha sentido triste por lo que le sucede. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante crónico
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno depresivo mayor
E) Trastorno esquizotípico de la personalidad

Respuesta A. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción A). Parece una esquizofrenia por las alucinaciones auditivas y el inicio en la adolescencia.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente masculino, de 22 años, desde hace más de 6 meses ha dejado de compartir con su familia y casi no sale de su pieza. Además, ha descuidando su aspecto personal. Sus familiares refieren que en ocasiones lo escuchan musitar, hablar y reírse solo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Ezquizofrenia
B) Depresión psicótica
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad esquizoide
E) Trastorno bipolar

Respuesta A. Es una forma clásica del primer brote de esquizofrenia. La edad es compatible. Seguramente tiene alucinaciones auditivas y por eso habla y se ríe solo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 75 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 24 años tiene la idea de que es el enviado de Dios y que está encargado de la salvación de las almas. Se muestra convencido de ello y al confrontarlo con la realidad, reacciona algo agresivo. Es un paciente tranquilo, con pocos amigos y afectivamente plano. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno esquizoafectivo
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad narcisista
E) Esquizofrenia

Respuesta E. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción E). Tiene síntomas positivos (delirio megalomaniaco) y negativos (aplanamiento afectivo). Es una Esquizofrenia. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 51 · texto original del banco, sin revisar

Paciente joven de 24 años, es traído por sus padres ya que desde hace aproximadamente un año se vuelve muy solitario, no sale de su hogar, descuida su higiene y habla frecuentemente sobre el apocalipsis y el fin de la humanidad. Al entrevistarlo se aprecia con marcado aplanamiento afectivo y frente a distintas preguntas habla sobre el apocalipsis. Su madre está actualmente cursando con depresión y su padre tiene trastorno bipolar en tratamiento con litio. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno bipolar
B) Trastorno por abuso de sustancias
C) Trastorno de la personalidad esquizotípico
D) Esquizofrenia
E) Trastorno delirante crónico

Respuesta D. Es una familia muy disfuncional. La clínica orienta mucho a EQZ. Los antecedentes familiares confunden, porque orientan a T. bipolar, pero no hay clínica de dicha enfermedad.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 135 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con trabajo y buenas relaciones, pero cree que sus vecinos entran a su casa mientras ella no está. ¿Diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia paranoide
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno bipolar con síntomas psicóticos

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno delirante (opción B). Trastorno delirante. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 84 años consulta por un cuadro de 4 semanas de evolución de des- confianza, asociada a enojo porque quienes viven con él le roban y le cambian sus co- sas de lugar, para molestarlo. Hace 1 semana despidió a alguien que había trabajado por 30 años con él, por la misma razón. Al examen se muestra molesto respecto al tema, sin otras alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Demencia
B) Paranoia
C) Delirium
D) Trastorno delirante
E) Depresión psicótica

Respuesta D. Cumple criterios de trastorno delirante, con delirio de persecución. No se indicaba desorientación ni inatención, como para pensar en delirium; tampoco había síntomas anímicos, como para pensar en depresión. La memoria no estaba afectada, como para pensar en demencia. No es un trastorno delirante crónico (mayor a 3 meses).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 78 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 25 años, con antecedente de esquizofrenia, con mala adherencia al tratamiento oral, inicia tratamiento con flufenazina intramuscular de depósito hace 3 días. Sin embargo, comienza con un cuadro de inquietud, malestar general y fiebre hasta 38,7°C, seguido de obnubilación. Al examen físico tiene FC: 109x', PA: 150/102 mmHg, T°: 38,5°C y, en el examen segmentario, destaca rigidez muscular generalizada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Meningitis bacteriana
B) Distonía aguda
C) Infección en el sitio de punción
D) Síndrome serotoninérgico
E) Síndrome neuroléptico maligno

Respuesta B. Diagnóstico: Distonía aguda (opción B). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Meningitis bacteriana, Infección en el sitio de punción) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concu

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 91 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 15 años ha presentado una serie de conflictos con sus familiares en el último tiempo, discutiendo con varios de ellos, de manera intensa. Además, está muy conversadora, incluso con extraños y ha tenido varios problemas en el colegio, debido a que interrumpe reiteradamente las clases y, cuando sus profesores la han hecho callar, responde de forma agresiva y los insulta. Duerme cerca de 5 horas al día, inició su vida sexual recientemente, sin protección y ha consumido marihuana en 3 oportunidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional hiperactivo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Esquizofrenia
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno por consumo de sustancias

Respuesta C. Diagnóstico: Esquizofrenia (opción C). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL). Las opciones alternativas (Trastorno por déficit atencional hiperactivo, Trastorno de personalidad limítrofe) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos d

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 64 años ha presentado, desde hace algún tiempo, conflictos con sus vecinos. Refiere que varios de sus vecinos tienen intenciones de dañarla o perjudicarla de alguna forma. Además, refiere la certeza de que sus vecinos han entrado a su departamento, habiéndose sentado en sus sillones, fumado en su sala e incluso dormido en su cama. Tiene una red de apoyo funcional, con buenas relaciones con sus familiares, quienes se muestran preocupados con este tema. No tiene otros síntomas y su examen de Minimental resulta 29/30. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno delirante
B) Depresión con síntomas psicótico
C) Esquizofrenia de inicio tardío
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno esquiafectivo

Respuesta B. Diagnóstico: Depresión con síntomas psicótico (opción B). Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 76 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 56 años dice, desde hace algunos meses, que sus vecinos lo espían y que están conspirando contra él. No tiene otros problemas y tiene una vida laboral y familiar normales. La esposa se muestra muy preocupada y refiere además que el paciente es aceptado y querido por todos y que los vecinos nunca lo han espiado ni nada similar. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Depresión
C) Trastorno delirante crónico
D) Trastorno de personalidad paranoide
E) Trastorno obsesivo compulsivo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción C). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 171 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 50 años asegura que es constantemente espiado por los gobiernos de varios países, dado que el maneja información importante y confidencial de muchos políticos y personas de poder. Al preguntarle cómo sabe que lo espían, reacciona enojado diciendo que es obvio y que uno de sus vecinos fue quien inició todo esto. El diagnóstico más probable es:

A) Esquizofrenia
B) Trastorno delirante
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Trastorno esquizoide de la personalidad
E) Trastorno paranoide de la personalidad

Respuesta B. Tiene un delirio paranoide, con la reacción apodíptica clásica de alguien psicótico. La edad y la ausencia de alucinaciones y síntomas negativos hacen improbable una esquizofrenia. No tiene síntomas anímicos, como para pensar en T. esquizoafectivo. Los T. personalidad no están psicóticos, aunque el TP paranoide es muy celoso y desconfiado y el TP esquizoide es muy solitario, apático e indiferente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 83 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre de 46 años refiere que las mujeres de su trabajo se le insinúan y quieren tener una relación con él. Sin embargo, no hay testigos de esos hechos y al interrogar a sus compañeras de trabajo, lo niegan. Al confrontar al paciente, se enoja, ya que le molesta que no crean en lo que él dice. El diagnóstico más probable es:

A) Hipomanía
B) Esquizofrenia
C) Trastorno delirante crónico
D) Dismorfofobia
E) Trastorno de personalidad narcisista

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción C). Es un trastorno delirante crónico de libro (delirio sistematizado; pérdida de juicio de realidad).. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 109 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 58 años ha tenido gran conflicto con la comunidad del edificio en que vive y también con la administración. Además, se la ha visto vociferando en los pasillos. Ella refiere que existe una asociación ilícita para explotar personas, en la que estarían involucrados el conserje, el administrador y varios de los copropietarios del edificio. Fuera de eso, no hay mayor afectación y se desenvuelve normalmente en su trabajo. Los familiares niegan las acusaciones. Al ser consultada dirigidamente, ella refiere el antecedente de consumir marihuana alrededor de una vez al mes. El diagnóstico más probable es:

A) Depresión psicótica
B) Trastorno delirante crónico
C) Esquizofrenia
D) Psicosis inducida por drogas
E) Trastorno bipolar

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno delirante crónico (opción B). Tiene un TDC, con delirio paranoide.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 110 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 42 años, que 2 meses después de una separación conyugal, evoluciona con un cuadro de delirio paranoide y alucinaciones auditivas. Además presenta marcada tristeza, anhedonia, irritabilidad y culpa patológica. Como antecedentes psiquiátricos, ella sufrió una depresión postparto y uno de sus tíos está en tratamiento con litio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Depresión psicótica
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno esquizoafectivo
D) Esquizofrenia
E) Trastorno esquizoide de la personalidad

Respuesta D. Hay una mezcla de síntomas psicóticos (delirio paranoide y alucinaciones auditivas) con un síndrome afectivo completo (tristeza, anhedonia, culpa), sin predominio claro de uno de ellos, lo que orienta a un trastorno esquizoafectivo. La depresión psicótica y el trastorno bipolar explican los síntomas psicóticos solo durante el episodio anímico, y la esquizofrenia no incluye un síndrome afectivo de

5.01.1.011 Consumo perjudicial de alcohol y drogas

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Consumo perjudicial: patrón de uso de alcohol o drogas que ya causa daño físico, mental o social (gastritis, accidentes, conflictos, conducción en estado de ebriedad) sin criterios de dependencia (sin tolerancia, abstinencia ni pérdida de control marcada).
- Pesquisa en APS con AUDIT (alcohol) o ASSIST (otras sustancias): AUDIT 0–7 bajo riesgo, 8–15 consumo de riesgo, 16–19 perjudicial, ≥20 probable dependencia; complementar con GGT/VCM y evaluación clínica.
- Tratamiento: intervención breve con entrevista motivacional según la etapa de cambio (precontemplación, contemplación, preparación, acción, mantención), sin confrontar; metas concretas de reducción o abstinencia.
- No corresponde iniciar disulfiram ni benzodiacepinas; tratar comorbilidad (depresión, ansiedad) y daño orgánico, y pesquisar otras sustancias.
- Seguimiento completo: controles programados para reforzar metas y registrar consumo; derivar a programa especializado si progresa a dependencia o fracasa la intervención breve.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 73 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 35 años es traída al servicio de urgencia debido a que, luego del consumo de alcohol en una fiesta, presentó una actitud agresiva peleando con otros invitados, a quienes arrojó vasos de vidrio, por lo que fue retirada del lugar. Refiere que consume alcohol de manera esporádica, habitualmente solo durante los fines de semana, y que lo hace como una forma de distenderse de su alta carga laboral. En una oportunidad fue detenida por manejar en estado de ebriedad, sin embargo, ella no considera que ello sea un problema. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Iniciar disulfiram vía oral
B) Indicar benzodiacepinas vía oral
C) Iniciar bupropión vía oral
D) Realizar entrevista mo2vacional
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta D. La paciente tiene consumo perjudicial de alcohol con escasa conciencia del problema, es decir, está en etapa precontemplativa, por lo que primero se debe trabajar la motivación al cambio con entrevista motivacional. Los fármacos y la psicoterapia no sirven si no hay intención de cambiar, y las benzodiacepinas no están indicadas sin síndrome de abstinencia.

Pregunta de práctica

Hombre de 34 años consulta por epigastralgia. Bebe casi todos los fines de semana, 8 a 10 tragos por ocasión, y hace 3 meses fue detenido por conducir bajo la influencia del alcohol. Niega temblor matinal, beber al despertar o intentos fallidos de dejarlo. Reconoce que 'debería tomar menos'. El AUDIT da 17 puntos. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Iniciar disulfiram 250 mg al día
B) Intervención breve con entrevista motivacional, metas de reducción y controles de seguimiento en APS
C) Indicar naltrexona y control en 6 meses
D) Hospitalizar para desintoxicación con diazepam
E) Tranquilizar, ya que solo bebe los fines de semana

Respuesta B. AUDIT 16–19 con daño ya presente y sin tolerancia ni abstinencia corresponde a consumo perjudicial. El paciente está en etapa contemplativa: se trata con intervención breve y entrevista motivacional, metas concretas y seguimiento. No requiere desintoxicación ni fármacos de deshabituación, y minimizarlo es un error.

5.01.1.012 Dependencia de alcohol

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- Dependencia de alcohol: tolerancia, abstinencia, consumo mayor al planeado, deseo persistente o fracaso al reducir, tiempo dedicado al consumo, abandono de actividades y persistencia pese al daño. Pesquisa con AUDIT (≥20 probable dependencia).
- Abstinencia: temblor y disautonomía a las 6–12 h, alucinosis con sensorio lúcido a las 12–24 h, convulsiones a las 12–48 h y delirium tremens a las 48–96 h (confusión, zoopsias, fiebre; mortalidad hasta 15%).
- Tiamina 100–300 mg EV/IM siempre antes de cualquier suero glucosado; Wernicke: oftalmoplejía, ataxia y confusión. Korsakoff: amnesia anterógrada con confabulación.
- Abstinencia según CIWA-Ar: <10 manejo ambulatorio sin benzodiacepinas; 10–19 diazepam 10–20 mg VO c/1–2 h; ≥20 hospitalizar. Lorazepam en cirróticos y ancianos. Convulsiones: benzodiacepinas, no fenitoína crónica.
- Deshabituación: entrevista motivacional y programa de tratamiento; naltrexona 50 mg/día (reduce craving; no con opioides ni hepatitis), acamprosato (seguro en daño hepático) o disulfiram 250 mg/día supervisado en paciente motivado.
- Seguimiento completo: controles para prevenir recaídas, tratar comorbilidad psiquiátrica y orgánica, apoyo familiar y grupos de autoayuda; derivar si hay complicaciones o fracaso.

PREGUNTAS (5)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 103

Paciente de 55 años alcohólico crónico, 48 horas después de dejar de beber presenta agitación severa, alucinaciones visuales de insectos, temblor generalizado, taquicardia 120 lpm, sudoración y fiebre 38°C. **¿Cuál es el diagnóstico y tratamiento?**

A) Delirium tremens: diazepam EV + tiamina + corrección hidrolectrolítica
B) Psicosis alcohólica: haloperidol
C) Meningoencefalitis: antibióticos EV
D) Hipoglicemia: glucosa EV en bolo
E) ACV isquémico: tPA

Respuesta A. Abstinencia alcohólica grave a las 48–72 horas del cese, con hiperactividad autonómica y alucinaciones: delirium tremens. Es la única indicación de benzodiacepinas en el delirium (diazepam o lorazepam), junto con tiamina y corrección hidroelectrolítica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 72 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 70 años, con antecedente de daño hepático crónico y consumo de alcohol activo, consulta porque quiere dejar de beber. Consume 3 litros de cerveza al día y comenta que hace un año intentó bajar el consumo a 1 litro al día, sin embargo, presentó agitación, angustia y la visualización de insectos que él no sabía que no eran reales. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Indicar el cese inmediato del consumo de alcohol
B) Iniciar disulfiram
C) Hospitalizar para desintoxicación
D) Indicar lorazepam
E) Derivar para psicoterapia cogni2vo-conductual

Respuesta C. Tiene alcoholismo con consumo alto y motivación para dejar de beber, pero con antecedente de síndrome de abstinencia grave con alucinaciones (visualiza insectos), por lo que la suspensión debe hacerse con supervisión médica en el hospital. Indicar el cese inmediato en domicilio es riesgoso por la posibilidad de delirium tremens. El disulfiram no se inicia en un paciente con daño hepático, y la psi

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Paciente con hálito alcohólico en urgencias; TAC descarta lesiones. A las 48 horas, agitación y desorientación. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Haloperidol 5 mg IM
B) Tiamina 100 mg EV
C) Suero glucosado 10% endovenoso
D) Metadona oral
E) Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica)

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica) (opción E). Lorazepam endovenoso (manejo de síndrome de abstinencia alcohólica). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 36 · texto original del banco, sin revisar

Paciente masculino con consumo OH crónico, pierde su trabajo, se fractura tobillo y se hospitaliza, pide alta voluntaria para ir a tomar cerveza, qué conducta define mejor la “adicción” x OH:

A) La conducta durante la hospitalización
B) Pérdida de trabajo
C) Embriaguez
D) La frecuencia del consumo
E) Laparotomía exploratoria

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: La conducta durante la hospitalización (opción A). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente alcohólico es ingresado, indicándosele tratamiento con diazepam 0,5 mg/noche y haloperidol 0,5 mg/noche. Evoluciona con sudoración, inquietud, palpita- ciones e insomnio con angustia que es mayor en la noche,

A) Acatisia
B) Síndrome de privación de alcohol
C) Síndrome neuroléptico maligno
D) Distonía aguda
E) Diquinesia aguda

Respuesta B. Es un síndrome de abstinencia moderado. No tiene delirium tremens, ni convul- siones (sería severo).

5.01.1.013 Dependencia de otras drogas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Dependencia de drogas (cocaína, pasta base, cannabis, benzodiacepinas, opioides): tolerancia, abstinencia, craving, pérdida de control, abandono de actividades y consumo pese al daño.
- Sospecharla ante deterioro laboral o académico, conflictos, delitos, síntomas de intoxicación o abstinencia repetidos, psicosis o complicaciones médicas (dolor torácico por cocaína, infecciones).

- Pasta base y cocaína: abstinencia con disforia, hipersomnia y craving intenso; benzodiacepinas: abstinencia con riesgo de convulsiones si se suspenden bruscamente (reinstalar diazepam o clonazepam y reducir 10–25% semanal).
- Manejo inicial: evaluar riesgo suicida, comorbilidad psiquiátrica (dual) y médica, tamizaje de VIH, hepatitis y sífilis; entrevista motivacional sin confrontar.
- Seguimiento: derivar a programa especializado de tratamiento de drogas (COSAM, programas con convenio SENDA, ambulatorio intensivo o residencial según gravedad); garantía GES en menores de 20 años con consumo de riesgo bajo a moderado.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 149 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente consulta porque quiere dejar de fumar. Fuma cerca de 10 cigarrillos al día, especialmente cuando está más nervioso, los fines de semana y en las reuniones sociales. Disfruta del cigarrillo y no cree que podrá dejar de fumar sin apoyo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en este paciente?

A) Terapia cognitiva conductual
B) Parches de nicotina
C) Bupropión
D) Fluoxetina
E) Vareniclina

Respuesta A. La base del tratamiento de todas las adicciones es la TCC. Además, en fumadores de menos de 15 cigarrillos al día suele ser la única intervención necesaria, ya que no suelen tener dependencia física a la nicotina. Sobre esa cantidad, a la TCC se le suele agregar sustitución con nicotina (si muchos síntomas de abstinencia) y bupropión o vareniclina (si mucho deseo de fumar).

Pregunta de práctica

Hombre de 26 años consulta acompañado de su madre. Fuma pasta base a diario desde hace 2 años; necesita cada vez más para el mismo efecto, ha intentado dejarla 3 veces sin lograrlo, perdió su trabajo y vendió objetos de la casa. Refiere craving intenso y quiere recibir ayuda. Niega ideación suicida; examen físico normal. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar clonazepam diario y control en 3 meses
B) Indicar disulfiram para generar aversión al consumo
C) Iniciar metadona en APS
D) Hospitalizar en psiquiatría en forma involuntaria
E) Evaluar comorbilidad y riesgo, realizar entrevista motivacional y derivar a un programa especializado de tratamiento de drogas

Respuesta E. Tolerancia, fracaso para dejarla, abandono de actividades y craving configuran una dependencia de pasta base. El médico general sospecha, evalúa riesgo y comorbilidad, motiva y deriva a un programa especializado. No hay fármaco de sustitución para la cocaína: la metadona es para opioides y el disulfiram para alcohol; las benzodiacepinas crónicas agregan otra dependencia y no hay criterio de hospitalización involuntaria.

5.01.1.014 Delirium

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Delirium: alteración aguda (horas a días) y fluctuante de la atención y la conciencia, con desorientación, desorganización del pensamiento y alucinaciones visuales; empeora de noche. Diagnóstico con CAM: inicio agudo y fluctuante + inatención + (pensamiento desorganizado o conciencia alterada).
- Formas hiperactiva, hipoactiva (la más subdiagnosticada) y mixta; factores de riesgo: edad avanzada, demencia, polifarmacia, déficit sensorial, hospitalización y cirugía.
- Buscar siempre la causa: glicemia capilar, saturación, infección (ITU, neumonía), retención urinaria, fecaloma, dolor, deshidratación, electrolitos, fármacos anticolinérgicos o benzodiacepinas, abstinencia de alcohol.
- Tratamiento: corregir la causa y medidas no farmacológicas (orientación, lentes y audífonos, luz de día, familia, evitar contención física); si hay agitación con riesgo, haloperidol 0,5–1 mg VO/IM o quetiapina 25 mg.
- Benzodiacepinas contraindicadas, salvo en abstinencia alcohólica o de benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar o hospitalizar según la causa; tras la resolución evaluar deterioro cognitivo de base (el delirium aumenta el riesgo de demencia).

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 168

Una paciente de 78 años con diagnóstico de enfermedad de Alzheimer es hospitalizada tras desorientarse y agredir a sus cuidadores. En el examen mental se encuentra desorientada en tiempo y espacio, no puede decir los días de la semana en orden inverso y no es capaz de recordar tres palabras que se le dicen en voz alta. Dice ver a su padre en la habitación y, tras el ingreso al hospital, comienza a gritar, exigiendo que la suelten y que se quiere ir del hospital. **¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo inicial?**

A) Clonazepam
B) Carbamazepina
C) Haloperidol
D) Mirtazapina
E) Diazepam

Respuesta C. Delirium sobreimpuesto a demencia (inatención: no dice los días en orden inverso; alucinaciones visuales; agitación). Además de tratar la causa, la agitación grave se maneja con haloperidol en dosis bajas (0,5–1 mg VO o IM). Las benzodiacepinas están contraindicadas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 148 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 56 años es encontrado inconsciente en la vía pública, con hálito alcohólico, con varios golpes. Se hospitaliza para manejo de sus lesiones, sin embargo, a las 48 horas presenta gran agitación, diciendo que lo tienen encerrado en la cárcel y no lo dejan escapar. Se observa desorientado, tembloroso y no coopera con el interrogatorio. ¿Cuál es el fármaco de elección para su manejo?

A) Tiamina
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Clorpromazina
E) Risperidona

Respuesta A. Conducta / Tratamiento indicado: Tiamina (opción A). Tratamiento demencia: multidisciplinario + evitar estrés del cuidador + donepesilo (inhibidor acetilcolinesterasa, de elección) o memantina. De acuerdo con las guías ministeriales de Chile, esta es la intervención que reduce morbilidad y mortalidad.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 24 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 77 años con enfermedad de Alzheimer inicial, en tratamiento con donepezilo 10 mg durante el día y trazodona 50 mg por la noche, presenta dos semanas de agitación nocturna asociada a la idea de que le están robando. Esto ha generado conflictos con sus cuidadores y, además, no ha permitido que lo bañen. Desde hace dos días presenta alucinaciones visuales. El resto de su examen físico es normal y su examen neurológico no tiene signos focales. Además de realizar exámenes, en busca de un foco infeccioso, ¿qué fármaco es de elección para su manejo actual?

A) Diazepam
B) Haloperidol
C) Lorazepam
D) Risperidona
E) Amitrip2lina

Respuesta B. Pregunta difícil y discutible. Claramente Gene un delirium y hay que darle un antipsicótico. El clásico que se ha usado siempre es el haloperidol, pero los antipsicóticos atípicos, como la risperidona, cuentan con buena evidencia y seguridad. En Parkinson y demencia por cuerpos de Lewy, se contraindica el haloperidol e incluso la risperidona por el riesgo de síntomas extrapiramidales y la respuest

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 37 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente se hospitaliza hace 48 horas, por un traumatismo, secundario a un accidente de tránsito. Como antecedente, toma 1 botella de vino al día, sin llegar a la ebriedad. Al segundo día de ingreso presenta un cuadro de agitación psicomotora, desorientación temporoespacial, temblor y alucinaciones visuales zoomórficas. ¿Cuál es el tratamiento más adecuado?

A) Haloperidol
B) Lorazepam
C) Risperidona
D) Carbamacepina
E) Tiamina

Respuesta B. Tiene un delirium tremens clásico, que se trata con benzodiacepinas, en especial el diazepam. El lorazepam también es útil y es el de elección en el DHC.

5.01.1.015 Trastornos neurocognitivos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno neurocognitivo mayor (demencia): declive cognitivo objetivo que interfiere con la autonomía en actividades instrumentales (dinero, medicamentos); el menor (deterioro cognitivo leve) tiene déficit objetivo con autonomía preservada.
- Tamizaje: MMSE (corte <24, ajustado por escolaridad; en EMPAM el Minimental abreviado <13 se complementa con Pfeffer ≥6) y MoCA (<26, más sensible para deterioro leve). Diferenciar de delirium (agudo, fluctuante) y depresión.
- Estudio de causas reversibles siempre: TSH, B12, VDRL, hemograma, electrolitos, función renal y hepática, y TAC o RM sin contraste (hematoma subdural crónico, tumor, hidrocefalia normotensiva: marcha magnética, incontinencia y demencia).
- Alzheimer leve a moderado: donepezilo 5→10 mg/día con ECG basal (bradicardia); MMSE <15: agregar memantina. En deterioro cognitivo leve no se indican inhibidores de acetilcolinesterasa.
- Síntomas conductuales: primero medidas no farmacológicas y buscar dolor, retención o infección; si persisten, quetiapina 12,5–25 mg o risperidona 0,25–0,5 mg (riesgo de ACV y mortalidad). Nunca benzodiacepinas.
- Seguimiento: derivar a neurología/geriatría según GES; apoyo al cuidador (escala de Zarit).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 76 años, traída por su hija por olvidos progresivos de 2 años de evolución. Desde hace 6 meses ya no puede manejar sus finanzas ni sus medicamentos y se ha perdido en su barrio. Está vigil, sin fluctuaciones de conciencia ni focalidad neurológica. MoCA 16/30, tamizaje de depresión negativo y exámenes metabólicos normales. **¿Cuál es el diagnóstico sindromático más adecuado?**

A) Trastorno neurocognitivo leve
B) Pseudodemencia depresiva
C) Delirium
D) Trastorno neurocognitivo mayor (demencia)
E) Envejecimiento cognitivo normal

Respuesta D. Según DSM-5, el trastorno neurocognitivo mayor es un declive cognitivo significativo que interfiere con la independencia en actividades instrumentales (finanzas, medicamentos). En el leve hay declive objetivo pero se conserva la autonomía. La evolución insidiosa, sin fluctuaciones ni alteración de conciencia, descarta delirium.

5.01.1.016 Trastornos de la personalidad

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de personalidad: patrón perdurable, inflexible y generalmente egosintónico de vivir y relacionarse, que se inicia en la adolescencia o adultez joven y causa malestar o deterioro.
- Clúster A (raros): paranoide (suspicacia, sin delirio), esquizoide (no desea relaciones), esquizotípico (pensamiento mágico, excentricidad). Clúster B (dramáticos): límite, antisocial (≥18 años con trastorno de conducta antes de los 15), histriónico, narcisista.
- Clúster C (ansiosos): evitativo (desea vínculos pero teme el rechazo), dependiente, obsesivo-compulsivo (perfeccionismo egosintónico, sin obsesiones ni rituales, a diferencia del TOC).
- Límite: inestabilidad afectiva y de relaciones, miedo al abandono, impulsividad, autolesiones, intentos suicidas y vacío crónico; ante gestos suicidas, observación protegida y evaluación psiquiátrica antes del alta.
- Manejo inicial: actitud empática, firme y no punitiva, manejo de crisis y de comorbilidad (depresión, consumo); la psicoterapia es el tratamiento de base (terapia dialéctico-conductual en el límite); fármacos solo sintomáticos y acotados.
- Seguimiento: derivar a salud mental especializada.

PREGUNTAS (7)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 79

Una paciente tiene relaciones interpersonales intensas e inestables y problemas frecuentes con las demás personas. Presenta antecedentes de 2 intoxicaciones medicamentosas y autoagresiones. Además, estuvo en tratamiento por bulimia hace 1 año. Tiene un sentimiento crónico de inutilidad y vacío, y es impulsiva en el consumo de alcohol y en las compras.

¿A qué trastorno de la personalidad corresponde el cuadro?

A) Histriónico
B) Limítrofe
C) Narcisista
D) Antisocial
E) Dependiente

Respuesta B. Relaciones intensas e inestables, impulsividad (alcohol, compras, atracones), autoagresiones e intentos suicidas reiterados y sentimiento crónico de vacío son los rasgos nucleares del trastorno límite de la personalidad. El tratamiento de elección es la psicoterapia, como la terapia dialéctico-conductual.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 132 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 32 años, madre de 4 hijos, de distintos padres, de los cuales no se hace cargo, tiene relaciones inestables y problemas frecuentes con sus compañeros de trabajo. Pelea frecuentemente con su familia y como antecedente, ha tenido varios episodios de autoagresión e intentos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno límite de la personalidad
C) Trastorno bipolar
D) Trastorno delirante
E) Trastorno depresivo mayor

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno límite de la personalidad (opción B). Es un TP limítrofe clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 98 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 30 años, consulta debido a que se siente deprimido. Es padre de tres hijos con tres mujeres diferentes, tiene antecedentes de múltiples fracasos académicos y laborales y se encuentra sin actividad laboral en la actualidad. Al interrogatorio, consume alcohol con cierta frecuencia, bebiendo 3 o 4 días a la semana en cantidad que él considera moderada, aunque reconoce que se emborracha los fines de semana. Además, con frecuencia se involucra en actividades riesgosas y presenta una autoimagen negativa. En el pasado, ha tenido ideación suicida con autoagresión, aunque no la tiene en la actualidad. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Esquizofrenia
B) Trastorno de conducta
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno adaptativo

Respuesta C. Trastorno de Personalidad Límite: El caso presentado describe un trastorno de personalidad límite clásico. Se recomienda revisar el resumen de psiquiatría.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 112 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años tiene problemas frecuentes con sus familiares, con quienes suele pelearse y distanciarse, pero luego de algunos meses retoma la relación, como si nada hubiese pasado. Además tiene antecedente de haber ingerido medicamentos con intención suicida y haberse autoagredido. Además ha cambiado varias veces de trabajo, ya que le cuesta atenerse a las normas, lo que le ha generado problemas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adaptativo
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno bipolar
D) Distimia
E) Depresión mayor

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno de personalidad limítrofe (opción B). Es un clásico trastorno limítrofe de la personalidad.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 84 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente que desde niña es muy tímida, tiene dificultades para relacionarse con otras peronsonas, por temor al rechazo. No ha tenido pareja y evita las situaciones en que hay muchas personas. Le gustaría mejorar su situación y desarrollar su autoestima. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno de personalidad evitativo
B) Trastorno de personalidad dependiente
C) Fobia social
D) Agorafobia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno de personalidad evitativo (opción A). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 58 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 23 años quien, desde la niñez es extremadamente introvertida y con baja autoestima por lo que se le es difícil conseguir amigos, por miedo a que pensarán de ella, esto la hace infeliz. En cambio, con su familia es muy cariñosa. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno evitativo de la personalidad
B) Síndrome de Asperger
C) Depresión mayor
D) Distimia
E) Fobia social

Respuesta A. Es un trastorno evitativo clásico (inicio temprano, pocos amigos, etc.), aunque puede confundirse con una fobia social, sin embargo, en la fobia social sí tienen amigos, solo que no hacen cosas frente a ellos, en las que los puedan juzgar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 122 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 28 años tiene relaciones amorosas muy intensas, se viste muy provocativa y es muy coqueta, lo que le ha traído problemas con sus pares a las que ella las llama “envidiosas”. Durante la entrevista es muy exagerada al contar sus problemas. El trastorno de la personalidad más probable en este caso es:

A) Narcisista
B) Limítrofe
C) Histriónico
D) Dependiente
E) Antisocial

Respuesta C. Tiene mezcla de narcisismo (envidia), limítrofe (intensas), pero más de histriónica (provocativa al vestir, coqueta, exagerada).

5.01.1.017 Disfunción sexual

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: psiq-20

QUÉ HAY QUE SABER

- Disfunciones sexuales: trastornos del deseo (hipoactivo), excitación (disfunción eréctil, excitación femenina), orgasmo (anorgasmia, eyaculación precoz o retardada) y dolor genito-pélvico/penetración (vaginismo, dispareunia), persistentes ≥6 meses y con malestar.
- Sospecharlas preguntando activamente en la anamnesis; buscar causas orgánicas (diabetes, enfermedad vascular, hipogonadismo, neuropatía, menopausia con atrofia vulvovaginal) y fármacos (ISRS, antipsicóticos, betabloqueadores, antiandrógenos).
- Factores psicológicos y relacionales: ansiedad de desempeño, depresión, conflictos de pareja, antecedente de abuso sexual.
- Manejo inicial: psicoeducación, abordaje de la pareja, tratar la causa orgánica o ajustar el fármaco (bupropión o mirtazapina tienen menos efecto sexual que ISRS); disfunción eréctil: inhibidores de PDE5 si no hay nitratos.
- Seguimiento: derivar a sexología/psiquiatría, ginecología o urología según el tipo y la causa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 162

Paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta B. El DSM-5 agrupa la dispareunia y el vaginismo en el trastorno por dolor genito-pélvico/penetración: dolor o temor a la penetración por al menos 6 meses, con malestar significativo, sin causa orgánica que lo explique. La evitación de las relaciones es secundaria al dolor, no a falta primaria de deseo.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 161 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 33 años consulta por un cuadro de 6 meses de evolución de dolor durante la penetración en las relaciones sexuales, por lo cual se ha negado a mantenerlas en el último mes. Su examen físico no muestra alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno orgásmico femenino
B) Trastorno por dolor genito-pélvico/penetración
C) Trastorno depresivo mayor
D) Trastorno por somatización
E) Trastorno del deseo sexual hipoactivo

Respuesta B. Dispareunia/Vaginismo: El trastorno por dolor genito-pélvico/penetración (dispareunia superficial o vaginismo) se caracteriza por contracción involuntaria de los músculos vaginales, causando dolor durante la penetración. Difiere del trastorno orgásmico (ausencia de orgasmo) y del deseo hipoactivo (disminución del deseo).

5.01.1.018 Trastornos de la conducta alimentaria

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Anorexia nerviosa: restricción con peso significativamente bajo (IMC <18,5 en adultos o bajo p5 en niños), miedo intenso a engordar y distorsión de la imagen corporal; subtipos restrictivo y purgativo.
- Signos de desnutrición: bradicardia, hipotensión ortostática, hipotermia, lanugo, piel amarillenta por carotenemia, amenorrea y osteoporosis.
- Hospitalizar de inmediato si IMC <14 (o pérdida >20% en 3 meses), FC <40, PAS <80/50, QTc >460 ms, hipokalemia, hipofosfatemia o hipoglicemia; realimentación lenta con fósforo, magnesio y tiamina para prevenir el síndrome de realimentación (hipofosfatemia).
- Bulimia: atracones con conductas compensatorias ≥1 vez por semana por 3 meses, con peso normal o sobrepeso; signo de Russell, erosión dental e hipertrofia parotídea; hipokalemia por vómitos. Fluoxetina 60 mg/día más TCC.
- Trastorno por atracón: atracones sin conductas compensatorias, con sobrepeso u obesidad.
- Seguimiento: derivar a equipo especializado en TCA; controlar peso, signos vitales y electrolitos mientras tanto.

PREGUNTAS (8)

Pregunta del libro · Tema 17.18

Una adolescente de 16 años consulta traída por su colegio debido a emaciación progresiva. Al examen físico destaca con IMC de 13.5 kg/m², hipotermia de 35.0 °C, presión arterial de 75/45 mmHg y frecuencia cardíaca de 34 lpm en reposo. Se constata lanugo en espalda y abdomen escafoide. La paciente rechaza tener problemas y afirma que solo desea "bajar un par de kilos más". ¿Cuál es la conducta médica inmediata e ineludible?

A) Indicar dieta hipercalórica fraccionada y citar a control en un mes en policlínico
B) Hospitalización médica inmediata en unidad de cuidados intensivos/intermedios para monitorización cardíaca y realimentación lenta controlada
C) Prescribir Fluoxetina 60 mg al día por vía oral y dar el alta a su domicilio
D) Derivar a psicoterapia psicoanalítica ambulatoria semanal
E) Indicar Metilfenidato matinal para mejorar su motivación de alimentarse

Respuesta B. La paciente presenta una Anorexia Nervosa severa con criterios de hospitalización médica inmediata de urgencia: desnutrición crítica (IMC 13.5 < 14 kg/m²), bradicardia extrema (< 40 lpm: 34 lpm), hipotensión severa (75/45 mmHg) e hipotermia. Estas alteraciones confieren un riesgo inminente de arritmias ventriculares letales, asistolia y colapso circulatorio. La única conducta admisible es la hospitalización inmediata en cama monitorizada (pediatría/UPC), con estabilización hemodinámica y protocolo de realimentación enteral lenta y progresiva con control estricto de fósforo para prevenir el síndrome de realimentación. La fluoxetina ambulatoria (C) o el manejo en casa (A y D) constituyen una negligencia médica con desenlace potencialmente fatal. Perla de examen: En anorexia nervosa, un IMC < 14 kg/m² o bradicardia < 40 lpm obligan a la hospitalización médica inmediata en cama monitorizada.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 145 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 17 años es traída por su padre, quien se muestra muy preocupado porque la considera muy delgada y siente que come muy poco. Relata que solo come una fracción del plato que se sirve en su casa y que deja gran parte de la comida que se le envía al colegio. La paciente comenta que la mayoría de sus compañeras son igualmente delgadas y no considera que tenga un problema, más allá de mostrarse molesta por la insistencia de su padre en consultar. Su IMC es de 16 kg/m². ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno obsesivo de la personalidad
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Dismorfofobia
E) Sana

Respuesta C. Es una anorexia nerviosa clásica (anorexia nervosa en latín) con restricción alimentaria, bajo peso (IMC 16 kg/m²), minimización del problema, normalización de la delgadez y escasa conciencia de problema. Las niñas y adolescentes son el grupo en el que suele comenzar.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 4 · texto original del banco, sin revisar

Mujer de 17 años, con IMC 15.5 kg/m², niega sentirse enferma, refiere que todas sus amigas hacen lo mismo, realiza ejercicio intenso a diario y come menos de un cuarto de su ración habitual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Anorexia nerviosa
B) Bulimia nerviosa
C) Trastorno por atracón
D) Depresión mayor con anhedonia
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta A. Bajo peso severo + restricción alimentaria voluntaria + negación de la enfermedad + ejercicio compulsivo = anorexia nerviosa restrictiva.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 168 · texto original del banco, sin revisar

Una niña de 15 años presenta disconformidad con su cuerpo, por lo que lo oculta, utilizando ropa 2 o 3 tallas más grandes. Además, tiene retraimiento social y gran preocupación por las calorías que ingiere. Los padres refieren que anda con náuseas en el último tiempo, por lo que come poco y ha bajado de peso. Sin embargo ella se había negado a acudir al médico. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno distímico
B) Trastorno alimentario mixto
C) Anorexia nervosa
D) Trastorno depresivo mayor
E) Bulimia nervosa

Respuesta C. Es una forma clásica de presentación de la anorexia, aunque no muestren todos los criterios (bajo peso, preocupación por el peso, alteración de la percepción corporal y amenorrea). Es frecuente que la paciente lo oculte, mienta o manipule a la familia, para que no la obliguen a subir de peso.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 45 · texto original del banco, sin revisar

Paciente de 23 años, que desde hace 6 meses experimenta desánimo, que ella dice que es causado por estar muy disconforme con su figura. Refiere que experimenta momentos en que come muchas galletas, sin parar, hasta ser imposible seguir comiendo, en especial cuando está ansiosa. Además, tiene miedo de reprobar en la universidad. Refiere que 3 veces por semana, puede trotar 5 horas y comer menos de 200 Calorías al día. Niega provocarse vómitos, ya que refiere que no puede inducírselos, aunque ha intentado. ¿Cuál es el diagnóstico de sospecha?

A) Anorexia nervosa
B) Trastorno por atracones
C) Depresión mayor
D) Bulimia nervosa
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta D. Es una bulimia, con los atracones característicos y además con la purga, por medio de ejercicios y ayuna (no solo se purga con vómitos o laxantes).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 76 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál de los siguientes hallazgos del examen físico sugieren un trastorno de conducta alimentaria en una adolescente?

A) IMC de 20
B) Hipertrofia de las parótidas
C) Telangiectasias periorales
D) Pulso dicroto
E) Hiperpigmentación areolar

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Hipertrofia de las parótidas (opción B). La hipertrofia de parótidas es un signo de vómitos recurrentes.. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 80 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 17 años ha bajado 15 kilogramos en el último tiempo. Su IMC actual es de 16. Tiene mucho miedo a engordar y de hecho quiere bajar un poco más de peso, por lo que luego de comer se induce vómitos, con mucha frecuencia. Está en amenorrea desde hace 4 meses. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno alimentario no especificado
B) Bulimia nervosa
C) Anorexia nervosa
D) Depresión mayor
E) Distimia

Respuesta C. Diagnóstico: Anorexia nervosa (opción C). La purga no es exclusiva de la bulimia. La anorexia puede tenerla.. 1. Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil V3 ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 141 · texto original del banco, sin revisar

Femenina con atracones, luego salía a correr 5 hrs y consumía 200 kcal/día, intentaba vomitar pero no podía:

A) Bulimia nerviosa
B) Anorexia
C) Trastorno por atracones
D) Ninguna de las anteriores es correcta
E) Todas las anteriores son correctas

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Bulimia nerviosa). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh. Las opciones alternativas (Anorexia, Trastorno por atracones) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que no concuerdan con la presentación del paciente.

5.01.1.019 Sexualidad humana y sus alteraciones

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: psiq-20

QUÉ HAY QUE SABER

- La sexualidad humana integra dimensiones biológicas, psicológicas y sociales (sexo asignado, identidad de género, orientación sexual y expresión de género); la diversidad sexual no es patología.

- Alteraciones: disfunciones sexuales, parafilias (interés sexual atípico intenso) y trastorno parafílico cuando causa malestar o daño a terceros (pedofilia, exhibicionismo, voyeurismo, frotteurismo).
- Sospechar ante consultas indirectas (insomnio, conflictos de pareja, ansiedad), uso de fármacos con efecto sexual o conductas de riesgo; preguntar con lenguaje neutro y confidencial.
- Manejo inicial: escucha sin juicio, psicoeducación, descartar causas orgánicas y farmacológicas, consejería en prevención de ITS y anticoncepción.
- Conductas parafílicas que dañan a terceros (abuso de menores) obligan a protección de la víctima y denuncia; nunca 'terapias de conversión' para la orientación sexual.
- Seguimiento: derivar a sexología o psiquiatría para el tratamiento especializado.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 30 años, derivado por orden judicial. Desde hace 2 años presenta fantasías e impulsos sexuales intensos y recurrentes de mostrar sus genitales a mujeres desconocidas en la vía pública, y lo ha hecho en varias ocasiones. Refiere culpa posterior. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
> **A)** Trastorno frotteurista
> **B)** Trastorno voyeurista
> **C)** Trastorno exhibicionista
> **D)** Trastorno fetichista
> **E)** Trastorno de travestismo
> Respuesta C. Las parafilias son intereses sexuales atípicos; se diagnostican como trastorno parafílico cuando por al menos 6 meses causan malestar, deterioro o se han ejecutado con personas que no consienten. Exponer los genitales a desconocidos es exhibicionismo; observar a otros desnudarse es voyeurismo y tocar o rozar a alguien sin consentimiento es frotteurismo.

5.01.1.020 Trastornos somatomorfos

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.5 Trastorno Depresivo Persistente (Distimia) y Trastorno Adaptativo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno de síntomas somáticos (somatización): múltiples síntomas físicos recurrentes de distintos sistemas, por años, con pensamientos, ansiedad o conductas excesivas respecto a ellos, consultas reiteradas y procedimientos innecesarios.
- Variantes: trastorno de ansiedad por enfermedad (hipocondría: miedo a tener una enfermedad grave con pocos síntomas) y trastorno de conversión o neurológico funcional (parálisis, crisis no epilépticas, ceguera sin correlato orgánico).
- Los síntomas no son voluntarios: diferenciar del trastorno facticio (producción intencional para asumir el rol de enfermo) y de la simulación (incentivo externo).
- Descartar enfermedad orgánica con un estudio razonable y no repetitivo; pesquisar depresión y ansiedad comórbidas.
- Manejo inicial: un médico tratante de cabecera, controles programados (no a demanda), validar el malestar sin reforzar exámenes, explicar el origen funcional, TCC; ISRS si hay depresión o ansiedad asociada.
- Seguimiento: derivar a salud mental si el cuadro es grave, hay deterioro importante o comorbilidad.

PREGUNTAS (6)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2016 · Pregunta 57

Paciente de 33 años que hace 5 años comienza con síntomas recurrentes y variables: molestias genitourinarias y gastrointestinales, asociadas a mareos y prurito. Ha consultado en reiteradas ocasiones a especialistas, quienes han descartado enfermedad orgánica, llegando incluso a realizarse una laparoscopía exploradora sin alteraciones. Sus síntomas le impiden trabajar. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Hipocondría
B) Trastorno facticio
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno de somatización
E) Simulación

Respuesta D. Múltiples síntomas somáticos de distintos sistemas, recurrentes por años, sin causa orgánica, con consultas reiteradas, procedimientos innecesarios y deterioro funcional definen el trastorno de somatización (hoy trastorno de síntomas somáticos). En la hipocondría predomina el miedo a tener una enfermedad grave; en el facticio y la simulación los síntomas se producen voluntariamente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 39 años es despedida de su trabajo y, a las pocas horas, presenta imposibilidad de realizar movimientos con ambas manos. Al examen físico tiene tono muscular y reflejos normales. Además, llama la atención la falta de concordancia entre el relato de los síntomas y la actitud de la paciente, que se ve muy tranquila con lo que sucede. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno dismórfico corporal
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno facticio
D) Trastorno somatomorfo
E) Trastorno disociativo

Respuesta B. Es un trastorno conversivo típico: síntomas neurológicos de inicio rápido y sin una causa orgánica que los explique. En estricto rigor sí es un trastorno somatomorfo (D), ya que los trastornos conversivos son un tipo de trastornos somatomorfos, pero la B es más específica.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 88 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años presenta cefalea, náuseas, mareos y epigastralgia, de dos años de evolución. Cuenta con múltiples exámenes que descartan causa orgánica, sin embargo, él insiste en exigir más estudios. No se identifica ánimo de obtener alguna ganancia. El diagnóstico más probable es un trastorno:

A) Depresivo mayo
B) Delirante
C) Obsesivo compulsivo
D) De somatización
E) Facticio

Respuesta D. Diagnóstico: De somatización (opción D). Tiene un T. de somatización clásico. Por no tener ánimo ganancial, no es facticio.. Los trastornos somatomorfos se caracterizan por síntomas físicos (somáticos) sin causa orgánica que los explique completamente, de causa psíquica (generalmente estrés). Los hallazgos descritos en el caso concuerdan exactamente con esta entidad clínica en el marco del Perfil

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 142 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 41 años que trabaja como ejecutiva en una empresa, consulta por cefalea, náuseas y mareos frecuentes y recurrentes. Su examen físico es normal y refiere sentirse estresada y exigida en su trabajo, ya que los resultados de la empresa dependen de su desempeño. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno facticio
E) Trastorno adaptativo de tipo ansioso

Respuesta A. Trastorno Somatomorfo: Este audio describe un trastorno somatomorfo, caracterizado por síntomas físicos sin una causa orgánica subyacente.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente sufre una fractura de muñeca, en relación a un accidente laboral. Presenta con mucho dolor, a pesar de haber evolucionado bien y de llevar mucho tiempo desde el accidente. Tiene antecedente de cuadros previos similares, con dolores crónicos y difíciles de tratar. El diagnóstico más probable es:

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversico
C) Trastorno de estrés postraumático
D) Depresión reactiva
E) Trastorno facticio

Respuesta A. Es un trastorno somatomorfo por dolor (no por somatización, ni hipocondriaco). No hay información para pensar que sea facticio (intencional para ganar cuidados y afecto) ni simulación (intencional, para ganar dinero o pensiones).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 115 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 50 años consulta por dolor abdominal, asociado a náuseas y malestar general. Además ha tenido disestesias en la piernas y sensación de frío, más otras molestias inespecíficas. Refiere estar angustiada por lo que le sucede y relata que está pasando por un periodo de estrés. Se solicitan exámenes que descartan patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno hipocondriaco
D) Trastorno facticio
E) Depresión

Respuesta E. Diagnóstico: Depresión (opción E). Es un trastorno de somatización clásico.. Ánimo bajo persistente por más de dos semanas, anhedonia, alteraciones del sueño y fatiga cumplen criterios diagnósticos para episodio depresivo mayor (Garantía GES en APS). El tratamiento de primera línea incluye psicoterapia e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS como sertralina).

5.01.1.021 Trastornos disociativos

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.9 Trastorno de Estrés Postraumático (TEPT) y Estrés Agudo

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos disociativos: alteración de la integración de conciencia, memoria, identidad, percepción o conducta, frecuentemente tras trauma grave (abuso sexual, violencia).
- Amnesia disociativa: incapacidad de recordar información autobiográfica, habitualmente de un evento traumático, sin causa orgánica; puede acompañarse de fuga disociativa (viaje con amnesia de identidad).
- Despersonalización/desrealización: sentirse ajeno al propio cuerpo o al entorno con juicio de realidad conservado; trastorno de identidad disociativo: dos o más estados de personalidad con lagunas amnésicas.
- Antes de diagnosticar: descartar causas orgánicas y tóxicas (epilepsia del lóbulo temporal, TEC, intoxicación, amnesia global transitoria, delirium) y distinguir de TEPT con síntomas disociativos.
- Manejo inicial: ambiente seguro, contención, no forzar el recuerdo, evaluar riesgo suicida y de violencia; no hay fármaco específico.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría para psicoterapia especializada (centrada en el trauma).

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 59

Mujer de 18 años sufrió un rapto por dos desconocidos al salir de la oficina. Es encontrada por terceros en un sitio eriazo, con evidentes signos de abuso sexual, sin lesiones físicas. En el Servicio Médico Legal se constata la violación. Ella no recuerda nada de lo sucedido: solo cuando fue abordada por los desconocidos y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Se muestra muy preocupada, pero no logra recordar lo ocurrido entremedio. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno facticio
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta E. La incapacidad de recordar información autobiográfica de un evento traumático, sin causa orgánica, corresponde a una amnesia disociativa, dentro de los trastornos disociativos. El estrés postraumático exige reexperimentación, evitación e hiperalerta por más de un mes; aquí el cuadro es inmediato y el síntoma central es la laguna amnésica.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 114 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 18 años subió a un taxi, en el que el taxista se desvió del camino que debía tomar, siendo luego agredida por él. Es encontrada por terceras personas en un sitio eriazo, con evidentes signos de haber sido abusada sexualmente. Fue trasladada al Servicio Médico Legal, donde se constató la violación. Sin embargo, ella no recuerda nada de los sucedido, recordando solo cuando estaba en el taxi y luego cuando estaba en el Servicio Médico Legal. Ella se muestra muy preocupada, pero no logra recordar nada de lo que aconteció entremedio. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno de estrés postraumático
C) Trastorno facticio
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción E). Es una amnesia disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 12 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 59 años, luego de una pelea con su marido, se va de su casa y es en- contrada varias horas después sin recordar lo sucedido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno facticio
B) Trastorno disociativo
C) Trastorno somatomorfo
D) Trastorno conversivo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta B. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción B). Es una fuga disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 180 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 23 años no llega a su domicilio luego de un conflicto familiar grave, siendo encontrada dos días después en una ciudad diferente, en buenas condiciones generales. Ella no recuerda nada de lo sucedido en ese intervalo de tiempo y no parece estar preocupada por ello. Su examen neurológico es normal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Amnesia global transitoria
B) Episodio psicó2co breve
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno de estrés agudo
E) Trastorno disocia2vo

Respuesta E. Tiene una fuga disociativa clásica, que es un Gpo de amnesia disociativa, en la que, además, se produce una “fuga” desde su lugar habitual. No se debe confundir con la amnesia global transitoria, que es un Gpo de accidente isquémico transitorio cerebral (se debe buscar fuente embólica), que se caracteriza por desorientación y amnesia (repitiendo las mismas preguntas), autolimitado, de pocas horas

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 25 años fue encontrada vagando por la calle descalza, desorientada y confusa. Hace 5 horas había tenido una discusión con su padre, luego de lo cual salió de su casa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno adaptativo
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno somatomorfo
E) Trastorno facticio

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno disociativo (opción A). Es una fuga disociativa clásica.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 26 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 40 años, con antecedente de cuatro episodios depresivos tratados y usuaria de fluoxetina de forma permanente, cursa un nuevo episodio luego de separación con su marido. En su último control se encontraba de mejor ánimo ya que asistiría al casamiento de su hija. Actualmente consulta muy preocupada porque hace aproximadamente una semana atrás, su mano derecha intentó atacarla, pero se defendió con la su mano izquierda y ayuda de familiares. El diagnóstico más probable en este caso es:

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno delirante
C) Psicosis
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno por somatización

Respuesta D. Hizo un trastorno disociativo grave, con despersonalización parcial. Es una pregunta muy difícil, ya que no es el cuadro clásico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 107 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente es despedido de su trabajo, luego de ser sorprendido robando. Evoluciona con paresia de ambas manos. Al examen neurológico no tiene alteraciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno de somatización
D) Trastorno adaptativo
E) Trastorno disociativo

Respuesta A. Diagnóstico: Trastorno conversivo (opción A). Es un trastorno conversivo clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 40 años pierde súbitame la movilidad de ambos brazos. Esto sucede en relación a la reactivación de un conficto familiar. Al examen físico se aprecia una disociación con los síntomas, por lo que se descarta patología orgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno conversivo
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno adaptativo

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno conversivo (opción C). Cuadro clásico (síntomas neurológicos de inicio súbito). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

5.01.1.022 Trastornos facticios

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: psiq-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno facticio: falsificación o producción intencional de signos o síntomas (inyectarse insulina, contaminar heridas o muestras, autolesiones) para asumir el rol de enfermo, sin incentivo externo evidente; forma crónica

grave: síndrome de Münchhausen.

- Facticio impuesto a otro (Münchhausen por poderes): un cuidador, habitualmente la madre, produce o inventa síntomas en un niño; es una forma de maltrato infantil.
- Sospechar ante cuadros inexplicables o que no responden, historias inconsistentes, múltiples hospitalizaciones en distintos centros, conocimiento médico y aceptación ansiosa de procedimientos invasivos.
- Diferenciar de simulación (producción intencional con incentivo externo: licencia, indemnización, evitar la cárcel) y de trastorno de síntomas somáticos (no intencional).
- Manejo inicial: confrontación no punitiva, evitar procedimientos innecesarios, coordinar un solo equipo tratante y tratar la comorbilidad; en la forma por poderes, proteger al niño, registrar y denunciar.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría.

PREGUNTAS (8)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 163

Paciente de 22 años es hospitalizada por un cuadro de diarrea, vómitos y dolor abdominal de difícil manejo. Durante la hospitalización es sorprendida ingiriendo laxantes, autoinduciéndose vómitos y adulterando la temperatura del termómetro. Los exámenes descartan patología orgánica y, luego de indagar, no se encuentra ninguna ganancia evidente con estos síntomas. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno conversivo
B) Trastorno facticio
C) Trastorno delirante
D) Trastorno bipolar
E) Trastorno de la conducta alimentaria

Respuesta B. En el trastorno facticio la persona produce o finge síntomas de forma intencional para asumir el rol de enfermo, sin incentivos externos evidentes. Si hubiera ganancia externa (licencia, dinero) sería simulación; en el conversivo los síntomas no son voluntarios. Los laxantes y vómitos no buscan bajar de peso, sino parecer enfermo.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 102 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente presenta dolor abdominal y vómitos desde hace 5 días, y tiene una actitud muy demandante y agresiva, solicitando la realización de exámenes y administración de medicamentos. En una ocasión fue sorprendido tomando laxantes y adulterando la temperatura del termómetro. Además, hace un año estuvo hospitalizado por un cuadro similar, hecho que él no refirió en la consulta. Al indagar un poco más, se concluye que no tiene una causa orgánica que explique sus síntomas, pero que tampoco hay una ganancia evidente para él. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por hipocondría
B) Trastorno de somatización
C) Trastorno delirante crónico
D) Episodio psicótico breve
E) Trastorno facticio

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción E). Al hacerlo intencionalmente, es un trastorno facticio clásico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2018 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 46 años presenta múltiples síntomas, como cefalea, molestias abdominales, calambres, astenia, entre otros, desde hace un año. Se han realizado múltiples exámenes, sin encontrar una causa orgánica. Llama la atención que ha tenido proteinuria persistente, que no se correlaciona con el cuadro clínico, ni con los demás exámenes, por lo que se tienen fuertes sospechas de que ha manipulado las muestras de orina. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno somatomorfo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno facticio
D) Trastorno disociativo
E) Trastorno hipocondriaco

Respuesta C. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción C). La sospecha de manipulación de los exámenes, hace que sea facticio.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 172 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 57 años presenta múltiples síntomas difíciles de precisar. Se ha realiza múltiples exámenes y evaluaciones médicas, sin poder llegar a un diagnóstico. Sin embargo, él insiste en que está muy enfermo y no puede realizar actividades básicas, como asearse. Hace 2 años fue pensionado por esto, sin cambiar su conducta. Su esposa lo cuida y lo asiste abnegadamente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por simulación
B) Trastorno hipocondríaco
C) Trastorno de somatizaicón
D) Trastorno facticio
E) Trastorno de personalidad dependiente

Respuesta D. Que se haya pensionado hace sospechar un T. por simulación, pero que no cambie su conducta y que su vida esté tan afectada, hace sospechar más un T. facticio. También el hecho de que su mujer lo cuide abnegadamente (fin ganancial de afecto, atención y cuidados).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2017 · Pregunta 47 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 30 años, diabética tipo 1, con historia de 5 hospitalizaciones en el último año por cuadros de hipoglicemia severa. Actualmente ingresa en shock hipogli- cémico, el que es manejado adecuadamente. Durante su hospitalización, es sorprendida en el baño inyectándose una dosis de insulina que no le correspondía, lo cual ella poste- riormente niega. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno somatomorfo
C) Trastorno hipocondriaco
D) Trastorno por simulación
E) Trastorno facticio

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción E). Es un trastorno facticio clásico. No es por simulación, porque no hay un fin económico.. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 85 · texto original del banco, sin revisar

Una joven que consulta por diarrea de meses, exige que la hospitalicen para estudio. Estudio normal. La pillan tomando laxantes, ella lo niega, no se sabe motivo por el que hace esto. ¿Cual es el diagnóstico? a. Trastorno facticio

A) Hemograma y VHS
B) Ecografía
C) Radiografía
D) TAC con contraste
E) Resonancia magnética

Respuesta A. Diagnóstico: Hemograma y VHS (opción A). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2018 · Pregunta 131 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 19 años, ha sido hospitalizada 8 veces por hipoglicemias, sin una causa clara, que han requerido hospitalización y que se resuelven fácilment

E) En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno disociativo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno somatomorfo
D) Trastorno facticio

Respuesta E. La alternativa correcta es la E (En la última hospitalización, fue sorprendida inyectándose una dosis de insulina en el baño. Sin embargo, ella niega abiertamente este hecho. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 34 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 50 años relata que, al llegar a su trabajo en auto, se le “descompuso el cuerpo”, sintiendo rigidez generalizada en todos sus músculos, lo que le impidió entrar a su trabajo y lo obligó a devolverse a su casa. Además, presentó pérdida de conciencia con movimientos repetitivos en su casa, razón por la cual fue llevado al servicio de urgencias. Refiere malestar, angustia y desasosiego de varios días de evolución. Al examen físico tiene un examen neurológico estrictamente normal y su resonancia magnética nuclear descarta lesiones. Sus familiares refieren que siempre ha sido un buen trabajador y excelente padre, por lo que no entienden bien qué le está pasando. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno depresivo
B) Trastorno conversivo
C) Trastorno adaptativo
D) Trastorno facticio
E) Trastorno disociativo

Respuesta D. Diagnóstico: Trastorno facticio (opción D). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

5.01.1.023 Trastorno del espectro autista

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TEA: déficit persistente de comunicación e interacción social recíproca (contacto visual, atención conjunta, juego simbólico) más patrones restringidos y repetitivos (estereotipias, rigidez ante cambios, intereses restringidos, alteraciones sensoriales), desde la infancia temprana.
- Señales de alerta: no balbucear a los 12 meses, no señalar ni decir palabras a los 16–18 meses, no combinar 2 palabras a los 24 meses, no responder a su nombre y cualquier pérdida de lenguaje o habilidad social.
- Pesquisa con M-CHAT-R/F (16–30 meses) en el control de salud; ante retraso del lenguaje descartar siempre hipoacusia con evaluación auditiva objetiva.
- Manejo inicial: derivación precoz a evaluación diagnóstica especializada (neurología infantil/psiquiatría, fonoaudiología, terapia ocupacional) sin esperar; orientación a la familia.
- La intervención temprana conductual y del lenguaje mejora el pronóstico; risperidona o aripiprazol solo para irritabilidad o agresividad grave, por especialista.
- Seguimiento: derivar; buscar comorbilidades (discapacidad intelectual, epilepsia, TDAH, ansiedad) y apoyar la inclusión escolar.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 1

Paciente de 20 años presenta episodios de descontrol y agresividad en los que rompe objetos, grita y amenaza con agredir y autoagredirse. Se molesta mucho cuando le cambian sus cosas de lugar y tiene rutinas muy marcadas que le cuesta modificar. Abandonó la secundaria tras reprobar dos veces primero medio. Tiene muy buena memoria, al punto de memorizar códigos de barras de productos. Desde niño fue considerado raro, no entablaba amistades, jugaba solo siempre con el mismo juguete y veía repetidamente sus dos películas favoritas. Saluda de manera extraña, con aleteo de sus extremidades superiores. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Esquizofrenia
B) Trastorno bipolar
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno del espectro autista
E) Trastorno estereotipado del movimiento

Respuesta D. El trastorno del espectro autista combina déficit persistente en la comunicación e interacción social desde la infancia con patrones restringidos y repetitivos: rutinas rígidas, intereses intensos, estereotipias motoras como el aleteo. Los episodios de descontrol ante cambios son frecuentes. El trastorno estereotipado del movimiento no explica el déficit social.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 105 · texto original del banco, sin revisar

Niño de 3 años con antecedente de autismo. Presenta episodios de golpear su cabeza contra la pared repetidamente, varias veces al día. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Derivar a psiquiatría infantil para evaluación y manejo conductual
B) Hospitalizar de urgencia
C) Iniciar haloperidol
D) Solicitar EEG para descartar epilepsia
E) Solo observar

Respuesta A. Conductas autolesivas en niño con TEA (autismo): derivar a psiquiatría infantil + equipo de terapia conductual (ABA). Las conductas repetitivas y autolesivas son parte del espectro autista y requieren manejo especializado.

5.01.1.024 Trastorno específico del aprendizaje escolar

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno específico del aprendizaje: dificultad persistente en lectura (dislexia), escritura (disgrafía/disortografía) o cálculo (discalculia), muy por debajo de lo esperado para la edad, con inteligencia normal.
- Sospechar ante bajo rendimiento escolar selectivo, lectura lenta con errores, inversión de letras o dificultad con números pese a escolarización adecuada; persiste ≥6 meses pese a apoyo.
- Antes de diagnosticar: descartar déficit visual o auditivo, discapacidad intelectual (WISC), TDAH, trastornos emocionales, problemas familiares y escolarización deficiente.
- Manejo inicial: evaluación psicopedagógica y apoyo en el colegio con adecuaciones curriculares (Programa de Integración Escolar), coordinación con la familia.
- Seguimiento: derivar a evaluación especializada (psicopedagogía, neurología o psiquiatría infantil) y pesquisar baja autoestima o ansiedad secundaria.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 8 años, en tercero básico, derivado por bajo rendimiento en lenguaje. Lee lento, con omisiones e inversiones de letras y mala comprensión lectora, pese a apoyo escolar por un año. Su rendimiento en matemáticas es adecuado. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual de 102, y su audición y visión son normales. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Discapacidad intelectual leve
B) Trastorno del espectro autista
C) Trastorno por déficit atencional
D) Trastorno específico del aprendizaje con dificultad en la lectura
E) Trastorno del desarrollo del lenguaje expresivo

Respuesta D. El trastorno específico del aprendizaje es una dificultad persistente en una habilidad académica (lectura, escritura o cálculo), muy por debajo de lo esperado, pese a intervención, con inteligencia normal y sin déficit sensorial que lo explique. La dislexia es la forma más frecuente. Un CI normal descarta discapacidad intelectual.

5.01.1.025 Retardo mental

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Discapacidad intelectual (retardo mental): déficit de funciones intelectuales (CI <70 en WISC/WAIS) y del funcionamiento adaptativo (conceptual, social, práctico), con inicio en el período del desarrollo.
- Grados: leve (CI 50–69, la mayoría), moderado (35–49), grave (20–34) y profundo (<20); hoy la gravedad se define sobre todo por el funcionamiento adaptativo.
- Causas: síndrome de Down (más frecuente genética), X frágil (más frecuente hereditaria), síndrome alcohólico fetal (más frecuente prevenible), hipotiroidismo congénito y PKU (pesquisa neonatal), asfixia, infecciones congénitas.

- Sospecha: retraso global del desarrollo en EEDP/TEPSI, dificultades escolares globales o conductas disruptivas; descartar hipoacusia y déficit visual.
- Manejo inicial: evaluación psicométrica, estudio etiológico básico y estimulación temprana; apoyo educativo (educación especial o PIE) y familiar.
- Seguimiento: derivar a neurología/genética y salud mental infantil; pesquisar comorbilidades (epilepsia, TEA, TDAH) y prevenir maltrato y abuso.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Niño de 7 años con retraso del lenguaje desde los 2 años. En el colegio no logra aprender a leer, requiere ayuda para vestirse y le cuesta seguir instrucciones de 2 pasos. La evaluación con WISC muestra un coeficiente intelectual total de 60, con perfil homogéneamente descendido. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**
>
> **A)** Discapacidad intelectual leve
> **B)** Discapacidad intelectual moderada
> **C)** Discapacidad intelectual grave
> **D)** Inteligencia limítrofe
> **E)** Trastorno específico del aprendizaje
>
> Respuesta A. La discapacidad intelectual (antes retardo mental) requiere déficit intelectual y adaptativo de inicio en el desarrollo. Por CI se clasifica en leve (50-69), moderada (35-49), grave (20-34) y profunda (bajo 20); la inteligencia limítrofe es 70-84. DSM-5 gradúa además por funcionamiento adaptativo. Con CI de 60 y déficit adaptativo, es leve.

5.01.1.026 Enuresis

Diagnóstico: **Específico** | Tratamiento: **Completo** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Enuresis: emisión involuntaria de orina durante el sueño en niños ≥5 años, al menos 2 veces por semana por 3 meses; primaria (nunca controló, la más frecuente) o secundaria (tras ≥6 meses seco: buscar estresor o causa orgánica).
- Monosintomática (solo nocturna) vs no monosintomática (urgencia, incontinencia diurna, constipación): esta última requiere estudio y tratar la disfunción vesical e intestinal.
- Estudio: anamnesis, examen físico (columna lumbosacra, genitales), orina completa ± urocultivo (ITU, glucosuria, densidad baja) y diario miccional; descartar diabetes, ITU, apnea del sueño y constipación.
- Tratamiento: educación sin castigo ni culpa, orinar antes de dormir y restringir líquidos nocturnos; primera línea alarma de enuresis (8–12 semanas) o desmopresina 120–240 μg sublingual (o 0,2–0,4 mg oral) antes de dormir, restringiendo líquidos por riesgo de hiponatremia.
- Remisión espontánea ~15% por año; tratar constipación asociada.
- Seguimiento completo: control de respuesta con calendario seco/mojado; retiro gradual de desmopresina; derivar si es secundaria con causa orgánica, no monosintomática refractaria o falla del tratamiento.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
>
> Niño de 7 años, traído porque moja la cama 4 noches por semana. Nunca ha estado seco por más de 6 meses. No tiene síntomas urinarios diurnos ni constipación, su examen físico es normal y el examen de orina es normal. La familia lo reta cada mañana. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**
>
> **A)** Derivar a urología para cistoscopía
> **B)** Iniciar imipramina
> **C)** Solicitar ecografía renal y uretrocistografía miccional
> **D)** Iniciar oxibutinina
> **E)** Educación a la familia, eliminar castigos y medidas conductuales como calendario y micción antes de dormir
>
> Respuesta E. Enuresis nocturna primaria monosintomática: se diagnostica desde los 5 años. Con examen y orina normales no requiere estudio de imágenes. Se inicia con educación, eliminar castigos y medidas conductuales; si persiste, la alarma de enuresis o la desmopresina son las terapias de primera línea. La imipramina ya no se usa por su cardiotoxicidad.

5.01.1.027 Encopresis

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- Encopresis: emisión de deposiciones en lugares inapropiados en niño ≥4 años, al menos 1 vez al mes por 3 meses; la forma más frecuente es retentiva, por constipación funcional con fecaloma y escurrimiento por rebalse.
- Sospecha: niño que mancha la ropa interior casi a diario con deposiciones blandas y defeca deposiciones duras, voluminosas y dolorosas cada varios días; masa fecal palpable en hipogastrio.
- Banderas rojas de organicidad: retraso en la eliminación de meconio (Hirschsprung, ampolla vacía), alteraciones de columna lumbosacra, déficit neurológico o mal incremento.
- Manejo inicial: educación sin castigo; desimpactación con polietilenglicol oral en dosis altas (o enemas), luego polietilenglicol de mantención por meses, sentarse en el baño tras las comidas, fibra y agua.
- Encopresis no retentiva o asociada a estrés familiar, abuso o conducta oposicionista: evaluación de salud mental.
- Seguimiento: derivar a gastroenterología o salud mental infantil si no responde, hay sospecha orgánica o componente psicológico relevante.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 6 años, controla esfínteres desde los 3 años. Desde hace 4 meses ensucia su ropa interior casi a diario con deposiciones blandas. Defeca deposiciones duras y voluminosas cada 5 días, con dolor. Al examen se palpa masa fecal en hipogastrio y el tacto rectal muestra ampolla llena de heces duras. **¿Cuál es el manejo más adecuado?**

A) Loperamida para controlar el escurrimiento
B) Desimpactación fecal, luego polietilenglicol de mantención y entrenamiento de hábito defecatorio
C) Psicoterapia exclusiva, sin tratamiento laxante
D) Dieta sin gluten
E) Biopsia rectal por sospecha de enfermedad de Hirschsprung

Respuesta B. La encopresis retentiva es la más frecuente: la constipación funcional con fecaloma produce escurrimiento de heces por rebalse. Se trata con desimpactación (polietilenglicol en dosis altas o enemas), mantención con polietilenglicol por meses, educación sin castigo y hábito defecatorio postprandial. El Hirschsprung se sospecha con inicio neonatal y ampolla vacía.

5.01.1.028 Trastorno por déficit atencional

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- TDAH: ≥6 síntomas de inatención y/o ≥6 de hiperactividad-impulsividad por ≥6 meses (5 desde los 17 años), presentes antes de los 12 años, en ≥2 contextos (casa y colegio) y con deterioro académico o social.
- Presentaciones: combinada (la más frecuente), inatenta (frecuente en niñas, pasa desapercibida) e hiperactiva-impulsiva; heredabilidad ~75%.
- Antes de diagnosticar: descartar déficit visual o auditivo, discapacidad intelectual, trastorno del aprendizaje, ansiedad, depresión, maltrato y problemas del sueño; usar cuestionarios a padres y profesores (Conners).
- Tratamiento inicial: intervención multimodal (psicoeducación, manejo conductual parental, apoyo y adecuaciones escolares) y metilfenidato como fármaco de primera línea en escolares (acción corta o prolongada).
- Efectos del metilfenidato: disminución del apetito, insomnio de conciliación, cefalea y alza leve de FC y PA; controlar peso, talla, PA y FC en cada visita.
- Seguimiento completo: controles periódicos de respuesta escolar y efectos adversos; derivar si hay comorbilidad importante, duda diagnóstica o falta de respuesta.

PREGUNTAS (5)

Pregunta del libro · Tema 17.18

Un niño de 8 años es traído a consulta médica porque su profesora señala que se para constantemente de su asiento en clases, habla sin parar, interrumpe a sus compañeros y no termina las guías escolares por distraerse con cualquier estímulo. Los padres relatan que en la casa el niño presenta la misma conducta desde los 5 años: no logra mantenerse sentado a la mesa, pierde constantemente los lápices y cuadernos, y le cuesta seguir instrucciones de más de un paso. Su coeficiente intelectual y examen neurológico son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y el fármaco de primera línea?

A) Trastorno del espectro autista; iniciar Risperidona
B) Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH); tratamiento farmacológico de primera línea con Metilfenidato asociado a intervenciones psicopedagógicas
C) Trastorno bipolar maníaco precoz; iniciar Carbonato de Litio
D) Trastorno oposicionista desafiante puro; internación en centro psiquiátrico
E) Depresión infantil enmascarada; indicar Sertralina

Respuesta B. El paciente cumple los criterios diagnósticos DSM-5 para Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) subtipo combinado: presencia de síntomas de inatención, hiperactividad motora e impulsividad presentes de forma continua durante más de 6 meses, que debutaron antes de los 12 años (presentes desde los 5 años) y que se manifiestan de forma consistente en al menos dos entornos diferentes (colegio y hogar), produciendo disfunción escolar. El tratamiento farmacológico de primera elección avalado por guías clínicas mundiales y MINSAL son los psicoestimulantes, específicamente el Metilfenidato, complementado con adaptaciones psicopedagógicas curriculares (programa PIE) y orientación a los padres. Perla de examen: En TDAH escolar con compromiso en dos o más entornos, el Metilfenidato es el tratamiento farmacológico de primera línea.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 70 · texto original del banco, sin revisar

Una mujer de 30 años, ingeniera civil, refiere que desde su infancia se le pierden con frecuencia las cosas y que le es difícil realizar tareas, en especial porque las procrastina y le cuesta terminarlas una vez iniciadas. Por ello realiza listas de todas las cosas que debe hacer a modo de cumplir con ellas. Recientemente, en su trabajo ha aumentado su carga laboral y responsabilidades, lo que la tiene agobiada y angustiada. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno del espectro au2sta
B) Trastorno obsesivo compulsivo
C) Trastorno de personalidad
D) Trastorno por déficit atencional hiperac2vo
E) Trastorno de angus2a generalizada

Respuesta D. Es un TDAH clásico, de alta capacidad (logró ser ingeniera). Se maneja con técnicas de trabajo y, en algunos casos, fármacos estimulantes como el metilfenidato y anfetaminas (ej. lisdexanfetamina).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 155 · texto original del banco, sin revisar

Una paciente de 27 años consulta por ansiedad y ánimo bajo. Refiere antecedentes de problemas de inquietud psicomotora durante la infancia y se considera olvidadiza y desordenada. Refiere que recientemente cambió de puesto de trabajo, presentando errores y dificultades, lo que le ha generado problemas, sintiéndose ansiosa y con ánimo bajo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno por déficit atencional de tipo hiperactivo
B) Trastorno de personalidad
C) Trastorno de ansiedad social
D) Trastorno de ansiedad generalizada
E) Trastorno bipolar

Respuesta A. Déficit Atencional en Adultos: Este audio describe un cuadro clínico compatible con déficit de atención del adulto de tipo hiperactivo, con síntomas depresivos y ansiosos.

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 176 · texto original del banco, sin revisar

Universitaria con dificultad para prestar atención, historia de dificultad para concretar tareas y para seguir el hilo de conversación. ¿Diagnóstico más probable?

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno depresivo mayor
C) Trastorno de personalidad limítrofe
D) Trastorno del espectro autista (TEA)
E) Trastorno por déficit de atención (TDA)

Respuesta E. Diagnóstico: Trastorno por déficit de atención (TDA) (opción E). Trastorno por déficit de atención (TDA). El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

Pregunta real · EUNACOM Julio 2015 · Pregunta 86 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 25 años presenta mal rendimiento en la universidad, habiendo reprobado una de las asignaturas. Refiere que no se concentra en sus estudios y que no alcanza a leer toda la materia. En la entrevista se ve verborreico, inquieto y teatral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno histriónico de la personalidad
B) Déficit atencional
C) Trastorno bipolar
D) Insuficiencia intelectual leve
E) Síndrome de Asperger

Respuesta B. Diagnóstico: Déficit atencional (opción B). Cuadro clásico. El cuadro clínico presentado reúne los criterios diagnósticos cardinales para esta patología, de acuerdo a las pautas de práctica clínica del Ministerio de Salud (MINSAL).

5.01.1.029 Intento de suicidio en niños y adolescentes

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Intento suicida adolescente: siempre es grave y requiere evaluación; factores de riesgo: intento previo (el más potente), depresión, consumo de sustancias, conflictos familiares, abuso, bullying, diversidad sexual sin apoyo, impulsividad y acceso a medios.
- Señales de alarma: carta o mensajes de despedida, regalar pertenencias, hablar de morir, aislamiento, autolesiones, búsqueda de métodos; preguntar directamente no induce el suicidio.
- Manejo inicial: tratar lo médico primero (paracetamol: N-acetilcisteína; tricíclicos: ECG), observación protegida sin dejarlo solo, retirar medios letales y evaluación psiquiátrica antes de cualquier alta.
- Hospitalizar si hay plan estructurado, intención de morir, arrepentimiento de haber sobrevivido, ideación persistente, psicosis o falta de red que supervise; los contratos de no suicidio no sirven.
- En riesgo vital se rompe la confidencialidad para informar a los padres; el ISRS no protege en el corto plazo (la fluoxetina es de elección si hay depresión, vigilando el inicio).
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil con control precoz tras el alta (alto riesgo de repetición en los meses siguientes).

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 87

Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo? **¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?**

A) Gases arteriales
B) Bilirrubinemia
C) Electrocardiograma
D) Creatinfosfoquinasa
E) Pruebas hepáticas

Respuesta C. La intoxicación por tricíclicos produce alteraciones de la conducción y arritmias ventriculares, que son lo más grave. El electrocardiograma (QRS ancho) permite estimar el riesgo.

Pregunta de práctica

Adolescente de 15 años es traída a urgencia tras ingerir 20 comprimidos de paracetamol después de una discusión con su pareja. Está estable, sin compromiso de conciencia, y ya recibió manejo toxicológico. En la entrevista refiere que quería morir, que lo planificó por una semana, que lamenta seguir viva y que lo volvería a intentar. **Una vez estabilizada médicamente, ¿cuál es la conducta más adecuada?**

A) Derivar solo a psicólogo del colegio
B) Alta con control en CESFAM en un mes
C) Alta con sertralina y control en 2 semanas
D) Alta a su domicilio si los padres se comprometen a vigilarla
E) Hospitalización con evaluación psiquiátrica urgente y supervisión continua

Respuesta E. Todo intento suicida en un adolescente requiere evaluación psiquiátrica antes del alta. Planificación, intención de morir, arrepentimiento de sobrevivir e ideación persistente indican alto riesgo, por lo que corresponde hospitalizar con supervisión continua. Los antidepresivos no protegen en el corto plazo y el compromiso familiar no basta con este nivel de riesgo.

5.01.1.030 Trastorno conducta oposicionista desafiante

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno oposicionista desafiante: patrón ≥6 meses de enojo o irritabilidad, discusiones y desafío a la autoridad, y vengatividad, con ≥4 síntomas, hacia adultos y figuras de autoridad, que excede lo esperable para la edad.
- No hay violación grave de derechos de otros ni de normas sociales mayores (eso es trastorno disocial); suele comenzar en preescolares y escolares.
- Buscar comorbilidad y factores contribuyentes: TDAH (muy frecuente), trastornos del ánimo y ansiedad, trastornos del aprendizaje, crianza inconsistente o violenta, VIF y maltrato.
- Manejo inicial: psicoeducación y entrenamiento parental (normas claras y consistentes, refuerzo positivo, consecuencias predecibles, evitar castigo físico), coordinación con el colegio.
- No hay fármaco específico; se trata la comorbilidad (por ejemplo TDAH).
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil para terapia familiar/parental.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 8 años traído por sus padres porque, desde hace 8 meses, discute constantemente con los adultos, se niega a cumplir normas en casa y en el colegio, molesta deliberadamente a otros, se enoja con facilidad, es rencoroso y culpa a los demás de sus errores. No ha agredido físicamente a personas ni animales, no ha robado ni destruido propiedad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno explosivo intermitente
B) Trastorno disocial
C) Trastorno por déficit atencional
D) Trastorno negativista desafiante (oposicionista)
E) Trastorno de desregulación disruptiva del estado de ánimo

Respuesta D. El trastorno negativista desafiante es un patrón de al menos 6 meses de ánimo irritable, conducta desafiante y vengativa contra figuras de autoridad, sin violar derechos básicos de otros. Si hubiera agresión, robos, destrucción o crueldad sería trastorno disocial. El tratamiento de primera línea es el entrenamiento parental.

5.01.1.031 Trastorno conducta disocial

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastorno disocial (de conducta): patrón repetitivo de violación de derechos de otros o de normas sociales, con ≥3 criterios en 12 meses: agresión a personas o animales, destrucción de propiedad, engaño o robo y violaciones graves de normas (fugas, ausentismo).
- Inicio infantil (antes de los 10 años, peor pronóstico) o adolescente; con rasgos de insensibilidad emocional (falta de culpa y empatía) es más grave.

- Es precursor del trastorno de personalidad antisocial, que se diagnostica desde los 18 años con antecedente de trastorno disocial antes de los 15.
- Pesquisar maltrato, abuso, VIF, consumo de sustancias, TDAH, depresión y discapacidad intelectual; evaluar riesgo para terceros y para el propio adolescente.
- Manejo inicial: intervenciones familiares y multisistémicas (familia, colegio, comunidad), activar redes de protección (OPD, Tribunal de Familia) si hay vulneración de derechos.
- Seguimiento: derivar a salud mental infanto-juvenil.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 145

En el servicio de urgencia usted evalúa a un niño de 11 años que se ha comportado muy agresivo, autoagrediéndose y golpeando a su madre. Ella fue citada al colegio por las malas notas y el comportamiento inapropiado de su hijo: el director le informó que había insultado y agredido a sus compañeros y a uno de sus profesores. Tras ser confrontado por su madre, el niño la agredió y luego se infligió cortes en los brazos. Además, su abuela refiere que el niño miente y le ha robado alcohol y cigarrillos de su tienda. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno disocial
B) Trastorno de personalidad limítrofe
C) Trastorno del espectro autista
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno oposicionista desafiante

Respuesta A. El trastorno disocial es un patrón persistente de violación de los derechos de otros y de normas sociales: agresión a personas, destrucción, engaño o robo. Aquí hay agresión a pares, profesor y madre, mentiras y robos. El oposicionista desafiante no incluye agresión física ni robos, y los trastornos de personalidad no se diagnostican a los 11 años.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2025 · Pregunta 38 · texto original del banco, sin revisar

Adolescente de 14 años que presenta ausencias repetidas al colegio, peleas con compañeros, robos dentro del hogar y consumo de alcohol desde los 12 años. Los padres refieren que "no respeta ninguna norma". ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Discapacidad intelectual
B) TDAH
C) Trastorno de conducta
D) Trastorno del espectro autista
E) Fobia social

Respuesta C. Trastorno de conducta: patrón repetitivo y persistente de comportamiento que viola los derechos básicos de otros o normas sociales (agresión, robo, absentismo, consumo de sustancias). Inicio antes de los 15 años. Requiere intervención multidisciplinaria.

5.01.1.032 Trastorno somatización en niños

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 6.2 Reflujo del Lactante, Dolor Abdominal Crónico y Constipación en el Niño

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños la somatización se expresa típicamente con dolor abdominal periumbilical y cefalea recurrentes, ligados a estrés escolar o familiar: aparecen en mañanas de días de colegio y ceden fines de semana y vacaciones.
- Banderas rojas que obligan a estudiar: dolor que despierta, alejado del ombligo, baja de peso, vómitos, sangrado, fiebre recurrente o examen alterado.
- Sin banderas rojas y con examen normal no se piden más exámenes; diferenciar de dolor abdominal funcional, ansiedad de separación, bullying, depresión y abuso.
- Manejo inicial: validar y legitimar el dolor, explicar su origen funcional, abordar los estresores con la familia y el colegio y favorecer el retorno a clases (el ausentismo refuerza el cuadro).
- Seguimiento completo: controles programados con el mismo médico, registro de síntomas y factores gatillantes; derivar a salud mental si persiste, hay deterioro importante o comorbilidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niña de 9 años con 4 meses de dolor abdominal periumbilical y cefalea recurrentes, que aparecen en las mañanas de días de colegio y ceden los fines de semana. Ha faltado mucho a clases. Coincide con la separación de sus padres. Crecimiento normal, sin baja de peso, fiebre, sangrado ni despertar nocturno por dolor. Examen físico, hemograma y orina normales. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Explicar el origen funcional, validar los síntomas y abordar los estresores con la familia y el colegio, favoreciendo el retorno a clases
B) Solicitar endoscopía digestiva alta
C) Solicitar TAC de abdomen y pelvis
D) Indicar reposo en casa hasta que ceda el dolor
E) Iniciar benzodiacepinas

Respuesta A. En niños, la somatización se expresa típicamente con dolor abdominal y cefalea recurrentes, ligados a estrés (escuela, conflictos familiares). Sin signos de alarma no se piden más estudios. Se legitima el dolor, se explica su naturaleza, se trabajan los estresores y se promueve la asistencia escolar; el ausentismo refuerza el cuadro.

5.01.1.033 Trastornos ansiosos en niños

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Trastornos ansiosos son los más frecuentes en la infancia: ansiedad de separación (miedo excesivo a separarse de los padres, el más frecuente en menores de 12 años), TAG, fobias específicas, fobia social y mutismo selectivo.
- Sospecha: síntomas somáticos (dolor abdominal, cefalea), rechazo escolar, irritabilidad, insomnio, preocupación excesiva por rendimiento o salud de los padres, con deterioro funcional.
- Descartar hipertiroidismo, efectos de fármacos (salbutamol, corticoides), maltrato, bullying y trastornos del ánimo.
- Tratamiento inicial: TCC con participación de la familia es la primera línea; en cuadros moderados a graves o sin respuesta, ISRS (sertralina o fluoxetina), vigilando ideación suicida al inicio.
- Benzodiacepinas no recomendadas de mantención en niños.
- Seguimiento completo: controles de síntomas, asistencia escolar y efectos del ISRS; derivar si es grave, refractario o con comorbilidad.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 7 años, desde hace 3 meses llora intensamente y se queja de dolor de estómago cada vez que debe separarse de su madre para ir al colegio. Teme que a ella le pase algo malo mientras está lejos, no quiere dormir solo y tiene pesadillas sobre perderse. En casa, junto a su madre, juega con normalidad. **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno de ansiedad generalizada
B) Trastorno de ansiedad social
C) Trastorno de ansiedad por separación
D) Mutismo selectivo
E) Trastorno de pánico

Respuesta C. La ansiedad por separación es miedo excesivo e inapropiado para la edad a separarse de las figuras de apego, con preocupación por que les ocurra algo, rechazo escolar, negativa a dormir solo, pesadillas y síntomas somáticos; en niños dura al menos 4 semanas. Se trata con terapia cognitivo-conductual y trabajo con padres.

5.01.1.034 Trastornos del ánimo en niños

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.1 Trastorno Depresivo Mayor: Criterios DSM-5, Escalas, ISRS y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- En niños y adolescentes la depresión se manifiesta a menudo con irritabilidad, explosiones de rabia, baja del rendimiento escolar, aislamiento, abandono de actividades y quejas somáticas en lugar de tristeza.
- Criterios: los de depresión mayor (≥5 de 9 síntomas por 2 semanas); distimia en niños requiere 1 año. Preguntar siempre por ideación suicida, consumo de sustancias, bullying y abuso.

- Sospechar trastorno bipolar ante antecedentes familiares, episodios de euforia o viraje con antidepresivos.
- Tratamiento inicial: psicoterapia (TCC o interpersonal) y, en cuadros moderados a graves o sin respuesta, fluoxetina (ISRS de elección en adolescentes, garantía GES desde 15 años); tricíclicos no son eficaces y son letales en sobredosis.
- Vigilar ideación suicida al inicio del antidepresivo; mantener 6–12 meses tras la remisión.
- Seguimiento completo: controles frecuentes con la familia y el colegio; derivar si hay riesgo suicida, psicosis, sospecha bipolar o falta de respuesta.

PREGUNTAS (2)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2024 · Pregunta 81

Un adolescente de 16 años presenta, desde hace 3 meses, anhedonia, disminución en su rendimiento escolar y presencia de pensamientos negativos sobre sí mismo y su situación, con aislamiento social. Además, relata dificultades para concentrarse en sus actividades académicas e insomnio tanto de inicio como de mantención. Ha subido 5 kilogramos de peso en los últimos meses. Niega autoagresiones y no tiene ideación suicida actual. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Distimia
B) Trastorno del espectro autista
C) Episodio depresivo mayor
D) Trastorno por déficit atencional
E) Trastorno de personalidad

Respuesta C. Cumple criterios de depresión mayor: se afectan el peso, el sueño, el rendimiento escolar y la vida social. En adolescentes la distimia exige un año de ánimo bajo sin cumplir criterios de depresión.

Pregunta de práctica

Adolescente de 14 años, desde hace 2 meses está irritable, con explosiones de rabia en casa, ha dejado el fútbol que le gustaba, duerme mal, bajó sus notas y dice que nada vale la pena. Niega ideación suicida. Se diagnostica un episodio depresivo moderado y se decide, junto a la psicoterapia, iniciar un antidepresivo. **¿Cuál es el fármaco de elección?**

A) Amitriptilina
B) Fluoxetina
C) Paroxetina
D) Venlafaxina
E) Carbonato de litio

Respuesta B. En niños y adolescentes la depresión puede manifestarse con irritabilidad en vez de tristeza. El tratamiento es psicoterapia y, en cuadros moderados a graves, un ISRS, siendo la fluoxetina el de mayor evidencia y de elección según la guía GES. Los tricíclicos no son eficaces y son letales en sobredosis; paroxetina y venlafaxina tienen peor perfil en jóvenes.

5.01.1.035 Consumo perjudicial de drogas en niños y adolescentes

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Consumo perjudicial en adolescentes: uso de alcohol, tabaco, cannabis u otras drogas que ya produce daño (rendimiento escolar, conflictos, conductas de riesgo, accidentes) sin dependencia establecida; el inicio precoz aumenta el riesgo de dependencia y psicosis (cannabis).
- Pesquisa con entrevista confidencial (HEADSSS) y tamizaje (CRAFFT o AUDIT/ASSIST); explorar comorbilidad (depresión, TDAH, ansiedad), riesgo suicida, abuso y contexto familiar.
- Tratamiento: intervención breve y entrevista motivacional, involucrar a la familia, fortalecer factores protectores (escuela, deporte, red de apoyo) y consejería en conductas sexuales de riesgo.
- Garantía GES para consumo perjudicial o dependencia de riesgo bajo a moderado de alcohol y drogas en menores de 20 años: plan de tratamiento ambulatorio en APS.
- Confidencialidad con límites: se informa a los padres si hay riesgo vital o para terceros.
- Seguimiento completo: controles para monitorear consumo y metas; derivar a programa especializado si hay dependencia, policonsumo grave o comorbilidad psiquiátrica severa.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Adolescente de 15 años, en su control de salud joven, refiere que fuma marihuana con amigos los fines de semana desde hace 6 meses y que a veces bebe alcohol en fiestas. Usted quiere tamizar el riesgo de consumo problemático con un instrumento validado para su edad. **¿Qué instrumento es el más adecuado?**

A) Test de Fagerström
B) AUDIT
C) CAGE
D) CRAFFT
E) Minimental

Respuesta D. El CRAFFT es el instrumento de tamizaje validado para consumo de alcohol y drogas en adolescentes; 2 o más respuestas positivas indican riesgo y requieren intervención breve o derivación. El AUDIT y el CAGE fueron diseñados para alcohol en adultos y el Fagerström mide dependencia a la nicotina.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 113 · texto original del banco, sin revisar

¿Cuál es el riesgo principal del consumo de marihuana entre los 12 y los 18 años de edad?

A) Riesgo de dependencia a la marihuana
B) Riesgo de intoxicación aguda
C) Desarrollo de esquizofrenia
D) Disminución de la motivación escolar
E) Desarrollo de alcoholismo

Respuesta D. La alternativa correcta es la D (Disminución de la motivación escolar). Pregunta difícil.. Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

5.01.1.036 Trastorno de ansiedad generalizada

Diagnóstico: **Específico** Tratamiento: **Completo** Seguimiento: **Completo**

Dónde se enseña: Tema 17.7 Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG) y Fobia Social

QUÉ HAY QUE SABER

- TAG: preocupación excesiva y difícil de controlar por múltiples temas (salud, dinero, familia, trabajo) la mayor parte de los días por ≥6 meses, con ≥3 de 6 síntomas: inquietud, fatiga, dificultad de concentración, irritabilidad, tensión muscular e insomnio.
- Consultan por lo somático (cefalea tensional, contracturas, bruxismo, colon irritable, insomnio); no hay crisis bruscas (eso orienta a pánico).
- Descartar hipertiroidismo (TSH), cafeína, estimulantes, abstinencia y depresión comórbida.
- Tratamiento: ISRS (escitalopram 10–20 mg o sertralina 50–200 mg) o venlafaxina 75–150 mg, más TCC con relajación e higiene del sueño; pregabalina como segunda línea.
- Benzodiacepinas no de mantención (tolerancia, dependencia, alteración de memoria; no tratan la preocupación): como máximo puente breve.
- Seguimiento completo: control a las 2–4 semanas para titular; mantener 6–12 meses tras la respuesta y retirar gradualmente; derivar si es refractario o hay comorbilidad grave.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2017 · Pregunta 104

Una mujer de 30 años se preocupa mucho por las finanzas y la salud de su familia. Además, le angustia que alguno de sus familiares pudiera quedarse sin trabajo o que la economía decayera. Refiere estar pasando por un periodo de estrés laboral y estar estresada porque muchas cosas dependen de ella, tanto en su trabajo, como en su familia. Refiere que en el último tiempo, lo único que la mantiene más tranquila es tomar un poco de clonazepam, el que consume 2 a 3 veces por semana. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? **¿Cuál es el diagnóstico más probable?**

A) Trastorno obsesivo compulsivo
B) Trastorno de pánico
C) Trastorno de personalidad dependiente
D) Reacción adversa a las benzodiazepinas
E) Trastorno de ansiedad generalizada

Respuesta E. Tiene preocupaciones distintas y de distintos tipos (finanzas, salud de la familia, trabajo): es un trastorno de ansiedad generalizada clásico.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 109 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 40 años consulta por desasosiego e insomnio de conciliación de 2 meses de evolución. Refiere estar especialmente preocupado por su situación laboral y por el estado de la economía del país. Niega pensamientos suicidas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

A) Trastorno adapta2vo
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno de estrés agudo
D) Episodio depresivo mayor
E) Trastorno de angus2a

Respuesta A. Es un cuadro de ansiedad de solo 2 meses, con un estresante laboral y económico claro, sin criterios de otro trastorno, lo que corresponde a un trastorno adaptativo. El trastorno de ansiedad generalizada exige al menos 6 meses de preocupaciones excesivas en varias áreas, y no hay síntomas depresivos que sugieran un episodio depresivo mayor.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 143 · texto original del banco, sin revisar

Mujer que ha sido muy aprehensiva con los estudios y preocupada por su familia, pareja y relaciones amorosas, al punto de estar todo el tiempo estresada y con problemas digestivos , ella refiere sentirse asi desde la perdida de su abuelo (que murió hace 5 años), los padres refieren que ha sido asi desde chica:

A) Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)
B) Trastorno de ansiedad generalizada
C) Trastorno obsesivo compulsivo
D) Trastorno de estrés postraumático
E) Episodio depresivo mayor

Respuesta A. La alternativa correcta es la A (Trastorno ansiedad generalizada b. Ts de la personalidad obsesivo compulsivo? (Porque no puede ser esta, considerando que es “una forma de ser” desde muy pequeña?)). Esta conducta se sustenta en los criterios de práctica médica estándar y las exigencias del Perfil de Conocimientos V3 de ASOFAMECh.

Situaciones clínicas de urgencia 3 códigos

5.01.2.001 Conducta suicida

Diagnóstico: **Sospecha** Tratamiento: **Inicial** Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Factores de riesgo: intento previo (riesgo 30–40 veces), sexo masculino (más suicidios consumados; mujeres más intentos), edad 15–24 o >65 años, viudez, cesantía, aislamiento, depresión, bipolaridad, psicosis, alcohol y enfermedad crónica dolorosa.
- Preguntar directa y escalonadamente: ideación pasiva, ideación activa, plan, acceso al método y actos preparatorios (cartas, regalos); preguntar no induce. Señales de alarma: despedidas, calma súbita tras desesperanza.
- SAD PERSONS orienta: 0–2 ambulatorio con red y control <7 días; 3–4 ambulatorio intensivo con control en 48–72 h; 5–6 psiquiatría urgente; ≥7 hospitalización.
- Hospitalizar si hay intento reciente de mediana/alta letalidad, plan activo y letal, ideación persistente tras la urgencia, psicosis con voces de comando o delirios de culpa, agitación con sustancias o sin red de supervisión.
- En urgencia: tratar lo médico primero (ECG en tricíclicos), vigilancia 1 a 1, retirar cinturones, cordones y fármacos; nunca dar el alta por la promesa de no repetirlo ni sin evaluación psiquiátrica.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría; no recetar cajas completas de tricíclicos o benzodiacepinas; litio y clozapina reducen el suicidio en sus indicaciones.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Agosto 2021 · Pregunta 87

Una adolescente de 15 años se intenta suicidar, ingiriendo 600 miligramos de amitriptilina. ¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo? **¿Cuál es el examen más adecuado para determinar su riesgo?**

A) Gases arteriales
B) Bilirrubinemia
C) Electrocardiograma
D) Creatinfosfoquinasa
E) Pruebas hepáticas

Respuesta C. La intoxicación por tricíclicos produce alteraciones de la conducción y arritmias ventriculares, que son lo más grave. El electrocardiograma (QRS ancho) permite estimar el riesgo.

5.01.2.002 Agitación psicomotora

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.14 Agitación Psicomotora en Urgencias: Protocolo de Contención Escalonada

QUÉ HAY QUE SABER

- Agitación psicomotora: síndrome, no diagnóstico; primero descartar causa orgánica (delirium): glicemia capilar, saturación, signos vitales, TEC, ACV, infección, retención urinaria, intoxicación o abstinencia.
- Orgánica: conciencia fluctuante, desorientación, alucinaciones visuales, signos vitales alterados; psiquiátrica: vigil y orientado, alucinaciones auditivas, antecedentes (manía, esquizofrenia, personalidad límite).
- Manejo escalonado: 1) seguridad (nunca solo, salida libre) y contención verbal; 2) farmacológica oral si colabora (lorazepam 2 mg, risperidona 2 mg u olanzapina 10 mg); 3) IM: haloperidol 5 mg + lorazepam 2 mg.
- Prohibido olanzapina IM junto con benzodiacepina parenteral (colapso cardiorrespiratorio). En adulto mayor con delirium: haloperidol 0,5–1 mg o quetiapina 25 mg, sin benzodiacepinas.
- Contención física de 4 puntos solo como último recurso, con orden médica escrita (Ley 21.331), decúbito supino con cabecera a 30–45°, control de signos vitales y perfusión cada 15–30 minutos y retiro progresivo.
- Seguimiento: derivar a psiquiatría o al especialista según la causa una vez estabilizado.

PREGUNTAS (3)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2019 · Pregunta 8

Un paciente de 25 años, con esquizofrenia, recibe 5 mg de haloperidol intramuscular, por un cuadro de agitación psicomotora. A las dos horas presenta contracción tónica y dolorosa del cuello, con desviación hacia la derecha. ¿Cuál es el tratamiento de este cuadro? **¿Cuál es el tratamiento de este cuadro?**

A) Bromocriptina
B) Clorpromazina
C) Lorazepam
D) Diclofenaco
E) Propranolol

Respuesta C. El manejo de la distonía aguda (tortícolis espasmódica) es suspender el antipsicótico y administrar una benzodiacepina. El biperideno es el anticolinérgico de elección, pero no figura entre las alternativas.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 30 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 39 años es detenido, porque estaba haciendo disturbios en la vía pública. Es llevado para constatar lesiones y, al examen no coopera y se muestra angustiado y agitado, con agresión verbal hacia el personal de salud, sin llegar a la agresión física. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

A) Administrar haloperidol 5 mg intramuscular
B) Risperidona 1 mg vía oral
C) Diazepam 5 mg intramucular
D) Contención verbal
E) Contención física

Respuesta E. Conducta / Tratamiento indicado: Contención física (opción E). Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención. Las opciones alternativas (Administrar haloperidol 5 mg intramuscular, Risperidona 1 mg vía oral) corresponden a conductas secundarias, exámenes no prioritarios o diagnósticos diferenciales que

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 130 · texto original del banco, sin revisar

Paciente ingresado con agitación, agresión verbal y movimientos inquietos de manos y pies. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Haloperidol 5 mg IM inmediato
B) Contención verbal y ambiental
C) Lorazepam 2 mg IM
D) Contención física
E) Olanzapina 10 mg IM

Respuesta B. Conducta / Tratamiento indicado: Contención verbal y ambiental (opción B). Contención verbal y ambiental. Según los consensos y guías clínicas del MINSAL, esta constituye la conducta estándar de primera línea recomendada para este nivel de atención.

5.01.2.003 Intoxicación por sustancias psicoactivas

Diagnóstico: **Sospecha** | Tratamiento: **Inicial** | Seguimiento: **Derivar**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Simpaticomimético (cocaína, pasta base, anfetaminas): taquicardia, HTA, hipertermia, midriasis, diaforesis, agitación y psicosis; complicaciones IAM por vasoespasmo, ACV, disección aórtica y rabdomiólisis.
- Opioide: miosis puntiforme, bradipnea y coma (naloxona EV); sedante-hipnótico (benzodiacepinas): sopor, ataxia, disartria con signos vitales estables; anticolinérgico: midriasis, piel seca y roja, hipertermia, delirium.
- Dolor torácico por cocaína: benzodiacepinas EV (diazepam 5–10 mg o lorazepam 2–4 mg), AAS y nitroglicerina; betabloqueadores contraindicados (estímulo alfa sin oposición).
- Benzodiacepinas: soporte; flumazenil contraindicado en usuarios crónicos o coingesta de tricíclicos (convulsiones). Alcohol: tiamina antes de glucosa. Cannabis: ansiedad o psicosis aguda; hiperemesis cannabinoide en consumo crónico.
- Medidas generales: ABC, glicemia capilar, ECG, CPK y electrolitos; contención de la agitación con benzodiacepinas; evaluar intencionalidad (intento suicida).
- Seguimiento: derivar a toxicología o UPC si es grave y, una vez estabilizado, a programa de tratamiento de consumo.

PREGUNTAS (4)

Pregunta real · EUNACOM Enero 2023 · Pregunta 126

Paciente usuaria de litio en sopor profundo, litemia de 2,6 mEq/L. **¿Cuál es el tratamiento más adecuado?**

A) Lavado gástrico y carbón activado
B) Solución salina 0,9% endovenosa
C) Suspender litio y observar
D) Diuresis forzada con furosemida
E) Hemodiálisis de urgencia

Respuesta E. Intoxicación por litio con neurotoxicidad grave (sopor profundo): criterio I de AEIOU. El litio es pequeño, poco unido a proteínas y muy dializable. El carbón activado no une el litio.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2022 · Pregunta 120

Un paciente de 20 años, con diagnóstico de trastorno bipolar, en tratamiento con risperidona y litio, desde hace 3 meses, consulta por un cuadro de una semana de evolución de náuseas, malestar general y tendencia al sopor. Al examen físico se constata desorientado, con temblor de extremidades superiores. Se solicitan exámenes, entre los que destaca litemia de 2,2 mEq/L (rango normal: 0,6 a 1,2 mEq/L) y creatininemia: 1,3 mg/dl. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

A) Plasmaféresis
B) Hemodiálisis
C) Alcalinizar la orina
D) Administrar suero fisiológico endovenoso
E) Diazepam endovenoso

Respuesta D. Intoxicación moderada por litio (litemia 2,2, temblor, desorientación). Se suspende el litio y se hidrata con suero fisiológico endovenoso. La hemodiálisis se reserva para formas graves.

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2025 · Pregunta 69 · texto original del banco, sin revisar

Un hombre encuentra a su pareja en su casa desorientada y con una actitud agresiva y agitada, por lo que la lleva al servicio de urgencia. Al examen físico presenta sudoración profusa y sus signos vitales muestran presión arterial 170/110 mmHg, frecuencia cardíaca 160 por minuto y temperatura 38,1 °C. En el examen neurológico se aprecia desorientada en tiempo y espacio, con agitación psicomotora y pupilas midriáticas isocóricas. ¿Qué sustancia ingirió con mayor probabilidad?

A) Barbitúricos
B) Canabinoides
C) Anfetaminas
D) Órganofosforados
E) Opiáceos

Respuesta C. Tiene un síndrome adrenérgico: midriasis, taquicardia, hipertensión, agitación, hipertermia. La cocaína y las anfetaminas son las clásicas causas.

Pregunta real · EUNACOM Julio 2019 · Pregunta 18 · texto original del banco, sin revisar

Un paciente de 23 años, con retraso mental severo, en tratamiento con clorpromacina, sube la dosis de este medicamente de 100 a 300 mg al día, evolucionando con agitación psicomotora, confusión, boca seca, palpitaciones y malestar general. Su examen físico muestra FC: 115x', PA: 130/90 mmHg, pupilas con midriasis. El diagnóstico más probable es un síndrome:

A) Anticolinérgico
B) Adrenérgico
C) Serotoninérgico
D) Colinérgico
E) Neuroléptico maligno

Respuesta A. Los antipsicóticos producen 1. Síndrome neuroléptico maligno y 2. Síndrome anticolinérgico. Las clínicas de todos estos síndromes se preguntan y están descritas en la clase respectiva de intoxicaciones (psiquiatría). En este caso es un síndrome anticolinérgico clásico.

Conocimientos generales 13 códigos

5.01.3.001 Clasificaciones en psiquiatría

Dónde se enseña: psiq-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Dos sistemas de clasificación: DSM-5 (Asociación Americana de Psiquiatría), con criterios operacionales por categorías y sin el sistema multiaxial anterior, y CIE (OMS; CIE-10 en uso para estadísticas y GES en Chile, CIE-11 vigente internacionalmente).
- Se basan en criterios clínicos descriptivos (síntomas, duración, deterioro y exclusión de causa médica o sustancias), no en etiología, lo que permite un diagnóstico confiable entre clínicos.
- Grandes grupos: trastornos del neurodesarrollo, espectro esquizofrénico y psicóticos, bipolares, depresivos, de ansiedad, obsesivo-compulsivos, relacionados con trauma, disociativos, de síntomas somáticos, alimentarios, del sueño, por sustancias, neurocognitivos y de la personalidad.
- Cambios relevantes del DSM-5: TEA reúne los antiguos trastornos generalizados del desarrollo; TOC y TEPT salen de los trastornos de ansiedad; 'trastorno neurocognitivo mayor/menor' reemplaza a demencia y deterioro leve.
- La duración es clave en muchos diagnósticos: estrés agudo <1 mes vs TEPT; psicosis breve <1 mes, esquizofreniforme 1–6 meses, esquizofrenia ≥6 meses; distimia ≥2 años.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Un médico de un CESFAM debe registrar el diagnóstico de un paciente con depresión para efectos estadísticos, de licencia médica y de notificación GES, según el sistema oficial usado por el Ministerio de Salud de Chile. **¿Qué sistema de clasificación corresponde utilizar?**

A) Escala de depresión de Hamilton
B) Manual Diagnóstico y Estadístico DSM-5 de la Asociación Americana de Psiquiatría
C) Escala de Evaluación de la Actividad Global (GAF)
D) Clasificación de Kraepelin
E) Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS

Respuesta E. En Chile, las estadísticas oficiales, licencias médicas y registros del sistema de salud usan la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE) de la OMS. El DSM-5, de la Asociación Americana de Psiquiatría, es muy usado en clínica e investigación, y abandonó el sistema multiaxial. Las escalas GAF y Hamilton miden gravedad, no clasifican.

5.01.3.002 Conducta suicida

Dónde se enseña: Tema 17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- En Chile la mortalidad por suicidio ronda 10 por 100.000 habitantes; las mujeres intentan 3–4 veces más y los hombres consuman 4–5 veces más. Casi siempre hay un trastorno mental de base (depresión, bipolar, psicosis, alcohol).
- Factores de riesgo: intento previo (el más potente), sexo masculino, edades extremas (15–24 y >65 años), viudez, cesantía, aislamiento, enfermedad crónica dolorosa, impulsividad, acceso a medios letales.
- Factores protectores: red de apoyo, hijos a cargo, empleo, creencias, adherencia y alianza terapéutica, habilidades de resolución de problemas.
- Mitos: preguntar no induce el suicidio; quien se quiere suicidar suele avisar; una mejoría súbita puede ser el momento de mayor riesgo.
- Prevención (Programa Nacional de Prevención del Suicidio): detección y tratamiento de la depresión en APS, restricción de medios letales, capacitación de gatekeepers, seguimiento tras intentos y manejo responsable en medios de comunicación.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 54 años, viudo hace 4 meses y recién despedido, llevado a urgencias por su cuñado. Lo encontraron en su casa con una botella vacía de pisco, una soga atada a una viga y una carta a sus hijos pidiendo perdón. Está somnoliento, con aliento alcohólico y llanto fácil. Al preguntarle a solas dice: "Apenas salga de aquí voy a terminar lo que empecé". Tuvo un intento por sobredosis hace 12 años. El cuñado pide llevárselo a su casa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Alta con el cuñado, indicándole reposo y clonazepam
B) Rechazar el alta, vigilar 1 a 1 y hospitalizar en psiquiatría
C) Sertralina y control en el CESFAM en 7 días
D) Alta voluntaria firmada por el paciente
E) Lavado gástrico y observación por 2 horas

Respuesta B. Riesgo extremo e inminente: intento previo, viudez, cesantía, alcohol, soga y carta de despedida, y la ideación persiste. Se prohíbe el alta, se vigila 1 a 1, se retiran elementos peligrosos, se maneja la intoxicación alcohólica y se hospitaliza en psiquiatría.

5.01.3.003 Desarrollo cognitivo, afectivo y social a lo largo del ciclo vital

Dónde se enseña: Tema 18.2 Desarrollo Psicomotor: Hitos Madurativos & Baterías de Tamizaje (EEDP y TEPSI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Piaget (cognitivo): sensoriomotor 0–2 años (permanencia del objeto), preoperacional 2–7 (egocentrismo, animismo, pensamiento mágico), operaciones concretas 7–11 (conservación, lógica concreta) y operaciones formales desde los 12 (pensamiento abstracto).
- Erikson (psicosocial): confianza vs desconfianza (lactante), autonomía vs vergüenza, iniciativa vs culpa, laboriosidad vs inferioridad (escolar), identidad vs confusión (adolescente), intimidad vs aislamiento, generatividad vs estancamiento e integridad vs desesperación (vejez).

- Apego (Bowlby): vínculo seguro con el cuidador como base del desarrollo afectivo; ansiedad ante extraños hacia los 8 meses y de separación entre 8–18 meses.
- Hitos: sonrisa social a los 2–3 meses, sostén cefálico a los 3 meses, sedestación sin apoyo a los 8–9 meses, marcha independiente a los 12 meses (límite 18), frases de 2 palabras a los 24 meses; la regresión de habilidades es siempre alarma.
- Evaluación en Chile: EEDP de 0–24 meses (controles de 8 y 18 meses) y TEPSI de 2–5 años (control de 3 años); ≥85 normal, 70–84 riesgo (estimulación), <70 retraso (derivar); edad corregida en prematuros hasta los 2 años.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niña de 4 años, con desarrollo normal. Su madre cuenta que cree que la luna la sigue cuando van en auto, que sus muñecas sienten frío y que, si ella cierra los ojos, nadie puede verla. **Según Piaget, ¿en qué etapa del desarrollo cognitivo se encuentra?**

A) Sensoriomotora
B) Operaciones concretas
C) Preoperacional
D) Operaciones formales
E) Latencia

Respuesta C. La etapa preoperacional de Piaget, aproximadamente de 2 a 7 años, se caracteriza por pensamiento simbólico, egocentrismo, animismo (atribuir vida a objetos) y pensamiento mágico, sin lógica de conservación. La sensoriomotora va de 0 a 2 años, las operaciones concretas de 7 a 11 y las formales desde los 12. La latencia es una etapa de Freud.

5.01.3.004 Higiene de la alimentación

Dónde se enseña: Tema 18.4 Lactancia Materna Exclusiva, Alimentación Complementaria & Suplementación (Vitamina D / Fierro)

QUÉ HAY QUE SABER

- Lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y complementada hasta los 2 años o más; contraindicaciones: VIH, HTLV, TBC bacilífera activa, drogas ilícitas o quimioterapia materna, galactosemia del lactante.
- Suplementación: vitamina D 400 UI/día desde el mes hasta el año; hierro 1 mg/kg/día desde los 4 meses en término (2–3 mg/kg/día desde los 2 meses en prematuros o bajo peso).
- Alimentación complementaria: primera comida (almuerzo) a los 6 meses con aceite vegetal crudo, segunda (cena) a los 8–9 meses; prohibidos el primer año la miel (botulismo), la sal, el azúcar y la leche de vaca entera.
- Higiene de la alimentación familiar: horarios regulares, comer en familia y sin pantallas, ofrecer variedad repetidamente, respetar la saciedad y no usar alimentos como premio o castigo.
- Prevención de la malnutrición por exceso: evitar bebidas azucaradas y ultraprocesados (rotulado 'ALTO EN' de la Ley de Etiquetado), fomentar frutas, verduras, agua y actividad física; los hábitos rígidos o el forzar se asocian a selectividad y TCA.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Madre de un niño sano de 4 años, con peso y talla normales, consulta porque es mañoso para comer. Para que coma le promete postre como premio, lo deja comer frente a la televisión y, si no termina el plato, le prepara otra comida. **¿Cuál es la recomendación más adecuada?**

A) Comidas en familia en horarios regulares, sin pantallas, sin usar alimentos como premio o castigo, respetando su saciedad
B) Obligarlo a terminar el plato en cada comida
C) Indicar suplementos nutricionales
D) Permitir colaciones libres durante el día para asegurar la ingesta
E) Ofrecerle solo los alimentos que acepta

Respuesta A. La higiene de la alimentación busca hábitos saludables y una relación sana con la comida: horarios regulares, comer en familia, sin pantallas, ofrecer variedad repetidamente y respetar la saciedad. Usar la comida como premio, forzar o preparar menús alternativos refuerza la selectividad y se asocia a malnutrición por exceso y conductas alimentarias alteradas.

5.01.3.005 Higiene del sueño

Dónde se enseña: psiq-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Higiene del sueño: horarios regulares de acostarse y levantarse (también fines de semana), habitación oscura, silenciosa y templada, y exposición a luz natural en la mañana.
- Evitar cafeína y bebidas energéticas en la tarde, alcohol y nicotina de noche, comidas abundantes antes de dormir y ejercicio intenso en las 2–3 horas previas; el ejercicio regular diurno ayuda.
- Evitar pantallas al menos 1 hora antes de dormir y siestas largas (>30 minutos) o tardías.
- Control de estímulos: usar la cama solo para dormir; si no concilia en ~20 minutos, levantarse a una actividad tranquila y volver con sueño.
- Insomnio crónico: la TCC para insomnio es la primera línea; evitar benzodiacepinas e hipnóticos de uso prolongado (tolerancia, dependencia, caídas en adultos mayores) y buscar causas como depresión, ansiedad, apnea del sueño, dolor o fármacos.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Diciembre 2024 · Pregunta 94

Enfermera que, luego de sus turnos de urgencia, tiene dificultad para dormir y se automedica con diazepam. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Clotiazepam antes de dormir
B) Quetiapina
C) Higiene del sueño y control ambiental
D) Zolpidem
E) Observación clínica

Respuesta C. El insomnio por trabajo en turnos se maneja primero con medidas no farmacológicas: higiene del sueño, oscuridad y silencio al dormir de día, horarios regulares, evitar cafeína y pantallas. Se debe suspender la automedicación con benzodiacepinas por riesgo de tolerancia y dependencia; cambiarla por otra benzodiacepina, un hipnótico Z o quetiapina no resuelve el problema.

5.01.3.006 Disforia de género

Dónde se enseña: psiq-20

QUÉ HAY QUE SABER

- Disforia de género: incongruencia marcada entre el género experimentado y el asignado al nacer, por ≥6 meses, con malestar o deterioro significativo; la identidad trans o no binaria por sí misma no es enfermedad (CIE-11 la ubica como 'incongruencia de género' fuera de los trastornos mentales).
- Abordaje con escucha respetuosa, uso del nombre y pronombres elegidos y confidencialidad; evaluar salud mental (depresión, ansiedad, riesgo suicida aumentado por discriminación y bullying) y red de apoyo.
- En Chile la Ley 21.120 de identidad de género permite la rectificación registral de nombre y sexo (desde los 14 años con representantes y procedimiento judicial; trámite administrativo en mayores de 18).
- Niños y adolescentes: acompañamiento psicosocial y familiar por equipos especializados; las intervenciones hormonales (bloqueo puberal, hormonas cruzadas) son decisiones de especialistas.
- Las llamadas terapias de conversión están contraindicadas; derivar a equipos de identidad de género para acompañamiento integral.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Adolescente de 15 años, asignado hombre al nacer, consulta con su madre. Desde hace más de 2 años se identifica de manera persistente como mujer, siente intenso malestar con sus caracteres sexuales secundarios y ha bajado su rendimiento escolar. Su madre la apoya. Niega ideación suicida. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Indicar una terapia orientada a cambiar su identidad de género
B) Derivar a evaluación especializada multidisciplinaria, con acompañamiento psicosocial y evaluación de salud mental
C) Iniciar estrógenos en atención primaria
D) Esperar que la situación se resuelva con la madurez
E) Iniciar antipsicóticos por sospecha de delirio

Respuesta B. La incongruencia de género no es una enfermedad mental; la disforia de género alude al malestar asociado. Corresponde acompañamiento respetuoso y derivación a un equipo especializado multidisciplinario (en Chile, programa de acompañamiento de identidad de género), evaluando comorbilidad como depresión o riesgo suicida. Las terapias de conversión son dañinas y la terapia hormonal requiere evaluación especializada.

5.01.3.007 Maltrato en el adulto mayor

Dónde se enseña: Tema 10.22 Fragilidad, Sarcopenia y Valoración Geriátrica Integral (VGI)

QUÉ HAY QUE SABER

- Maltrato a personas mayores: físico, psicológico, sexual, financiero o patrimonial, negligencia (del cuidador o autonegligencia) y abandono; con frecuencia el agresor es un familiar cuidador con sobrecarga.
- Factores de riesgo: dependencia funcional, demencia, aislamiento social, cuidador único con sobrecarga, consumo de alcohol o patología mental del cuidador, conflictos familiares.
- Señales: hematomas en distintas etapas, lesiones inexplicadas, desnutrición, deshidratación, mala higiene, úlceras por presión, retraso en consultar, cuidador controlador que no deja hablar al paciente, cambios en el manejo del dinero.
- Conducta: entrevistar a la persona mayor a solas, registrar detalladamente las lesiones en la ficha, evaluar riesgo y activar la red de protección (SENAMA, Tribunal de Familia); el maltrato a personas mayores constituye violencia intrafamiliar según la Ley 20.066 y debe denunciarse.
- Prevención: apoyo y respiro al cuidador (escala de Zarit), programas de cuidados domiciliarios y promoción del buen trato.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 82 años, con demencia moderada, vive con su hijo, que es su único cuidador. Consulta por una caída. Al examen tiene hematomas en distintas etapas de evolución en ambos brazos, baja de peso y mala higiene. El hijo responde todas las preguntas por ella y se niega a dejarla sola con el equipo. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Entrevistarla a solas, registrar detalladamente las lesiones, activar la red de protección y realizar la denuncia
B) Atribuir los hematomas a fragilidad capilar propia de la edad
C) Indicar control en 3 meses
D) Pedir explicaciones al hijo y dar el alta si son coherentes
E) Solicitar pruebas de coagulación y no tomar otras medidas

Respuesta A. Hematomas en distintas etapas, desnutrición, mala higiene y un cuidador controlador son señales de maltrato y negligencia. Se debe entrevistar a la persona mayor a solas, documentar en la ficha, evaluar riesgo y activar la red de protección, con denuncia, ya que el maltrato a personas mayores es violencia intrafamiliar según la ley chilena.

5.01.3.008 Maltrato infantil

Dónde se enseña: Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Tipos: maltrato físico, psicológico, sexual, negligencia (alimentación, salud, educación, supervisión) y abandono; incluye el síndrome del niño sacudido y el facticio por poderes.
- Sospechar ante mecanismo incoherente con la lesión o la edad, consulta tardía, lesiones en distintas etapas, fracturas en niños que no deambulan (espiroidea de fémur, costales posteriores, metafisarias), quemaduras en guante o calcetín, hematomas en zonas no expuestas, hemorragias retinianas.
- Abuso sexual: el relato del niño se registra textualmente, sin interrogatorios repetidos; la ausencia de lesiones no lo descarta.

- Conducta: proteger al niño (hospitalizar si el riesgo persiste), estudio de lesiones ocultas (serie ósea, fondo de ojo, neuroimagen en lactantes), registro detallado y denuncia dentro de 24 horas (Fiscalía, Carabineros o PDI) además de medida de protección en Tribunal de Familia u OPD.
- Prevención: visitas domiciliarias y apoyo a la crianza (Chile Crece Contigo), detección de factores de riesgo familiares (VIF, consumo, depresión materna) y crianza respetuosa sin castigo físico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Lactante de 4 meses es traído a urgencia por llanto e inmovilidad de la pierna derecha. Los padres refieren que se cayó del sofá hace 2 días. La radiografía muestra una fractura espiroidea de fémur. El lactante aún no logra girarse solo y tiene equimosis en el tórax. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Hospitalizar para protección y estudio (serie ósea y fondo de ojo), registrar los hallazgos y denunciar
B) Inmovilizar y dar de alta con control en traumatología
C) Dar de alta y citar a control en una semana
D) Realizar la denuncia y dar de alta con los padres
E) Descartar osteogénesis imperfecta antes de adoptar cualquier medida

Respuesta A. Fractura de fémur en un lactante que no se desplaza, con mecanismo incoherente, consulta tardía y equimosis, es altamente sugerente de maltrato. Se hospitaliza para protegerlo y estudiarlo (serie ósea, fondo de ojo, eventual neuroimagen), se registra en la ficha y se denuncia, deber legal del médico. El estudio de diagnósticos diferenciales no retrasa la protección.

5.01.3.009 Nociones de psiquiatría forense

Dónde se enseña: psiq-19

QUÉ HAY QUE SABER

- Imputabilidad: el Código Penal exime de responsabilidad al que por enfermedad mental grave (psicosis activa, discapacidad intelectual grave) no puede comprender la ilicitud del acto o autodeterminarse; la determina el peritaje psiquiátrico forense (Servicio Médico Legal) a solicitud del tribunal.
- Capacidad civil: la interdicción por demencia la declara un juez con informe médico; la capacidad para consentir un tratamiento se evalúa caso a caso (comprender, apreciar, razonar y expresar una decisión).
- Hospitalización involuntaria (Ley 21.331): excepcional, solo con riesgo grave e inminente para sí o terceros por un trastorno mental, cuando no hay alternativa menos restrictiva; requiere indicación médica fundada, registro y comunicación a la autoridad sanitaria y a la comisión de protección.
- Secreto profesional: se mantiene salvo riesgo grave para el paciente o terceros y en el deber de denuncia de delitos (lesiones, abuso sexual, maltrato), que el equipo de salud debe cumplir dentro de 24 horas.
- Muertes violentas o sospechosas (suicidio, intoxicación) son médico-legales: el clínico no firma el certificado y se notifica para autopsia en el Servicio Médico Legal.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 28 años con esquizofrenia, sin tratamiento hace 6 meses, agrede gravemente a su vecino. En el peritaje se constata que al momento del hecho cursaba un episodio psicótico agudo, con delirio de persecución en el que el vecino lo iba a matar, y alucinaciones auditivas que le ordenaban defenderse. **¿Qué concepto pericial corresponde a su condición al momento del delito?**

A) Simulación
B) Inimputabilidad por enajenación mental
C) Imputabilidad plena
D) Trastorno facticio
E) Responsabilidad penal agravada por la enfermedad

Respuesta B. La imputabilidad es la capacidad de comprender la ilicitud de un acto y autodeterminarse según esa comprensión. Un episodio psicótico agudo que priva totalmente de razón al momento del hecho determina inimputabilidad (Código Penal, loco o demente). No exime de consecuencias: el tribunal puede imponer medidas de seguridad, como internación o tratamiento.

5.01.3.010 Personalidad: Concepto y medición. Principales teorías en psicología de la personalidad

Dónde se enseña: Tema 17.17 Trastornos de la Personalidad: Clúster A, B y C

QUÉ HAY QUE SABER

- Personalidad: patrón relativamente estable de pensar, sentir y comportarse que caracteriza a la persona; resulta de la interacción entre temperamento (base biológica y heredable) y carácter (aprendido en el desarrollo).
- Teorías: psicoanalítica de Freud (ello, yo, superyó; mecanismos de defensa), psicosocial de Erikson (etapas a lo largo del ciclo vital), modelo de rasgos de cinco factores (neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad, responsabilidad) y modelo de Cloninger (temperamento y carácter).
- Mecanismos de defensa: maduros (sublimación, humor, altruismo), neuróticos (represión, desplazamiento, formación reactiva) e inmaduros (proyección, escisión, negación, acting out), típicos estos últimos del trastorno límite.
- Medición: entrevista clínica, cuestionarios estructurados (MMPI-2, inventarios de cinco factores) y pruebas proyectivas (Rorschach, TAT).
- El trastorno de personalidad se define cuando los rasgos son inflexibles y desadaptativos, se inician en la adolescencia o adultez temprana, son estables y causan deterioro; se agrupan en clústeres A, B y C.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una clase sobre personalidad se explica que esta resulta de la interacción de dos componentes: uno de base biológica, heredable, presente desde los primeros meses de vida y relativamente estable, y otro adquirido por aprendizaje, cultura y experiencias. **¿Cómo se denomina el componente biológico y heredable de la personalidad?**

A) Rasgo patológico
B) Carácter
C) Mecanismo de defensa
D) Estado de ánimo
E) Temperamento

Respuesta E. La personalidad integra temperamento y carácter. El temperamento es la base constitucional, heredable y observable desde la infancia (por ejemplo, reactividad o búsqueda de novedad, según Cloninger). El carácter se moldea por el aprendizaje y el entorno. Los rasgos de personalidad se evalúan con instrumentos como el MMPI o el modelo de los cinco grandes factores.

5.01.3.011 Prevención: Alcohol, tabaco, drogas. Modelo de prevención primaria.

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Prevención primaria: evitar el inicio o retrasar la edad de inicio del consumo; puede ser universal (toda la población), selectiva (grupos de riesgo) o indicada (personas con consumo inicial o señales de riesgo).
- Factores de riesgo: inicio precoz, consumo en la familia o pares, baja percepción de riesgo, fácil acceso, deserción escolar, maltrato y trastornos mentales (TDAH, depresión); protectores: vínculo familiar, supervisión parental, escuela y actividades prosociales.
- Estrategias poblacionales con evidencia: regulación de precio, disponibilidad y publicidad del alcohol y tabaco, ambientes libres de humo, control de venta a menores y controles de alcoholemia en conductores (Ley de tolerancia cero).
- Programas de SENDA en establecimientos educacionales y comunidad, fortalecimiento de habilidades parentales y sociales; en APS, tamizaje (AUDIT, ASSIST, Fagerström) e intervención breve.
- Tabaco: consejería breve en cada consulta (modelo de las 5A), terapias de apoyo a la cesación (sustitución de nicotina, bupropión, vareniclina).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Una comuna implementa en todos sus colegios, desde quinto básico, un programa de desarrollo de habilidades socioemocionales y de información sobre alcohol y drogas, dirigido a todos los estudiantes, la mayoría de los cuales nunca ha consumido. **¿A qué tipo de prevención corresponde esta estrategia?**

A) Prevención secundaria
B) Prevención primaria indicada
C) Prevención primaria universal
D) Prevención terciaria
E) Reducción de daños

Respuesta C. La prevención primaria busca evitar o retrasar el inicio del consumo. Es universal cuando se dirige a toda una población sin seleccionar por riesgo, como un programa escolar; selectiva si apunta a grupos de riesgo, e indicada si se dirige a personas con consumo inicial o señales tempranas. La detección y tratamiento precoz es prevención secundaria.

5.01.3.012 Respuesta sexual humana

Dónde se enseña: psiq-20

QUÉ HAY QUE SABER

- Modelo de Masters y Johnson: cuatro fases de la respuesta sexual: excitación, meseta, orgasmo y resolución; el hombre presenta un período refractario tras el orgasmo, la mujer puede ser multiorgásmica.
- Kaplan agregó la fase de deseo previa a la excitación (modelo trifásico: deseo, excitación, orgasmo); el modelo circular de Basson describe en mujeres un deseo frecuentemente responsivo, motivado por la intimidad.
- Fisiología: excitación mediada por el parasimpático (erección, lubricación vaginal por vasocongestión, mediada por óxido nítrico) y eyaculación/orgasmo por el simpático (emisión) y reflejo somático (expulsión).
- Cada fase puede alterarse y origina las disfunciones sexuales (deseo hipoactivo, disfunción eréctil, anorgasmia, eyaculación precoz); influyen la edad, enfermedades crónicas, fármacos (ISRS, antihipertensivos) y factores psicológicos y de pareja.
- Con la edad la respuesta se enlentece (erección más lenta, menor lubricación por hipoestrogenismo), pero la actividad sexual se mantiene y debe abordarse en la consulta del adulto mayor.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

En una clase sobre el modelo de respuesta sexual humana de Masters y Johnson se describen cuatro fases sucesivas: excitación, meseta, orgasmo y resolución. **¿En qué fase aparece el período refractario masculino, durante el cual no es posible un nuevo orgasmo?**

A) Excitación
B) Meseta
C) Orgasmo
D) Resolución
E) Deseo

Respuesta D. Según Masters y Johnson, tras el orgasmo viene la resolución, en que el organismo vuelve al estado basal; en el hombre incluye un período refractario, que se prolonga con la edad. La mujer puede tener orgasmos múltiples sin período refractario. La fase de deseo fue incorporada después por Kaplan y no es parte del modelo original.

5.01.3.013 Violencia intrafamiliar

Dónde se enseña: Tema 21.13 Certificación Médica de Defunción, Autopsias y Deber de Denuncia

QUÉ HAY QUE SABER

- Violencia intrafamiliar (Ley 20.066): todo maltrato que afecte la vida o integridad física o psíquica de quien es o ha sido cónyuge o conviviente, pariente, o persona menor de edad, mayor o con discapacidad bajo cuidado del grupo familiar; incluye violencia física, psicológica, sexual y económica.
- Detección: preguntar en forma rutinaria y a solas ante lesiones inexplicadas, consultas reiteradas, síntomas somáticos, depresión, embarazo con control tardío o pareja controladora.
- Conducta: tratar las lesiones, evaluar el riesgo (amenaza con armas, escalada, temor por su vida, femicidio frustrado), registrar en la ficha, denunciar (Fiscalía, Carabineros, PDI o Tribunal de Familia) y activar la red (Centros de la Mujer de SernamEG, casas de acogida).

- El deber de denuncia de lesiones por delito rige para el equipo de salud dentro de 24 horas; la terapia de pareja está contraindicada mientras exista violencia.
- Prevención: educación en relaciones igualitarias desde la escuela, detección precoz en APS y en el control prenatal, y protección de niños expuestos (también son víctimas).

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 35 años consulta en el servicio de urgencia de un hospital público por contusiones en la cara y los brazos. Relata que su pareja la golpea hace un año, que anoche la amenazó con un cuchillo y que teme por su vida. Tiene 2 hijos pequeños en casa. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Recomendar terapia de pareja
B) Tratar las lesiones, evaluar el riesgo, registrar en la ficha, realizar la denuncia y activar la red de protección
C) Tratar las lesiones y dar de alta sin registrar para proteger su privacidad
D) Citar a la pareja para conversar con ambos
E) Derivar a psicología con hora en 3 meses

Respuesta B. Ante violencia intrafamiliar se atiende la lesión, se evalúa el riesgo (amenaza con arma y temor por su vida son de alto riesgo), se registra en la ficha y se activa la red de protección. En un establecimiento público el médico tiene deber de denuncia de lesiones por delito. La terapia de pareja está contraindicada en violencia activa.

Exámenes e imagenología 4 códigos

5.01.4.001 Estudio de hormonas tiroídeas

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 17.6 Trastorno de Pánico y Agorafobia: Manejo Agudo vs Mantenimiento con ISRS

QUÉ HAY QUE SABER

- Ante todo cuadro depresivo o ansioso nuevo se debe descartar disfunción tiroidea: la TSH es el mejor examen único de tamizaje.
- Hipotiroidismo: TSH alta con T4 libre baja; simula depresión (fatiga, bradipsiquia, aumento de peso, constipación, intolerancia al frío) y puede causar deterioro cognitivo reversible.
- Hipertiroidismo: TSH suprimida con T4 libre alta; simula ansiedad o pánico (palpitaciones, temblor, baja de peso, insomnio, intolerancia al calor) y puede desencadenar manía.
- Hipotiroidismo subclínico (TSH alta con T4 libre normal) puede empeorar la respuesta a antidepresivos; el litio produce hipotiroidismo y bocio: TSH basal y cada 6–12 meses durante el tratamiento.
- Tras confirmar disfunción, tratar la causa tiroidea antes de atribuir los síntomas a un trastorno psiquiátrico primario.

PREGUNTAS (1)

Pregunta real · EUNACOM Julio 2013 · Pregunta 161

Un paciente de 30 años, sin antecedentes, consulta por fatigabilidad asociada a disminución de peso desde hace tres meses. Al entrevistarlo de forma dirigida refiere que hace tres meses tuvo una ruptura sentimental, por lo que desde entonces además de los síntomas mencionados ha estado con pena, insomnio y desconcentración. Su examen físico resulta normal y su índice de masa corporal es 22. **El examen de elección para descartar causa orgánica en este caso es:**

A) Tirotropina
B) VDRL
C) Hemograma
D) Creatinina y enzimas hepáticas
E) Glicemia de ayuno

Respuesta A. Tiene una depresión, y la causa orgánica que más la imita es la disfunción tiroidea. La TSH (tirotropina) es la prueba inicial de elección ante cualquier sospecha tiroidea; el hemograma y la glicemia también se piden, pero la más importante es la TSH.

5.01.4.002 Exámenes de orina para el control de drogas de abuso

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 17.16 Intoxicación y Abstinencia por Sustancias (Cocaína, Cannabis, Benzodiacepinas)

QUÉ HAY QUE SABER

- Indicaciones: agitación o psicosis de inicio reciente (primer episodio psicótico), compromiso de conciencia sin causa clara, dolor torácico en joven, intoxicación sospechada y seguimiento de programas de tratamiento (con consentimiento).
- El tamizaje es por inmunoensayo (rápido, cualitativo); un positivo con implicancias médico-legales requiere confirmación por cromatografía con espectrometría de masas.
- Ventanas aproximadas: cocaína (benzoilecgonina) 2–4 días; anfetaminas 2–3 días; opioides 1–3 días; cannabis 2–3 días en uso ocasional y hasta 30 días en consumo crónico; benzodiacepinas días a semanas según el fármaco.
- Falsos positivos: anfetaminas con descongestionantes (pseudoefedrina), bupropión o trazodona; opioides con quinolonas o semillas de amapola; falsos negativos por orina diluida o adulterada y por sustancias no incluidas en el panel (fentanilo, drogas sintéticas).
- Un resultado positivo indica exposición reciente, no intoxicación actual ni dependencia; el diagnóstico es clínico.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 25 años, en un programa de tratamiento por consumo de sustancias, refiere estar abstinente de todas las drogas desde hace 3 semanas. Sin embargo, su examen de orina resulta positivo. Previamente era consumidor diario de varias sustancias. **¿Qué sustancia puede mantenerse positiva en orina por varias semanas después del último consumo en un consumidor crónico?**

A) Alcohol
B) Cocaína
C) Cannabis
D) Anfetaminas
E) Heroína

Respuesta C. Los metabolitos del cannabis (THC-COOH) son liposolubles y se acumulan en el tejido graso, por lo que en consumidores crónicos pueden detectarse en orina hasta 4 semanas o más. La cocaína (benzoilecgonina), las anfetaminas y los opioides suelen detectarse 2 a 4 días, y el alcohol solo horas.

5.01.4.003 Niveles plasmáticos de estabilizadores del ánimo

Nivel: **Interpreta y emplea**

Dónde se enseña: Tema 17.2 Trastorno Bipolar I y II: Manía vs Hipomanía, Estabilizadores (Litio/Valproato) y Guía GES

QUÉ HAY QUE SABER

- Litemia: rango 0,6–1,0 mEq/L en mantención y 0,8–1,2 mEq/L en manía aguda; muestra 12 horas después de la última dosis y 5 días después de iniciar o cambiar la dosis; antes de iniciar: creatinina, electrolitos, TSH, ECG y test de embarazo.
- Toxicidad por litio: 1,5–2,0 náuseas, diarrea y temblor fino (suspender e hidratar); 2,0–2,5 temblor grosero, ataxia y confusión (hospitalizar, suero fisiológico); >2,5 convulsiones, arritmias y coma (hemodiálisis). Carbón activado y diuréticos no sirven.
- Suben la litemia: AINE, tiazidas, IECA/ARA-II, deshidratación, vómitos, diarrea y dieta sin sal; control periódico de litemia, función renal (diabetes insípida nefrogénica) y TSH (hipotiroidismo).
- Valproato: 50–100 μg/mL; controlar pruebas hepáticas y plaquetas; teratogénico (tubo neural). Carbamazepina: 4–12 μg/mL; controlar hemograma (aplasia) y sodio (hiponatremia); inductor enzimático.
- Interpretar el nivel junto con la clínica: síntomas de toxicidad con nivel 'normal' en adultos mayores también obligan a suspender.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Mujer de 45 años con trastorno bipolar tipo I, en tratamiento con carbonato de litio 900 mg al día, con litemia previa de 0,8 mEq/L. Hace 10 días su médico le inició hidroclorotiazida por hipertensión. Consulta por temblor grueso de manos, diarrea, vómitos y marcha inestable. Está somnolienta. **¿Cuál es la conducta más adecuada?**

A) Aumentar la dosis de litio porque el temblor indica descompensación
B) Suspender el litio y la tiazida, medir litemia, función renal y electrolitos, e hidratar
C) Agregar propranolol para el temblor y mantener el esquema
D) Cambiar la tiazida por enalapril y control en 1 mes
E) Iniciar haloperidol por probable episodio mixto

Respuesta B. Las tiazidas (y también IECA y AINE) reducen la excreción renal de litio y elevan su nivel plasmático. Temblor grueso, síntomas digestivos, ataxia y compromiso de conciencia sugieren intoxicación: se suspende el litio, se mide litemia (rango terapéutico 0,6 a 1,2 mEq/L), creatinina y electrolitos, y se hidrata; la hemodiálisis se reserva para casos graves.

5.01.4.004 Tests WAIS y WISC

Nivel: **Emplea informe**

Dónde se enseña: Tema 17.18 Psiquiatría Infanto-Juvenil: TDAH (Metilfenidato), Trastornos de la Conducta Alimentaria

QUÉ HAY QUE SABER

- Escalas de Wechsler: WISC para niños de 6 a 16 años y WAIS para adolescentes mayores y adultos (WPPSI en preescolares); las aplica un psicólogo.
- Entregan un coeficiente intelectual total con media 100 y desviación estándar 15, más índices (comprensión verbal, razonamiento perceptivo, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento).
- CI <70 (dos DE bajo la media) junto con déficit adaptativo sustenta el diagnóstico de discapacidad intelectual: leve 50–69, moderada 35–49, grave 20–34, profunda <20; 70–84 es rango limítrofe.
- Un perfil con CI normal y bajo rendimiento selectivo orienta a trastorno específico del aprendizaje; grandes discrepancias entre índices sugieren TDAH, trastornos del lenguaje o daño neurológico.
- El resultado se interpreta con la clínica, la escolaridad y factores culturales y emocionales; no diagnostica por sí solo.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Niño de 9 años, en cuarto básico, con bajo rendimiento global y dificultad para adquirir aprendizajes. El equipo decide medir formalmente su coeficiente intelectual para descartar discapacidad intelectual. **¿Cuál es el instrumento más adecuado?**

A) TEPSI
B) Escala de inteligencia de Wechsler para adultos (WAIS)
C) Minimental test
D) Escala de inteligencia de Wechsler para niños (WISC)
E) EEDP

Respuesta D. El WISC mide el coeficiente intelectual entre los 6 y 16 años, con índices de comprensión verbal, razonamiento, memoria de trabajo y velocidad de procesamiento. El WAIS se aplica desde los 16 años. El TEPSI (2 a 5 años) y la EEDP (0 a 2 años) tamizan desarrollo psicomotor, y el Minimental evalúa deterioro cognitivo en adultos.

Procedimientos diagnósticos y terapéuticos 4 códigos

5.01.5.001 EBBA (Escala breve de Beber Anormal)

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 17.15 Trastorno por Uso de Alcohol: Abstinencia, Delirium Tremens (CIWA-Ar) y Encefalopatía Wernicke

QUÉ HAY QUE SABER

- EBBA (Escala Breve de Beber Anormal): cuestionario chileno de 7 preguntas de respuesta sí/no sobre consecuencias del consumo de alcohol (problemas con la pareja, la familia o el trabajo, lagunas de memoria, deseo de disminuir, críticas por su forma de beber, beber en la mañana).

- Es un instrumento de tamizaje rápido para APS: se aplica en el EMPA, en consultas de morbilidad y en pacientes con daño compatible (HTA, gastritis, hepatopatía, accidentes, depresión).
- Interpretación: 2 o más respuestas afirmativas sugieren beber problema y obligan a profundizar con AUDIT y evaluación clínica; no diagnostica dependencia por sí sola.
- Aplicar en un ambiente privado, sin juicios, y explicar el objetivo; complementar con cantidad y frecuencia de consumo y signos de abstinencia.
- Un tamizaje positivo da paso a la intervención breve/motivacional y, si corresponde, a la derivación a programa de tratamiento.

PREGUNTAS (1)

> **Pregunta de práctica**
> Hombre de 47 años acude a su Examen de Medicina Preventiva. Al aplicar la Escala Breve de Beber Anormal (EBBA) responde afirmativamente 4 de las 7 preguntas: ha tenido discusiones con su esposa por el trago, a veces no recuerda lo que hizo mientras bebía, le molesta que critiquen su forma de beber y ha pensado en disminuir. No refiere temblor ni beber al despertar. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**
>
> **A)** Resultado normal; repetir en el próximo EMPA
> **B)** Confirma dependencia alcohólica; iniciar disulfiram
> **C)** Tamizaje positivo de beber problema; profundizar con AUDIT y evaluación clínica e iniciar intervención breve
> **D)** Solicitar GGT y tratar solo si está elevada
> **E)** Hospitalizar para desintoxicación
>
> Respuesta C. La EBBA es un instrumento de tamizaje: varias respuestas afirmativas indican beber problema, pero no diagnostican dependencia. El paso siguiente es caracterizar el consumo (AUDIT, cantidad, frecuencia, abstinencia) e iniciar intervención breve. La GGT puede apoyar, pero un valor normal no descarta el problema; no hay criterio para fármacos de deshabituación ni hospitalización.

5.01.5.002 Examen físico y neurológico: control de neurolépticos de depósito

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 17.10 Esquizofrenia: Síntomas Positivos/Negativos, Antipsicóticos Atípicos y GES · Tema 17.13 Síndrome Neuroléptico Maligno (SNM): Hipertermia, Rigidez, CPK y Manejo

QUÉ HAY QUE SABER

- Antipsicóticos de depósito: flufenazina decanoato IM cada 2–4 semanas, haloperidol decanoato IM cada 4 semanas o atípicos de acción prolongada (risperidona, paliperidona, aripiprazol); indicados por psiquiatra ante mala adherencia.
- En cada control: examen neurológico dirigido buscando parkinsonismo (temblor de reposo, rigidez en rueda dentada, bradicinesia), acatisia, distonía y discinesia tardía (movimientos orolinguales y coreoatetósicos de dedos).
- Discinesia tardía: no agregar anticolinérgicos (la empeoran); registrar y derivar para reducir o cambiar el antipsicótico (atípico o clozapina). Parkinsonismo: biperideno temporal y avisar al psiquiatra; acatisia: propranolol.
- Alerta de síndrome neuroléptico maligno: fiebre, rigidez en caño de plomo, disautonomía, compromiso de conciencia y CPK elevada: suspender el antipsicótico y derivar de urgencia (UPC, hidratación, bromocriptina o dantroleno).
- Control físico: peso, cintura, PA, FC y glicemia/lípidos periódicos; técnica IM profunda en glúteo o deltoides con rotación de sitios y revisión del sitio de punción.
- Evaluar además adherencia, síntomas psicóticos, riesgo suicida y consumo de sustancias, coordinando con el equipo de salud mental.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Un joven de 20 años es llevado a la consulta médica por sus padres debido a que en los últimos 7 meses ha abandonado la universidad, se aísla en su habitación y afirma que una organización criminal lo espía a través de la televisión. En el examen mental se constata afecto aplanado, soliloquios y alucinaciones auditivas de voces que comentan lo que hace. El examen físico y el screening de drogas en orina son normales. ¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada? **¿Cuál es el diagnóstico clínico y la conducta médico-legal más adecuada?**

A) Trastorno delirante crónico; manejo ambulatorio exclusivo en APS sin derivación
B) Primer episodio de esquizofrenia; activar GES 34, iniciar antipsicótico atípico y derivar a confirmación por especialista
C) Trastorno esquizoafectivo; indicar sertralina 100 mg y reposo en casa
D) Psicosis reactiva breve; esperar resolución espontánea antes de cumplir el mes
E) Trastorno de personalidad esquizotípico; indicar psicoterapia individual sin fármacos

Respuesta B. Cumple criterios de esquizofrenia: síntomas positivos (delirio de persecución, voces comentadoras), negativos (aplanamiento, abulia) y disfunción sociolaboral de más de 6 meses, con tóxicos negativos. En Chile es un primer episodio de esquizofrenia cubierto por GES 34: confirmación por psiquiatra en 20 días como máximo y tratamiento integral dentro de 24 horas desde la confirmación. Se notifica, se inicia un atípico (por ejemplo risperidona u olanzapina) y se deriva. La psicosis breve dura menos de un mes.

Pregunta de práctica

Hombre de 52 años con esquizofrenia, estable hace 8 años con flufenazina decanoato intramuscular cada 3 semanas. En su control de inyección en el CESFAM, la enfermera nota que mueve la lengua y los labios en forma repetitiva, como si masticara, y que tamborilea los dedos. El paciente no lo percibe. Sin síntomas psicóticos activos. **¿Cuál es la interpretación y la conducta más adecuada?**

A) Discinesia tardía; registrar con un examen neurológico dirigido, no agregar anticolinérgicos y derivar a psiquiatría para evaluar el cambio a un antipsicótico atípico o clozapina
B) Distonía aguda; administrar biperideno intramuscular y mantener igual
C) Recaída psicótica con estereotipias; aumentar la dosis de flufenazina
D) Acatisia; indicar propranolol
E) Síndrome neuroléptico maligno; hospitalizar en UCI

Respuesta A. Movimientos coreoatetósicos orolinguales y de dedos tras años de un neuroléptico típico de depósito son discinesia tardía. Por eso cada control de depósito incluye examen neurológico buscando extrapiramidalismo y discinesias. Los anticolinérgicos la empeoran; se deriva para reducir o cambiar el antipsicótico.

5.01.5.003 Intervención en crisis

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 17.3 Evaluación y Manejo del Riesgo Suicida: Factores de Riesgo e Indicación de Hospitalización

QUÉ HAY QUE SABER

- Intervención en crisis (primera ayuda psicológica): intervención breve y focalizada para restablecer el equilibrio tras un evento crítico (catástrofe, duelo súbito, asalto, intento suicida), aplicable por cualquier profesional de salud.
- Pasos: contacto empático y escucha activa sin forzar el relato, asegurar seguridad física y necesidades básicas (abrigo, alojamiento, comida), normalizar la reacción como esperable y entregar psicoeducación.
- En Chile se usa el modelo ABCDE: escucha Activa, reentrenamiento de la ventilación (Breathing), Categorización de necesidades, Derivación a redes y psicoEducación.
- Evaluar riesgo suicida y de daño a terceros, consumo de alcohol y personas vulnerables (niños, adultos mayores); activar redes de apoyo familiares e institucionales.
- No usar debriefing obligatorio ni benzodiacepinas preventivas (no previenen el TEPT y pueden empeorarlo).
- Acordar seguimiento cercano y derivar si los síntomas persisten más allá de semanas o hay riesgo.

PREGUNTAS (2)

Pregunta de práctica

Mujer de 38 años llega al SAPU 2 horas después de que su casa se incendiara por completo. Nadie resultó herido. Está llorando, temblorosa, dice que no sabe dónde dormirá esta noche con sus 2 hijos y repite que no puede pensar. No tiene antecedentes psiquiátricos ni ideas de muerte, está orientada y su examen físico es normal. **¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?**

A) Realizar intervención en crisis: escucha activa, contención, asegurar necesidades básicas y activar redes de apoyo, con seguimiento cercano
B) Indicar diazepam endovenoso y derivar a psiquiatría
C) Pedirle que relate en detalle el incendio para procesar el trauma (debriefing obligatorio)
D) Iniciar sertralina para prevenir el trastorno de estrés postraumático
E) Hospitalizar en psiquiatría por reacción aguda a estrés

Respuesta A. La intervención en crisis (primera ayuda psicológica) busca restablecer el equilibrio: escuchar sin forzar el relato, contener, cubrir necesidades básicas como seguridad y alojamiento, conectar con redes de apoyo y evaluar riesgo. El debriefing forzado y los fármacos preventivos no han demostrado beneficio y pueden empeorar la evolución.

Pregunta de práctica

Hombre de 45 años presenció hace 3 horas un accidente de tránsito en que murió su compañero de trabajo. Llega al CESFAM acompañado de su esposa: está inquieto, llora a ratos, dice sentirse aturdido y teme no poder dormir. Está orientado, sin consumo de alcohol, sin ideas de muerte ni síntomas psicóticos. **¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una adecuada intervención en crisis?**

A) Indicarle que olvide lo ocurrido y retome su trabajo al día siguiente
B) Realizar una sesión única obligatoria de relato detallado del accidente
C) Iniciar clonazepam por 3 meses para prevenir un trastorno de estrés postraumático
D) Derivarlo de urgencia a hospitalización psiquiátrica
E) Escucharlo sin presionarlo a relatar detalles, validar su reacción como esperable, reforzar el apoyo de su esposa y acordar un control cercano

Respuesta E. La intervención en crisis es breve y focalizada: contacto empático, escucha sin forzar el relato, normalizar la reacción, evaluar riesgo, cubrir necesidades inmediatas, activar la red de apoyo y asegurar seguimiento. Las benzodiacepinas prolongadas y el debriefing obligatorio no previenen el estrés postraumático y pueden empeorarlo.

5.01.5.004 Mini mental test, MoCA test

Nivel: **Realizar**

Dónde se enseña: Tema 10.14 Enfermedad de Alzheimer y Deterioro Cognitivo Leve

QUÉ HAY QUE SABER

- MMSE (Minimental): 30 puntos; evalúa orientación, registro, atención y cálculo, memoria diferida, lenguaje y praxia constructiva; corte habitual <24, ajustado por escolaridad; poco sensible para deterioro cognitivo leve.
- En el EMPAM chileno se usa el Minimental abreviado: <13 puntos es alterado y se complementa con el cuestionario de actividades funcionales de Pfeffer al informante (≥6 indica compromiso funcional).
- MoCA: 30 puntos, corte <26 (sumar 1 punto si la escolaridad es ≤12 años); más sensible para deterioro cognitivo leve y función ejecutiva, pero penaliza la baja escolaridad.
- Aplicación: paciente vigil, sin delirium, con lentes y audífonos, en ambiente tranquilo; el test del reloj es complementario y se altera precozmente en el Alzheimer.
- Un test alterado no diagnostica demencia: se requiere compromiso funcional, evaluación clínica y estudio de causas reversibles (TSH, B12, VDRL, neuroimagen); un test normal con quejas corroboradas obliga a aplicar MoCA o seguir controlando.

PREGUNTAS (1)

Pregunta de práctica

Hombre de 70 años, profesor universitario jubilado, consulta por quejas de memoria de 1 año, corroboradas por su esposa. Es completamente autónomo. Su Minimental (MMSE) es de 29/30. **¿Cuál es el siguiente paso más adecuado para evaluar un posible deterioro cognitivo leve?**

A) Solicitar PET cerebral
B) Repetir el Minimental en una semana
C) Tranquilizarlo, ya que el Minimental es normal
D) Solicitar electroencefalograma
E) Aplicar el test MoCA

Respuesta E. El Minimental tiene efecto techo y baja sensibilidad para deterioro cognitivo leve, sobre todo en personas de alta escolaridad. El MoCA evalúa mejor funciones ejecutivas y atención, y es más sensible para detectarlo (punto de corte habitual 26, con un punto adicional si la escolaridad es 12 años o menos). Ante quejas corroboradas no basta con un MMSE normal.